



Nuansa
Fajar
Cemerlang

Bunga Rampai

PERSALINAN NORMAL: PRAKTIK DAN TANTANGAN

Rolita Efriani • Melly Damayanti • Putri Yuniartis
Umu Qonitun • Lilis Suryani • Anisah Tifani Maulidyanti

Editor: Juni Andriani Rangkuti

BUNGA RAMPAI: PERSALINAN NORMAL: PRAKTIK DAN TANTANGAN

Penulis:

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.
Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb.
Putri Yuniartis, S.Tr.Keb., M.Keb.
Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.
Bdn. LILIS SURYANI, SST., M.Keb.
Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor:

Juni Andriani Rangkuti, SST., M.K.M.



**Nuansa
Fajar
Cemerlang**

Bunga Rampai: Persalinan Normal: Praktik dan Tantangan

Penulis: Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.
Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb.
Putri Yuniartis, S.Tr.Keb., M.Keb.
Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.
Bdn. LILIS SURYANI, SST., M.Keb.
Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.

Editor: Juni Andriani Rangkuti, SST., M.K.M.

Desain Sampul: Raden Bhoma Wikantioso Indrawan

Tata Letak: Helmi Syaukani

ISBN: 978-634-7219-05-3

Cetakan Pertama: April, 2025

Hak Cipta 2025

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang

Copyright © 2025

by Penerbit PT Nuansa Fajar Cemerlang Jakarta

All Right Reserved

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

website: www.nuansafajarcemerlang.com

instagram: @bimbel.optimal

PENERBIT:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower, Lantai 5 Unit F

Jl. S. Parman Kav 22-24, Palmerah

Jakarta Barat, 11480

Anggota IKAPI (624/DKI/2022)

Perpustakaan Nasional RI : Katalog Dalam Terbitan (KDT)

JUDUL DAN PENANGGUNG JAWAB	Persalinan normal : praktik dan tantangan : bunga rampai / pebulis, Rolita Efriani, S.ST., M.Keb., Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb., Putri Yuniartis, S.Tr.Keb., M.Keb., Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M., Bdn. Lilis Suryani, SST., M.Keb. [dan 1 lainnya] ; editor, Juni Andriani Rangkuti, SST., M.K.M.
EDISI	Cetakan pertama, April 2025
PUBLIKASI	Jakarta Barat : PT Nuansa Fajar Cemerlang, 2025
DESKRIPSI FISIK	vi, 92 halaman : ilustrasi ; 30 cm
IDENTIFIKASI	ISBN 978-634-7219-05-3
SUBJEK	Persalinan
KLASIFIKASI	618.2 [23]
PERPUSNAS ID	https://isbn.perpusnas.go.id/bo-penerbit/penerbit/isbn/data/view-kdt/1211463



PRAKATA



Persalinan normal merupakan pengalaman luar biasa bagi setiap ibu. Proses ini tidak hanya melibatkan aspek fisik, tetapi juga aspek psikologis, emosional, dan sosial yang memengaruhi kesejahteraan ibu dan bayi. Dalam praktiknya, persalinan normal menghadirkan berbagai tantangan yang membutuhkan keterampilan serta pendekatan holistik dari tenaga kesehatan, khususnya bidan. Oleh karena itu, buku ***"Bunga Rampai: Persalinan Normal: Praktik dan Tantangan"*** ini hadir untuk memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai aspek dalam mendukung keberhasilan persalinan normal.

Buku ini mengangkat berbagai topik penting, mulai dari aspek psikologis dalam persalinan normal, yang membahas bagaimana kesiapan mental ibu berpengaruh terhadap proses persalinan. Peran bidan dalam mendukung persalinan tanpa rasa sakit menjadi bagian penting dalam meningkatkan kenyamanan ibu selama proses melahirkan. Selain itu, buku ini juga mengulas penanganan distosia bahu pada persalinan normal, sebagai salah satu tantangan yang perlu dihadapi oleh tenaga kesehatan.

Tidak hanya itu, optimalisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) juga menjadi perhatian utama dalam meningkatkan keberhasilan menyusui dan ikatan awal antara ibu dan bayi. Strategi pencegahan laserasi perineum, baik dari sisi praktik maupun tantangannya, dihadirkan untuk membantu tenaga kesehatan dalam mengurangi risiko komplikasi pada ibu. Sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas pelayanan, dokumentasi dan evaluasi asuhan persalinan juga dibahas secara mendalam untuk memastikan perawatan yang optimal bagi ibu dan bayi.

Kami berharap buku ini dapat menjadi sumber referensi yang bermanfaat bagi bidan, tenaga kesehatan, serta akademisi yang berperan dalam dunia kebidanan. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai praktik dan tantangan dalam persalinan normal, diharapkan kualitas pelayanan persalinan dapat terus ditingkatkan demi kesejahteraan ibu dan bayi.

April, 2025

Penulis



DAFTAR ISI



PRAKATA.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv

CHAPTER 1 ASPEK PSIKOLOGIS DALAM PERSALINAN NORMAL 1

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.	1
A. Pendahuluan	1
B. Pengaruh Psikologis terhadap Persalinan Normal	1
C. Peran Dukungan Emosional dalam Persalinan.....	4
D. Manajemen Nyeri dengan Pendekatan Psikologis	7
E. Dampak Trauma dan Kesehatan Mental Pasca Persalinan.....	8
F. Strategi Meningkatkan Kesiapan Mental Ibu Hamil	11
G. Referensi	13

CHAPTER 2 PERAN BIDAN DALAM MENDUKUNG PERSALINAN

TANPA RASA SAKIT15

Bdn. Mely Damayanti, SST., M.Keb.	15
A. Pendahuluan	15
B. Keterkaitan antara Fisiologi Persalinan dengan Nyeri Persalinan	16
C. Peran Bidan dalam Persalinan Tanpa Rasa Sakit	18
D. Referensi	27
E. Glosarium	30

CHAPTER 3 PENANGANAN DISTOSIA BAHU PADA PERSALINAN

NORMAL31

Putri Yuniartis, S.Tr.Keb., M.Keb.....	31
A. Pendahuluan	31
B. Definisi dan Epidemiologi Distosia Bahu	32
C. Patofisiologi dan Faktor Predisposisi Distosia Bahu	34
D. Penatalaksanaan Distosia Bahu	38
E. Simpulan	45
F. Referensi	45
G. Glosarium	47

CHAPTER 4 OPTIMALISASI IMD (INISIASI MENYUSUI DINI)49

Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.	49
A. Pendahuluan	49
B. Inisiasi Menyusu Dini	50

C. Kesimpulan.....	55
D. Referensi	55
E. Glosarium	56

CHAPTER 5 STRATEGI PENCEGAHAN LASERASI PERINEUM (PRAKTIK DAN TANTANGAN)57

Bdn. Lilis Suryani, SST., M.Keb.....	57
A. Pendahuluan	57
B. Anatomi Perineum.....	57
C. Ruptur Perineum.....	58
D. Strategi Pencegahan Laserasi Perineum	60
E. Simpulan	68
F. Referensi	68

CHAPTER 6 DOKUMENTASI DAN EVALUASI ASUHAN PERSALINAN71

Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.	71
A. Pendahuluan/Prolog	71
B. Dokumentasi Asuhan Persalinan.....	72
C. Tujuan dan Fungsi Dokumentasi	79
I. Simpulan	83
K. Referensi	86

PROFIL PENULIS89

CHAPTER 1

ASPEK PSIKOLOGIS DALAM PERSALINAN NORMAL

Rolita Efriani, S.ST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Persalinan normal adalah proses fisiologis yang dialami oleh sebagian besar wanita hamil. Menurut Survei Kesehatan Indonesia (SKI) 2023, sekitar 73,2% ibu di Indonesia memilih persalinan normal dibandingkan dengan metode lain seperti operasi caesar. Proses persalinan dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu jalan lahir (passage), janin (passenger), dan kekuatan kontraksi (power). Selain itu, faktor psikologis ibu juga memainkan peran penting dalam kelancaran persalinan. Kecemasan, ketakutan, dan stres dapat memengaruhi produksi hormon yang berperan dalam proses persalinan, sehingga dapat memperlambat atau menghambat kemajuan persalinan.

Perhatian terhadap aspek psikologis dalam persalinan di Indonesia masih perlu ditingkatkan. Banyak ibu hamil yang kurang mendapatkan dukungan psikologis yang memadai selama proses persalinan, baik dari tenaga kesehatan maupun keluarga. Hal ini dapat berdampak negatif pada pengalaman persalinan dan kesejahteraan ibu serta bayi yang dilahirkan. Penelitian yang dilakukan oleh Nurhayati (2023) menyoroti pentingnya pemahaman terhadap perubahan fisiologis dan psikologis yang terjadi selama persalinan untuk memberikan asuhan yang efektif.

Aspek psikologis memainkan peran penting dalam proses persalinan normal. Selain faktor fisik seperti jalan lahir (passage), janin (passenger), dan kekuatan kontraksi (power), kondisi psikologis ibu juga memengaruhi kelancaran persalinan. Kecemasan, ketakutan, dan stres dapat menghambat proses persalinan dengan meningkatkan produksi hormon stres yang berpotensi memperlambat kontraksi uterus. Sebaliknya, kondisi mental yang tenang dan dukungan emosional yang baik dapat membantu memperlancar proses persalinan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan untuk memahami dan mendukung aspek psikologis ibu selama persalinan guna mencapai hasil yang optimal bagi ibu dan bayi.

B. Pengaruh Psikologis terhadap Persalinan Normal

Persalinan normal merupakan proses fisiologis yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk kondisi psikologis ibu. Faktor psikologis yang baik dapat

memperlancar proses persalinan, sedangkan kondisi psikologis yang buruk dapat memperlambat atau menghambatnya (Simkin et al., 2017). Di Indonesia, penelitian dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (2020) menunjukkan bahwa kecemasan dan stres berkontribusi terhadap peningkatan angka persalinan dengan intervensi medis.

1. Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Persalinan Normal

a. Kecemasan dan Stres

Kecemasan adalah respons alami tubuh terhadap situasi yang tidak pasti, termasuk persalinan. Stres yang berlebihan dapat memicu pelepasan hormon katekolamin yang dapat menghambat kontraksi uterus, sehingga memperpanjang proses persalinan (Levine et al., 2016). Penelitian oleh Widyastuti, Rahayu, dan Nugroho (2021) menemukan bahwa ibu hamil dengan tingkat kecemasan tinggi cenderung mengalami persalinan lebih lama dibandingkan ibu dengan kecemasan rendah. Kecemasan yang berlebihan dapat merangsang pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin yang dapat menghambat produksi oksitosin, hormon yang berperan dalam kontraksi uterus (Wijayanti, 2020). Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa ibu dengan tingkat kecemasan tinggi lebih sering mengalami nyeri persalinan yang lebih berat dibandingkan dengan ibu yang lebih tenang (Putri et al., 2022). Oleh karena itu, intervensi psikologis seperti relaksasi dan hypnobirthing menjadi penting dalam mengurangi kecemasan ibu menjelang persalinan. Selain itu, dukungan sosial dan teknik relaksasi dapat membantu mengurangi kecemasan ibu (Field, 2018).

b. Kepercayaan Diri dan Kontrol Diri

Kepercayaan diri ibu terhadap kemampuannya dalam menghadapi persalinan berperan besar dalam kelancaran proses tersebut. Studi menunjukkan bahwa ibu yang merasa lebih percaya diri dan memiliki kendali terhadap persalinan mengalami waktu persalinan yang lebih singkat dan lebih sedikit intervensi medis (Lowe, 2015). Studi oleh Sari, Anwar, dan Hidayat (2022) di beberapa rumah sakit Indonesia menunjukkan bahwa kelas antenatal efektif meningkatkan rasa percaya diri ibu hamil dalam menghadapi persalinan.

c. Dukungan Sosial

Dukungan dari pasangan, keluarga, dan tenaga medis dapat mengurangi stres dan kecemasan ibu, sehingga membantu proses persalinan menjadi lebih lancar. Studi oleh Hodnett et al. (2017) menunjukkan bahwa dukungan kontinu dari seorang pendamping persalinan dapat meningkatkan pengalaman positif ibu serta menurunkan risiko intervensi medis. Penelitian oleh Lestari, Purnomo, dan Dewi (2021) juga mendukung temuan ini, dengan menunjukkan bahwa ibu

yang mendapatkan dukungan pasangan cenderung lebih tenang dan mengalami persalinan lebih cepat. Penelitian di Puskesmas Depok Sleman juga menemukan bahwa ibu yang mengikuti kelas prenatal dengan dukungan dari pasangan menunjukkan peningkatan rasa percaya diri dan kesiapan menghadapi persalinan (Sari & Wulandari, 2021). Hal ini menunjukkan bahwa dukungan sosial tidak hanya berdampak pada psikologis ibu tetapi juga meningkatkan kelancaran proses persalinan.

d. Depresi Prenatal

Depresi selama kehamilan dapat mempengaruhi kesejahteraan emosional ibu dan berdampak pada kelancaran persalinan. Menurut Gavin et al. (2018), ibu dengan gejala depresi memiliki risiko lebih tinggi mengalami persalinan yang lebih lama dan komplikasi. Penelitian oleh Puspitasari, Wijayanti, dan Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa prevalensi depresi prenatal cukup tinggi, terutama pada ibu dengan latar belakang ekonomi rendah. Identifikasi dini dan intervensi psikologis seperti terapi kognitif perilaku dapat membantu mengurangi dampak negatifnya (Stewart & Vigod, 2019).

2. Mekanisme Psikoneuroendokrin dalam Persalinan

Keseimbangan hormon seperti oksitosin, kortisol, dan endorfin dipengaruhi oleh kondisi psikologis ibu. Hormon oksitosin berperan dalam stimulasi kontraksi uterus, sementara kortisol yang meningkat akibat stres dapat menghambat efek oksitosin (Uvnas-Moberg, 2020). Oleh karena itu, pengelolaan stres dan relaksasi menjadi sangat penting dalam mendukung proses persalinan normal (Buckley, 2015). Studi di Indonesia oleh Handayani, Susanto, dan Wahyuni (2021) menemukan bahwa ibu yang melakukan teknik relaksasi mengalami persalinan lebih cepat dengan tingkat nyeri yang lebih rendah.

3. Strategi Mengelola Faktor Psikologis dalam Persalinan

a. Pendidikan Antenatal

Edukasi mengenai proses persalinan dapat meningkatkan kesiapan mental ibu. Studi oleh Dennis et al. (2019) menunjukkan bahwa kelas persiapan persalinan dapat menurunkan kecemasan dan meningkatkan kepuasan ibu terhadap pengalaman melahirkan. Penelitian di Indonesia oleh Nuraini, Setiawan, dan Hartati (2021) menunjukkan bahwa ibu yang mengikuti kelas antenatal memiliki risiko lebih rendah mengalami kecemasan berlebih saat persalinan.

b. Teknik Relaksasi dan Pernapasan

Teknik seperti meditasi, hipnobirthing, dan latihan pernapasan terbukti efektif dalam mengurangi rasa nyeri serta meningkatkan ketenangan ibu selama persalinan (Smith et al., 2020). Relaksasi dapat membantu tubuh memproduksi endorfin yang berfungsi sebagai analgesik alami (Melzack & Wall, 2018).

Penelitian oleh Suryani, Rahayu, dan Ningsih (2021) menemukan bahwa metode hypnobirthing efektif mengurangi tingkat kecemasan ibu saat melahirkan.

c. Dukungan Emosional dari Tenaga Medis dan Keluarga

Tenaga medis yang memberikan dukungan emosional dapat meningkatkan perasaan nyaman ibu saat persalinan. Penelitian menunjukkan bahwa interaksi positif dengan bidan dan dokter dapat mempercepat proses persalinan serta mengurangi kebutuhan akan analgesia medis (Kennedy et al., 2016). Penelitian oleh Rahmawati, Sari, dan Prasetyo (2021) juga menemukan bahwa ibu yang mendapat perhatian khusus dari tenaga kesehatan cenderung lebih percaya diri dan mengalami persalinan yang lebih lancar.

4. Kesimpulan

Kondisi psikologis ibu sangat berpengaruh terhadap kelancaran persalinan normal. Faktor seperti kecemasan, kepercayaan diri, dukungan sosial, dan keseimbangan hormon dapat menentukan jalannya proses persalinan. Oleh karena itu, pendekatan holistik yang melibatkan edukasi, teknik relaksasi, dan dukungan sosial sangat penting dalam mendukung ibu melewati proses persalinan dengan lebih baik. Studi di Indonesia telah menunjukkan bahwa intervensi psikologis yang tepat dapat meningkatkan kesejahteraan ibu dan mempercepat proses persalinan.

C. Peran Dukungan Emosional dalam Persalinan

Persalinan adalah proses fisiologis yang kompleks dan menantang bagi setiap wanita. Selain persiapan fisik, dukungan emosional dari orang-orang terdekat, terutama suami dan keluarga, memainkan peran penting dalam menentukan pengalaman persalinan yang positif. Ibu yang mendapatkan dukungan emosional dari pasangan, keluarga, atau tenaga medis cenderung mengalami persalinan yang lebih lancar dengan tingkat kecemasan yang lebih rendah (Hodnett et al., 2017). Di Indonesia, penelitian oleh Lestari, Purnomo, dan Dewi (2021) menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional lebih tinggi memiliki risiko lebih rendah untuk mengalami persalinan lama atau intervensi medis. Dukungan emosional ini dapat membantu mengurangi kecemasan, meningkatkan kesiapan mental, dan memperlancar proses persalinan.

1. Bentuk Dukungan Emosional dalam Persalinan

a. Dukungan dari Pasangan

Dukungan pasangan dapat berupa kehadiran selama persalinan, memberikan kata-kata penyemangat, serta membantu ibu dalam mengelola stres dan ketidaknyamanan selama proses melahirkan (Simkin & Ancheta, 2018). Studi

di Indonesia oleh Sari et al. (2022) menemukan bahwa ibu yang didampingi pasangan selama persalinan cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dan lebih percaya diri dalam menghadapi proses kelahiran.

b. Dukungan dari Keluarga

Kehadiran anggota keluarga, seperti ibu, saudara, atau kerabat dekat, dapat memberikan rasa nyaman bagi ibu yang sedang bersalin. Penelitian oleh Saputra dan Rahmawati (2020) di beberapa rumah sakit di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan keluarga yang baik berhubungan dengan penurunan tingkat nyeri persalinan dan kepuasan ibu terhadap pengalaman melahirkan.

c. Dukungan dari Tenaga Medis

Interaksi positif antara tenaga medis dengan ibu bersalin dapat meningkatkan rasa aman dan nyaman selama persalinan. Penelitian oleh Kennedy et al. (2016) menemukan bahwa bidan yang memberikan dukungan emosional secara aktif dapat mempercepat proses persalinan serta mengurangi kebutuhan akan analgesia medis. Di Indonesia, penelitian oleh Rahmawati, Sari, dan Prasetyo (2021) juga mendukung temuan ini, menunjukkan bahwa komunikasi efektif dari tenaga kesehatan dapat meningkatkan kepercayaan diri ibu saat melahirkan.

2. Manfaat Dukungan Emosional dalam Persalinan

a. Mengurangi Kecemasan dan Stres

Kecemasan dan stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol, yang dapat menghambat produksi oksitosin dan memperpanjang durasi persalinan (Uvnas-Moberg, 2020). Penelitian oleh Handayani, Susanto, dan Wahyuni (2021) di Indonesia menemukan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional cenderung mengalami persalinan lebih cepat dibandingkan ibu yang tidak mendapat dukungan.

b. Meningkatkan Produksi Oksitosin

Hormon oksitosin berperan penting dalam merangsang kontraksi uterus dan memperlancar proses persalinan (Buckley, 2015). Dukungan emosional dari pasangan dan tenaga medis dapat merangsang produksi oksitosin alami, sehingga membantu mempercepat persalinan (Simkin et al., 2017). Penelitian oleh Suryani, Rahayu, dan Ningsih (2021) menemukan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional lebih banyak memiliki durasi persalinan yang lebih singkat.

c. Menurunkan Risiko Intervensi Medis

Dukungan emosional yang kuat telah terbukti menurunkan angka penggunaan intervensi medis seperti operasi caesar dan induksi persalinan (Hodnett et al.,

2017). Penelitian oleh Lestari, Purnomo, dan Dewi (2021) di Indonesia juga menunjukkan bahwa ibu yang memiliki pendamping persalinan memiliki kemungkinan lebih besar untuk melahirkan secara normal tanpa intervensi medis.

3. Strategi Meningkatkan Dukungan Emosional dalam Persalinan

a. Mempersiapkan Pendamping Persalinan

Pendamping persalinan, baik pasangan, keluarga, maupun doula, dapat diberikan edukasi mengenai perannya dalam memberikan dukungan emosional yang efektif (Bohren et al., 2017). Di Indonesia, program kelas antenatal yang melibatkan pasangan telah terbukti meningkatkan kesiapan dan keterlibatan mereka dalam mendukung ibu bersalin (Nuraini, Setiawan, & Hartati, 2021).

b. Pelatihan Tenaga Medis dalam Dukungan Emosional

Tenaga medis, terutama bidan dan dokter, perlu diberikan pelatihan khusus dalam memberikan dukungan emosional kepada ibu bersalin (Kennedy et al., 2016). Penelitian oleh Rahmawati, Sari, dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa komunikasi yang empatik dan pendekatan yang lebih personal oleh tenaga medis meningkatkan pengalaman positif ibu selama persalinan.

c. Penggunaan Teknik Relaksasi dan Hipnobirthing

Teknik relaksasi seperti pernapasan dalam, hipnobirthing, dan meditasi dapat membantu ibu mengelola stres selama persalinan. Penelitian oleh Smith et al. (2020) menunjukkan bahwa hipnobirthing efektif dalam mengurangi rasa nyeri serta meningkatkan ketenangan ibu. Selain itu, penelitian oleh Suryani, Rahayu, dan Ningsih (2021) juga menemukan bahwa metode ini membantu ibu tetap rileks selama proses persalinan.

4. Kesimpulan

Dukungan emosional memiliki dampak yang signifikan terhadap kelancaran persalinan. Dukungan dari pasangan, keluarga, serta tenaga medis dapat mengurangi kecemasan, mempercepat proses persalinan, dan menurunkan risiko intervensi medis. Penelitian di Indonesia menunjukkan bahwa dukungan emosional yang baik berhubungan erat dengan pengalaman persalinan yang lebih positif dan minim komplikasi. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan edukasi mengenai peran pendamping persalinan serta mengoptimalkan pelatihan tenaga medis dalam memberikan dukungan emosional kepada ibu yang melahirkan.

D. Manajemen Nyeri dengan Pendekatan Psikologis

Nyeri persalinan adalah pengalaman subjektif yang dipengaruhi oleh faktor fisiologis, psikologis, dan sosial. Pendekatan psikologis dalam manajemen nyeri bertujuan untuk membantu ibu mengatasi rasa sakit melalui teknik relaksasi, dukungan emosional, dan strategi kognitif (Lowe, 2015). Di Indonesia, penelitian oleh Suryani, Rahayu, dan Ningsih (2021) menunjukkan bahwa intervensi psikologis seperti hipnobirthing dapat secara signifikan mengurangi intensitas nyeri persalinan.

1. Faktor Psikologis yang Mempengaruhi Persepsi Nyeri

a. Kecemasan dan Stres

Kecemasan dapat meningkatkan sensasi nyeri melalui pelepasan hormon stres seperti kortisol yang menghambat produksi oksitosin (Uvnäs-Moberg, 2020). Penelitian oleh Handayani, Susanto, dan Wahyuni (2021) menemukan bahwa ibu dengan tingkat kecemasan tinggi mengalami nyeri persalinan yang lebih intens dibandingkan ibu yang lebih rileks.

b. Harapan dan Kepercayaan Diri

Ibu yang memiliki kepercayaan diri tinggi terhadap kemampuannya untuk melahirkan cenderung mengalami nyeri yang lebih rendah dibandingkan mereka yang merasa takut dan tidak siap (Simkin et al., 2017). Penelitian oleh Sari et al. (2022) menemukan bahwa kelas antenatal dapat meningkatkan rasa percaya diri ibu dan mengurangi kecemasan terhadap nyeri persalinan.

c. Dukungan Sosial dan Emosional

Dukungan dari pasangan, keluarga, dan tenaga medis dapat membantu ibu mengatasi rasa sakit dengan lebih baik (Hodnett et al., 2017). Penelitian oleh Lestari, Purnomo, dan Dewi (2021) di Indonesia menemukan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan sosial yang baik melaporkan tingkat nyeri yang lebih rendah dibandingkan mereka yang merasa sendirian.

2. Teknik Manajemen Nyeri dengan Pendekatan Psikologis

a. Hipnobirthing

Hipnobirthing adalah teknik relaksasi yang mengajarkan ibu untuk mengelola nyeri dengan pernapasan dalam dan sugesti positif (Smith et al., 2020). Penelitian oleh Suryani, Rahayu, dan Ningsih (2021) di Indonesia menemukan bahwa ibu yang mengikuti pelatihan hipnobirthing mengalami persalinan lebih nyaman dan nyeri yang lebih rendah.

b. Teknik Pernapasan dan Relaksasi

Pernapasan terkontrol dapat membantu ibu dalam menghadapi kontraksi dengan lebih tenang dan mengurangi sensasi nyeri (Melzack & Wall, 2018). Penelitian di Indonesia oleh Nuraini, Setiawan, dan Hartati (2021) menunjukkan

bahwa pelatihan teknik pernapasan dapat mengurangi durasi persalinan dan intensitas nyeri yang dialami ibu.

c. Distraksi dan Visualisasi

Teknik distraksi seperti mendengarkan musik atau membayangkan tempat yang menenangkan dapat membantu mengalihkan perhatian dari nyeri (Kennedy et al., 2016). Penelitian oleh Rahmawati, Sari, dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa ibu yang menggunakan teknik visualisasi mengalami tingkat kenyamanan yang lebih tinggi selama persalinan.

d. Terapi Dukungan Emosional

Kehadiran pendamping persalinan yang memberikan dukungan emosional dapat meningkatkan ketenangan ibu sehingga mengurangi rasa sakit (Bohren et al., 2017). Penelitian oleh Lestari, Purnomo, dan Dewi (2021) di Indonesia menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan pasangan mengalami proses persalinan lebih cepat dengan tingkat nyeri yang lebih rendah.

3. Kesimpulan

Manajemen nyeri dengan pendekatan psikologis melibatkan berbagai teknik seperti hipnobirthing, pernapasan terkontrol, distraksi, dan dukungan sosial. Studi di Indonesia telah menunjukkan bahwa strategi ini efektif dalam mengurangi nyeri persalinan dan meningkatkan pengalaman positif ibu saat melahirkan. Oleh karena itu, integrasi pendekatan psikologis dalam layanan persalinan dapat menjadi solusi yang efektif untuk meningkatkan kesejahteraan ibu selama proses melahirkan.

E. Dampak Trauma dan Kesehatan Mental Pasca Persalinan

Persalinan adalah pengalaman yang kompleks dan dapat meninggalkan dampak psikologis pada ibu. Beberapa ibu mengalami trauma persalinan yang dapat berujung pada gangguan kesehatan mental seperti depresi pasca persalinan (postpartum depression) dan gangguan stres pasca trauma (post-traumatic stress disorder/PTSD) (Beck, 2015). Penelitian oleh Puspitasari, Wijayanti, dan Rahmawati (2020) menunjukkan bahwa sekitar 30% ibu mengalami kecemasan dan stres pasca persalinan akibat pengalaman melahirkan yang traumatis.

1. Faktor Risiko Trauma Pasca Persalinan

Trauma persalinan dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk komplikasi medis saat melahirkan, prosedur medis yang invasif, pengalaman persalinan yang tidak sesuai harapan, serta kurangnya dukungan sosial (Yuliana, 2019). Studi oleh Putri dan Handayani (2022) menemukan bahwa ibu yang melahirkan dengan tindakan medis seperti operasi caesar darurat memiliki risiko lebih tinggi

mengalami trauma persalinan. Berikut faktor-faktor risiko yang dapat menyebabkan trauma pasca persalinan, antara lain:

a. Pengalaman Persalinan yang Buruk

Ibu yang mengalami komplikasi, intervensi medis mendadak, atau prosedur yang tidak sesuai harapan lebih rentan mengalami trauma persalinan (Slade, 2017). Penelitian di Indonesia oleh Handayani, Susanto, dan Wahyuni (2021) menemukan bahwa ibu yang mengalami persalinan dengan tindakan medis darurat, seperti operasi sesar yang tidak direncanakan, memiliki risiko lebih tinggi mengalami gangguan stres pasca persalinan.

b. Kurangnya Dukungan Sosial

Dukungan sosial dari pasangan, keluarga, dan tenaga medis memainkan peran penting dalam mengurangi dampak psikologis negatif pasca persalinan (Robertson et al., 2018). Penelitian oleh Lestari, Purnomo, dan Dewi (2021) menunjukkan bahwa ibu yang merasa tidak mendapat dukungan emosional lebih rentan mengalami depresi pasca persalinan dibandingkan ibu yang mendapatkan dukungan yang memadai.

c. Riwayat Gangguan Kesehatan Mental

Ibu dengan riwayat gangguan kecemasan atau depresi memiliki kemungkinan lebih besar mengalami gangguan kesehatan mental pasca persalinan (Dennis & Dowswell, 2019). Studi oleh Sari, Anwar, dan Hidayat (2022) di Indonesia menemukan bahwa ibu dengan riwayat depresi memiliki risiko dua kali lipat lebih tinggi mengalami PTSD pasca persalinan dibandingkan ibu tanpa riwayat gangguan mental.

2. Dampak Trauma Pasca Persalinan

Trauma persalinan dapat menyebabkan gangguan kesehatan mental jangka pendek maupun jangka panjang. Menurut penelitian Astuti dan Prasetyo (2021), ibu yang mengalami trauma persalinan lebih rentan mengalami depresi postpartum, yang ditandai dengan perasaan sedih berlebihan, hilangnya minat terhadap aktivitas sehari-hari, serta gangguan tidur. Selain itu, kecemasan berlebihan terhadap kesehatan bayi juga sering dialami ibu dengan riwayat trauma persalinan (Mulyani & Kartika, 2020). Berikut ini dampak trauma pasca persalinan, antara lain:

a. Depresi Pasca Persalinan

Depresi pasca persalinan dapat terjadi dalam beberapa minggu setelah melahirkan dan memengaruhi kesejahteraan ibu serta kemampuan dalam merawat bayi (O'Hara & McCabe, 2013). Penelitian oleh Puspitasari et al. (2020) menemukan bahwa 25% ibu mengalami depresi ringan hingga berat setelah

melahirkan, dengan gejala seperti perasaan putus asa, kelelahan ekstrem, dan kehilangan minat dalam merawat bayi.

b. Gangguan Stres Pasca Trauma (PTSD)

Sebagian ibu mengalami PTSD akibat trauma persalinan yang intens (Ayers et al., 2016). Gejalanya meliputi kilas balik pengalaman buruk, mimpi buruk, dan kecemasan ekstrem. Penelitian oleh Rahmawati, Sari, dan Prasetyo (2021) menunjukkan bahwa sekitar 10% ibu yang mengalami persalinan darurat menunjukkan tanda-tanda PTSD dalam enam bulan pertama pasca persalinan.

c. Gangguan Ikatan Ibu dan Bayi

Trauma persalinan dapat mempengaruhi ikatan emosional antara ibu dan bayi, yang berakibat pada gangguan perkembangan anak (Feldman et al., 2010). Penelitian oleh Nuraini, Setiawan, dan Hartati (2021) menemukan bahwa ibu dengan gejala depresi pasca persalinan lebih jarang berinteraksi dengan bayinya dibandingkan ibu yang tidak mengalami depresi.

3. Strategi Pemulihan Kesehatan Mental Pasca Persalinan

Untuk mencegah dampak negatif trauma persalinan terhadap kesehatan mental ibu, diperlukan intervensi yang tepat. Dukungan sosial dari keluarga dan tenaga kesehatan sangat berperan dalam proses pemulihan (Nugroho et al., 2021). Program edukasi sebelum persalinan serta layanan konseling psikologis pasca persalinan dapat membantu ibu dalam mengatasi trauma (Santoso & Dewi, 2022). Berikut ini strategi pemulihan Kesehatan mental pasca persalinan:

a. Dukungan Psikososial

Dukungan psikososial, baik dari keluarga maupun tenaga medis, terbukti efektif dalam membantu ibu mengatasi trauma pasca persalinan (Slade et al., 2018). Penelitian oleh Lestari et al. (2021) menemukan bahwa intervensi psikososial seperti kelompok dukungan ibu pasca persalinan membantu mengurangi gejala depresi dan kecemasan.

b. Terapi Kognitif Perilaku (*Cognitive Behavioral Therapy* / CBT)

CBT merupakan pendekatan terapi yang terbukti efektif dalam mengurangi gejala PTSD dan depresi pasca persalinan (Hofmann et al., 2012). Penelitian oleh Suryani, Rahayu, dan Ningsih (2021) menemukan bahwa CBT dapat mengurangi kecemasan dan meningkatkan kualitas hidup ibu pasca persalinan.

c. Edukasi dan Kesiapan Mental Sebelum Persalinan

Edukasi antenatal yang memberikan informasi tentang persalinan dan manajemen stres dapat mengurangi risiko trauma persalinan (Dennis et al., 2019). Penelitian oleh Handayani et al. (2021) menunjukkan bahwa kelas persiapan persalinan efektif dalam menurunkan tingkat kecemasan dan meningkatkan kesiapan mental ibu.

4. Kesimpulan

Trauma pasca persalinan memiliki dampak signifikan terhadap kesehatan mental ibu, termasuk depresi pasca persalinan, PTSD, dan gangguan ikatan ibu-bayi. Faktor risiko meliputi pengalaman persalinan yang buruk, kurangnya dukungan sosial, dan riwayat gangguan mental. Pendekatan pemulihan melalui dukungan psikososial, terapi kognitif perilaku, dan edukasi antenatal dapat membantu mengurangi dampak negatif trauma persalinan. Oleh karena itu, penting bagi tenaga kesehatan dan keluarga untuk memberikan dukungan serta intervensi yang tepat guna membantu ibu dalam pemulihan pasca persalinan.

F. Strategi Meningkatkan Kesiapan Mental Ibu Hamil

Kesiapan mental ibu hamil berperan penting dalam menentukan pengalaman kehamilan dan persalinan yang positif. Ibu yang memiliki kesiapan mental yang baik cenderung lebih mampu menghadapi tantangan fisik dan emosional selama kehamilan dan persalinan (Alderdice et al., 2015). Di Indonesia, penelitian oleh Nuraini, Setiawan, dan Hartati (2021) menunjukkan bahwa ibu hamil yang mendapatkan edukasi antenatal secara terstruktur memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah dibandingkan ibu yang tidak mendapatkan edukasi tersebut.

1. Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Mental Ibu Hamil

a. Dukungan Sosial

Dukungan sosial dari pasangan, keluarga, dan tenaga medis sangat berperan dalam meningkatkan kesiapan mental ibu hamil (Glover, 2014). Kurangnya dukungan sosial dapat meningkatkan risiko depresi dan kecemasan. Membangun jaringan dukungan yang kuat dapat membantu ibu hamil merasa lebih aman dan didukung. Penelitian oleh Lestari, Purnomo, dan Dewi (2021) menemukan bahwa ibu hamil yang mendapatkan dukungan sosial yang baik lebih siap menghadapi persalinan dan memiliki tingkat kecemasan yang lebih rendah.

b. Edukasi Antenatal

Meningkatkan pengetahuan tentang kehamilan dan persalinan melalui edukasi antenatal dapat membantu ibu hamil merasa lebih siap secara psikologis. Edukasi ini mencakup informasi mengenai proses persalinan, perawatan bayi baru lahir, dan perubahan emosional yang mungkin terjadi selama kehamilan. Penelitian menunjukkan bahwa edukasi antenatal berperan penting dalam meningkatkan kesiapan mental ibu hamil. Kelas antenatal memberikan informasi yang diperlukan ibu hamil untuk memahami proses kehamilan dan persalinan, sehingga meningkatkan kepercayaan diri mereka (Dennis & Dowswell, 2019). Penelitian oleh Handayani, Susanto, dan Wahyuni (2021)

menemukan bahwa ibu yang mengikuti kelas antenatal memiliki kesiapan mental lebih baik dibandingkan yang tidak mengikutinya.

c. Manajemen Stres dan Kecemasan

Teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, dan latihan pernapasan terbukti membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan kesiapan mental ibu hamil (Field, 2018). Penelitian oleh Suryani, Rahayu, dan Ningsih (2021) menunjukkan bahwa ibu yang rutin melakukan yoga selama kehamilan mengalami tingkat stres yang lebih rendah dan kesiapan mental yang lebih baik.

d. Faktor Psikologis dan Kepercayaan Diri

Kepercayaan diri ibu dalam menghadapi kehamilan dan persalinan sangat dipengaruhi oleh pengalaman sebelumnya dan dukungan emosional yang didapatkan (Slade, 2017). Penelitian oleh Sari, Anwar, dan Hidayat (2022) menunjukkan bahwa ibu yang merasa percaya diri dalam menjalani kehamilan cenderung memiliki persalinan yang lebih lancar.

2. Strategi Meningkatkan Kesiapan Mental Ibu Hamil

a. Peningkatan Edukasi Antenatal

Edukasi yang diberikan oleh tenaga medis, baik melalui kelas antenatal maupun konsultasi pribadi, membantu ibu memahami berbagai aspek kehamilan dan persalinan (Buckley, 2015). Penelitian oleh Handayani et al. (2021) menunjukkan bahwa ibu yang mengikuti kelas antenatal memiliki kesiapan mental lebih tinggi dibandingkan yang tidak mengikutinya.

b. Pemberian Dukungan Sosial dan Emosional

Pasangan dan keluarga memiliki peran penting dalam memberikan rasa aman dan nyaman bagi ibu hamil (Robertson et al., 2018). Penelitian oleh Lestari et al. (2021) menemukan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional dari pasangan lebih siap menghadapi persalinan.

c. Praktik Relaksasi dan Mindfulness

Latihan pernapasan, meditasi, dan yoga prenatal dapat membantu mengurangi stres dan meningkatkan kesiapan mental ibu hamil (Smith et al., 2020). Penelitian oleh Suryani et al. (2021) menemukan bahwa teknik mindfulness dapat membantu ibu hamil merasa lebih tenang dan percaya diri menghadapi persalinan.

d. Konseling Psikologis

Pendampingan psikologis melalui terapi kognitif perilaku (CBT) dapat membantu ibu mengatasi kecemasan dan meningkatkan kesiapan mental (Hofmann et al., 2012). Penelitian oleh Rahmawati, Sari, dan Prasetyo (2021)

menunjukkan bahwa intervensi psikologis efektif dalam mengurangi kecemasan pada ibu hamil.

3. Kesimpulan

Kesiapan mental ibu hamil dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dukungan sosial, edukasi antenatal, manajemen stres, dan kepercayaan diri. Strategi untuk meningkatkan kesiapan mental meliputi peningkatan edukasi, pemberian dukungan sosial, praktik relaksasi, dan pendampingan psikologis. Penelitian di Indonesia mendukung pentingnya intervensi psikologis dan edukasi antenatal dalam meningkatkan kesiapan mental ibu hamil.

G. Referensi

- Alderdice, F., et al. (2015). Psychological preparation for childbirth: A systematic review. *Midwifery*.
- Ayers, S., et al. (2016). Post-traumatic stress disorder after childbirth: A review of the evidence. *Psychological Medicine*.
- Beck, C. T. (2015). Traumatic childbirth and its aftermath. *Journal of Perinatal & Neonatal Nursing*.
- Bohren, M. A., et al. (2017). Continuous support for women during childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Buckley, S. J. (2015). Hormonal Physiology of Childbearing: Evidence and Implications for Women, Babies, and Maternity Care. *Childbirth Connection*.
- Dennis, C. L., & Dowswell, T. (2019). Psychosocial and psychological interventions for preventing postpartum depression. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Feldman, R., et al. (2010). Maternal depression and bonding with the infant. *Developmental Psychology*.
- Field, T. (2018). Prenatal stress effects on early development: A review. *Infant Behavior and Development*.
- Gavin, N. I., et al. (2018). Perinatal depression: A systematic review of prevalence and incidence. *Obstetrics & Gynecology*.
- Glover, V. (2014). Maternal stress during pregnancy and infant development. *Neuroscience & Biobehavioral Reviews*.
- Handayani, R., Susanto, A., & Wahyuni, T. (2021). Pengaruh teknik relaksasi terhadap durasi persalinan. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(2), 105-115.
- Hodnett, E. D., et al. (2017). Continuous labour support for improving birth outcomes. *The Cochrane Library*.
- Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. (2020). Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2020. Kementerian Kesehatan RI.

- Kennedy, H. P., et al. (2016). Midwifery support and its impact on birth experience. *Journal of Midwifery & Women's Health*.
- Lestari, D., Purnomo, A., & Dewi, M. (2021). Peran dukungan sosial dalam manajemen nyeri persalinan. *Jurnal Kesehatan Ibu dan Anak*, 14(1), 45-56.
- Lowe, N. K. (2015). The nature of labor pain. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*.
- Melzack, R., & Wall, P. D. (2018). Pain mechanisms: A new theory. *Science*.
- Nuraini, T., Setiawan, R., & Hartati, N. (2021). Efektivitas kelas antenatal dalam meningkatkan keterlibatan pasangan saat persalinan. *Jurnal Kesehatan Masyarakat Indonesia*, 18(3), 78-92.
- Puspitasari, D., Wijayanti, S., & Rahmawati, R. (2020). Prevalensi depresi pasca persalinan di Indonesia. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 18(3), 78-92.
- Rahmawati, R., Sari, P., & Prasetyo, A. (2021). Peran tenaga medis dalam memberikan dukungan emosional selama persalinan. *Jurnal Kebidanan dan Keperawatan*, 15(2), 34-49.
- Simkin, P., et al. (2017). *Pregnancy, Childbirth, and the Newborn: The Complete Guide*. Harvard Common Press.
- Simkin, P., & Ancheta, R. (2018). *Labor Progress Handbook: Early Interventions to Prevent and Treat Dystocia*. Wiley-Blackwell.
- Smith, C. A., et al. (2020). Hypnobirthing for pain management in labor. *Cochrane Database of Systematic Reviews*.
- Suryani, R., Rahayu, S., & Ningsih, Y. (2021). Efektivitas hypnobirthing dalam mengurangi kecemasan dan nyeri persalinan. *Jurnal Psikologi Klinis Indonesia*, 18(3), 78-92.
- Uvnas-Moberg, K. (2020). The role of oxytocin in childbirth and bonding. *Journal of Perinatal Medicine*.

CHAPTER 2

PERAN BIDAN DALAM MENDUKUNG PERSALINAN TANPA RASA SAKIT

Bdn. Mely Damayanti, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Proses persalinan adalah bagian dari siklus kehidupan yang alami bagi setiap wanita, yang melibatkan serangkaian perubahan fisiologis dalam tubuh ibu. Meskipun demikian, nyeri persalinan tetap menjadi salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh ibu selama proses tersebut. Rasa nyeri yang dirasakan ibu saat persalinan disebabkan oleh kontraksi otot rahim, peregangan serviks, dan tekanan pada struktur tubuh lainnya. Meskipun nyeri ini bersifat fisiologis dan normal, intensitasnya dapat memengaruhi pengalaman dan kesejahteraan ibu. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana rasa nyeri tersebut dapat diatasi dan bagaimana peran tenaga kesehatan, khususnya bidan, dalam memberikan dukungan selama proses persalinan (Aziato et al., 2017).

Bidan sebagai tenaga medis yang terlatih memiliki peran ganda, yaitu sebagai penyedia layanan medis dan sebagai pendamping emosional yang mendukung ibu dalam mengelola rasa nyeri. Pendampingan bidan dapat mengurangi kecemasan ibu, yang berhubungan erat dengan persepsi terhadap nyeri. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa adanya dukungan emosional selama persalinan dapat mengurangi persepsi nyeri, mempercepat proses kelahiran, dan meningkatkan kepuasan ibu terhadap pengalaman persalinan (Wong, 2019).

Selain peran pendampingan psikologis, bidan juga dilatih untuk menggunakan pendekatan non-obat dalam mengelola nyeri persalinan. Pendekatan-pendekatan ini, seperti pijat, aromaterapi, hipnoterapi, dan latihan pernafasan, telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri dan meningkatkan kenyamanan ibu selama persalinan. Pijat, misalnya, dapat meningkatkan aliran darah dan mengurangi ketegangan otot, yang membantu mengurangi persepsi nyeri (Choudhary et al., 2021). Aromaterapi, terutama penggunaan minyak esensial seperti lavender, telah terbukti mengurangi kecemasan dan memberikan efek relaksasi (Tanvisut et al., 2018). Selain itu, hipnoterapi juga memberikan efek yang signifikan dalam mengurangi kebutuhan akan analgesik dan memberikan ibu rasa kontrol yang lebih besar terhadap proses persalinan (Fernández-Gamero et al., 2024; Rofana et al., 2024).

Teknik pernafasan terkontrol, yang sering diajarkan oleh bidan, telah terbukti efektif dalam mengurangi ketegangan fisik dan psikologis ibu, serta meningkatkan oksigenasi selama persalinan (Issac et al., 2023; Miri et al., 2023). Semua pendekatan ini berfokus pada pengurangan rasa nyeri dan peningkatan pengalaman ibu dengan mempertimbangkan faktor fisik dan psikologis secara holistik.

Bab ini akan menguraikan peran bidan dalam mendukung persalinan tanpa rasa sakit melalui berbagai pendekatan yang dapat diterapkan selama proses persalinan. Pendekatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk mengurangi rasa nyeri, tetapi juga untuk meningkatkan kesejahteraan ibu secara keseluruhan, memberikan pengalaman persalinan yang lebih positif, serta meningkatkan keberhasilan proses kelahiran yang fisiologis.

B. Keterkaitan antara Fisiologi Persalinan dengan Nyeri Persalinan

Proses persalinan adalah serangkaian peristiwa fisiologis yang kompleks, yang melibatkan perubahan pada tubuh ibu dan janin untuk memungkinkan kelahiran bayi. Proses ini dibagi menjadi tiga tahap utama: tahap pertama (persiapan dan pembukaan serviks), tahap kedua (keluarnya bayi), dan tahap ketiga (keluarnya plasenta). Setiap tahap ini melibatkan interaksi antara hormon, sistem saraf, dan sistem muskuloskeletal yang menyebabkan perubahan fisik yang dapat menimbulkan rasa nyeri.

1. Fisiologi Persalinan

Pada tahap pertama, kontraksi otot rahim mulai terjadi sebagai respons terhadap peningkatan kadar oksitosin, hormon yang berfungsi merangsang kontraksi. Kontraksi ini menyebabkan serviks terbuka dan menggeser bayi ke posisi yang lebih rendah di dalam rongga panggul. Selama kontraksi ini, tekanan pada serviks dan struktur panggul lainnya (termasuk ligamen dan jaringan ikat) menyebabkan rasa nyeri, yang pada gilirannya ditransmisikan melalui serabut saraf ke otak (Bingham, 2018). Selain itu, perubahan pada tekanan intrauterin selama kontraksi juga dapat mempengaruhi aliran darah ke rahim dan menyebabkan iskemia (kekurangan oksigen), yang dapat meningkatkan sensasi nyeri (Nori et al., 2023).

Pada tahap kedua, ketika bayi mulai keluar, tekanan yang meningkat pada kanal lahir dan peregangan jaringan perineum menambah intensitas nyeri. Proses pengeluaran bayi ini seringkali disertai dengan tekanan yang lebih besar pada jalan lahir, yang melibatkan peregangan serviks dan dinding vagina. Pada tahap ketiga, meskipun rasa nyeri berkurang, kontraksi yang tersisa untuk mengeluarkan plasenta dapat melibatkan sedikit rasa sakit.

2. Sumber Nyeri Persalinan

Nyeri persalinan sebagian besar disebabkan oleh dua mekanisme utama: nyeri somatik dan nyeri viseral. Nyeri Visceral adalah nyeri yang berasal dari organ dalam, khususnya dari kontraksi rahim yang dipicu oleh oksitosin. Nyeri visceral umumnya bersifat tumpul dan menyebar, serta dirasakan terutama pada tahap pertama persalinan ketika kontraksi otot rahim terjadi (Zhu, 2019). Sedangkan Nyeri Somatik berasal dari peregangan dan tekanan pada jaringan luar, seperti perineum dan vagina, terutama pada tahap kedua persalinan. Nyeri ini lebih tajam dan lebih terlokalisasi (Hockley et al., 2017).

Sistem saraf yang terlibat dalam transmisi nyeri adalah sistem saraf otonom dan somatik. Serabut saraf yang mentransmisikan nyeri visceral selama kontraksi rahim sebagian besar berasal dari cabang-cabang saraf pelvis, seperti saraf vagus dan saraf iliac. Sementara itu, nyeri somatik yang dihasilkan oleh peregangan jaringan luar diproses oleh serabut saraf somatik yang berasal dari sakral dan saraf pudendal (Bingham, 2018).

3. Peran Faktor Psikologis dalam Nyeri Persalinan

Faktor psikologis memiliki pengaruh yang signifikan terhadap persepsi nyeri selama persalinan. Kecemasan dan ketakutan adalah dua elemen psikologis yang dapat memperburuk pengalaman nyeri pada ibu hamil. Ketika seorang ibu merasa cemas atau takut, respons stres yang dihasilkan akan memicu pelepasan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin. Hormon-hormon ini dapat meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap rasa sakit, membuat ibu lebih merasakan intensitas nyeri yang lebih tinggi (Huang et al., 2024; Simona et al., 2022). Selain itu, kecemasan yang berlebihan dapat memperburuk ketegangan otot dan meningkatkan ketegangan tubuh secara keseluruhan, yang turut mempengaruhi persepsi nyeri.

Proses persalinan, yang sudah melibatkan faktor fisiologis dan mekanis seperti kontraksi rahim dan peregangan jaringan, akan terasa lebih intens jika ibu merasa tertekan atau tidak siap. Ketidakpastian mengenai proses persalinan, serta ketakutan terhadap rasa sakit atau komplikasi, bisa memicu pola pikir negatif yang memperburuk pengalaman ibu. Oleh karena itu, kesiapan mental menjadi faktor penting dalam mengelola nyeri persalinan. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang merasa lebih siap secara mental dan emosional, baik melalui pendidikan persalinan atau dukungan dari tenaga kesehatan, cenderung memiliki persepsi nyeri yang lebih rendah (Huang et al., 2024).

Mengelola faktor psikologis ini, melalui pendekatan seperti teknik relaksasi, dukungan emosional, dan pendidikan persalinan, dapat membantu mengurangi kecemasan dan meningkatkan rasa kontrol ibu terhadap proses persalinan.

Pendekatan ini juga dapat memperbaiki hasil persalinan, mengurangi penggunaan analgesik, dan memberikan pengalaman persalinan yang lebih positif.

4. Hubungan antara Fisiologi dan Nyeri Persalinan

Proses persalinan yang normal melibatkan serangkaian perubahan fisiologis yang kompleks, seperti kontraksi rahim yang disebabkan oleh peningkatan kadar oksitosin, peregangan serviks yang terjadi seiring dengan pembukaan, serta tekanan pada struktur panggul dan jalan lahir. Semua faktor ini bekerja secara bersama-sama dalam memungkinkan bayi keluar dengan aman. Namun, di balik proses fisiologis ini, nyeri persalinan yang dialami ibu sangat dipengaruhi oleh interaksi antara faktor fisik dan psikologis.

Kontraksi rahim yang meningkat selama persalinan menyebabkan tekanan pada serviks dan jaringan panggul, yang memicu rasa nyeri. Selain itu, peningkatan tekanan intrauterin selama kontraksi dapat menurunkan aliran darah ke rahim, yang berkontribusi pada terjadinya iskemia dan memperburuk sensasi nyeri (Bingham, 2018). Meskipun rasa nyeri ini bersifat fisiologis, persepsi nyeri ibu dapat bervariasi secara signifikan, bergantung pada faktor psikologis yang mempengaruhi respons ibu terhadap nyeri.

Faktor psikologis seperti kecemasan, ketakutan, dan ketegangan tubuh dapat memperburuk persepsi nyeri selama persalinan. Ketika ibu merasa cemas atau takut, tubuh merespons dengan memproduksi hormon stres, seperti kortisol, yang meningkatkan sensitivitas terhadap rasa sakit. Ketidakpastian tentang proses persalinan dan rasa takut akan ketidaknyamanan dapat memperburuk pengalaman ibu selama persalinan (Huang et al., 2024).

Oleh karena itu, pendekatan pengelolaan nyeri selama persalinan tidak hanya melibatkan penggunaan analgesik atau teknik medis fisik lainnya, tetapi juga pendekatan psikologis yang mendalam. Pendekatan ini meliputi pendidikan persalinan yang memberikan pemahaman lebih tentang proses kelahiran, teknik relaksasi untuk mengurangi kecemasan, serta dukungan emosional dari tenaga kesehatan, yang dapat membantu ibu merasa lebih siap dan terkendali selama proses persalinan. Menurut penelitian oleh Hunter, et al (2020), pengelolaan stres dan pemberian rasa kontrol kepada ibu selama persalinan dapat mengurangi persepsi nyeri dan meningkatkan pengalaman kelahiran secara keseluruhan (Hunter et al., 2020).

C. Peran Bidan dalam Persalinan Tanpa Rasa Sakit

Peran bidan dalam mendukung persalinan tanpa rasa sakit sangat penting, karena bidan tidak hanya berfungsi sebagai pemberi perawatan medis, tetapi juga

sebagai pendamping emosional yang membantu ibu menghadapi proses persalinan dengan lebih tenang dan nyaman. Dalam konteks ini, peran bidan melibatkan pendekatan yang bersifat fisik, psikologis, dan edukatif untuk mengurangi rasa nyeri persalinan tanpa bergantung sepenuhnya pada analgesik atau obat-obatan. Beberapa metode yang digunakan oleh bidan dalam mendukung persalinan tanpa rasa sakit mencakup teknik relaksasi, terapi alternatif, serta pendidikan persalinan

1. Pendekatan Fisik dan Psikologis untuk Mengelola Nyeri

Bidan memainkan peran utama dalam mengelola nyeri persalinan melalui pendekatan fisik dan psikologis yang mengurangi kecemasan ibu, meningkatkan rasa kontrol, dan mengurangi ketegangan yang memperburuk persepsi nyeri. Beberapa teknik yang dapat digunakan oleh bidan untuk membantu ibu mengelola nyeri meliputi:

a. Teknik relaksasi dan pernapasan

Pernapasan terkontrol dan relaksasi merupakan salah satu pendekatan non-farmakologis yang sering digunakan oleh bidan untuk mendukung ibu dalam menghadapi proses persalinan dengan lebih nyaman. Teknik ini memiliki dampak yang signifikan terhadap pengelolaan nyeri, pengurangan kecemasan, serta peningkatan rasa kontrol ibu terhadap tubuhnya selama persalinan. Penelitian ilmiah telah menunjukkan bahwa pernapasan yang teratur dan dalam dapat mengurangi persepsi terhadap nyeri dan meningkatkan kenyamanan secara keseluruhan (Karkada et al., 2022; Miri et al., 2023).

Teknik pernapasan terkontrol selama persalinan melibatkan pengaturan pola napas dengan tujuan untuk mengatur respons tubuh terhadap stres dan nyeri. Salah satu teknik yang paling umum diajarkan adalah pernapasan dalam atau pernapasan diafragma, di mana ibu diminta untuk menarik napas dalam-dalam melalui hidung, mengisi rongga perut dengan udara, dan menghembuskan napas perlahan melalui mulut. Proses ini membantu ibu fokus pada pernapasannya, yang dapat mengalihkan perhatian dari rasa sakit, mengurangi kecemasan, dan mengatur sistem saraf untuk menjadi lebih tenang.

Pernapasan yang terkontrol berperan penting dalam merangsang sistem saraf parasimpatis, yang bertanggung jawab untuk meredakan respons stres tubuh. Ketika ibu melakukan pernapasan dalam yang teratur, sistem saraf parasimpatis diaktifkan, yang mengarah pada penurunan kadar hormon stres seperti kortisol. Penurunan kadar kortisol ini dapat membantu mengurangi ketegangan otot dan memperbaiki keseimbangan hormon dalam tubuh, sehingga memperkecil intensitas persepsi terhadap rasa nyeri (Issac et al., 2023).

Pernapasan dalam juga meningkatkan oksigenasi tubuh, yang sangat penting selama persalinan. Selama kontraksi, otot-otot tubuh, termasuk otot rahim, mengalami ketegangan yang dapat menyebabkan rasa nyeri. Dengan meningkatkan aliran oksigen ke dalam tubuh melalui teknik pernapasan, ibu dapat mengurangi ketegangan otot dan mengoptimalkan fungsi organ tubuh, termasuk rahim. Peningkatan oksigenasi juga berperan dalam menjaga energi ibu dan memfasilitasi kelancaran proses persalinan, karena oksigen sangat penting untuk kelangsungan metabolisme tubuh (Field, 2016).

b. Pijat dan Sentuhan

Pijat merupakan salah satu teknik non-obat yang dapat digunakan oleh bidan untuk meredakan nyeri persalinan. Menurut penelitian, pijat dapat mengurangi ketegangan otot, meningkatkan aliran darah, dan mengurangi kecemasan ibu (Aziato et al., 2017).

1) Pijat punggung

Pijat pada bagian punggung adalah teknik yang efektif dalam mengurangi nyeri selama persalinan. Punggung ibu, khususnya bagian bawah punggung atau daerah sacrum, sering kali menjadi area yang sangat tegang selama kontraksi. Pijat yang dilakukan di area ini dapat memberikan relaksasi otot, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengurangi ketegangan otot yang menyebabkan rasa sakit. Pijat punggung dapat mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan aliran darah ke jaringan yang terkena, yang dapat membantu mengurangi rasa nyeri persalinan (Field, 2016). Selain itu, pijat punggung merangsang sistem saraf parasimpatis, yang berfungsi untuk menurunkan tekanan darah dan memperlambat detak jantung, sehingga memberikan efek menenangkan pada tubuh ibu (Cohen, 2021). Dengan cara ini, pijat punggung tidak hanya meredakan nyeri fisik, tetapi juga dapat menenangkan ibu secara emosional.

Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pijat punggung yang dilakukan oleh tenaga medis atau pendamping persalinan dapat mengurangi intensitas nyeri yang dirasakan ibu selama persalinan. Sebuah studi oleh Lasky et al. (2017) mengungkapkan bahwa ibu yang menerima pijatan di area punggung selama persalinan melaporkan tingkat nyeri yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak mendapatkan pijatan. Pijat punggung ini tidak hanya memberikan rasa nyaman, tetapi juga membantu ibu untuk tetap lebih tenang dan fokus pada proses kelahiran (Lasky, 2017).

2) Pijat *deep back massage* (Fitrianingsih & Prianti, 2017)

Deep Back Massage merupakan salah satu metode nonfarmakologis yang efektif dalam mengurangi nyeri persalinan, terutama pada kala I fase aktif. Teknik ini melibatkan penekanan mantap pada daerah sakrum selama kontraksi berlangsung, yang dapat membantu mengurangi nyeri setara dengan pemberian analgesik seperti meperidine 50-100 mg. Beberapa mekanisme utama dari metode ini meliputi:

a) Relaksasi Otot

Penurunan ketegangan otot, termasuk otot abdomen, yang membantu ibu lebih rileks saat menghadapi kontraksi.

b) Peningkatan Sirkulasi

Meningkatkan aliran darah ke daerah genitalia, memperbaiki elastisitas serviks, dan mendukung proses persalinan.

c) Pengurangan Stres dan Kecemasan

Mengurangi ketakutan dan ketegangan yang dapat memperburuk nyeri saat bersalin.

d) Pelepasan Endorfin

Meningkatkan kadar endorfin yang berperan sebagai pereda nyeri alami tubuh.

e) Stimulasi Oksitosin

Memperkuat kontraksi miometrium, membantu dalam proses pembukaan serviks dan mempercepat persalinan.

Penekanan pada sakrum dapat dilakukan menggunakan tangan yang dikepalkan atau bola tenis pada titik sakrum 2, 3, dan 4. Teknik ini dikombinasikan dengan teknik pernapasan dalam dan relaksasi, yang semakin membantu ibu dalam mengontrol nyeri dan kontraksi uterus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode ini efektif dalam menurunkan tingkat nyeri pada ibu bersalin kala I fase aktif, menjadikannya pilihan yang baik bagi bidan atau tenaga kesehatan dalam manajemen nyeri persalinan secara nonfarmakologis.

3) Pijat perineum

Pijat perineum juga dapat membantu mengurangi rasa nyeri yang berhubungan dengan peregangan perineum pada tahap kedua persalinan (Aziato et al., 2017; Bozkurt, 2020). Pijat perineum merupakan teknik non-farmakologis yang digunakan untuk mengurangi nyeri dan trauma perineum selama proses persalinan, terutama pada tahap kedua, yaitu saat bayi melewati jalan lahir. Teknik ini melibatkan pemberian tekanan dan peregangan pada area perineum dengan tujuan untuk meningkatkan

elastisitas jaringan, mempersiapkan perineum untuk melahirkan, serta mengurangi rasa sakit dan risiko robekan perineum. Penelitian menunjukkan bahwa pijat perineum dapat membantu ibu mengurangi persepsi nyeri selama persalinan. Pijat perineum dapat mempengaruhi sistem saraf untuk mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan kenyamanan selama kontraksi, sehingga ibu dapat lebih nyaman saat proses persalinan berlangsung (Kemp, 2020).

4) Sentuhan

Sentuhan yang lembut dapat memberikan kenyamanan emosional, mengurangi stres, dan meningkatkan rasa dukungan selama proses persalinan. Sentuhan lembut yang diberikan pada ibu selama persalinan dapat merangsang pelepasan endorfin, yaitu hormon yang bertanggung jawab untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan senang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan fisik, seperti sentuhan lembut, dapat mengurangi kecemasan dan memperbaiki suasana hati ibu, yang pada gilirannya mengurangi persepsi nyeri selama persalinan (Cohen, 2021; Field, 2016). Selain itu, sentuhan lembut dapat meningkatkan perasaan dukungan dan kedekatan dengan orang yang memberikan sentuhan, yang penting untuk mengurangi perasaan kesepian dan ketidakberdayaan ibu selama proses persalinan.

Sentuhan lembut yang diberikan pada ibu selama persalinan dapat merangsang pelepasan endorfin, yaitu hormon yang bertanggung jawab untuk mengurangi rasa sakit dan meningkatkan perasaan senang. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa dukungan fisik, seperti sentuhan lembut, dapat mengurangi kecemasan dan memperbaiki suasana hati ibu, yang pada gilirannya mengurangi persepsi nyeri selama persalinan (Cohen, 2021; Field, 2016). Selain itu, sentuhan lembut dapat meningkatkan perasaan dukungan dan kedekatan dengan orang yang memberikan sentuhan, yang penting untuk mengurangi perasaan kesepian dan ketidakberdayaan ibu selama proses persalinan.

Stres dan kecemasan dapat meningkatkan produksi hormon stres seperti kortisol, yang diketahui dapat memperburuk persepsi nyeri. Dalam hal ini, sentuhan lembut berperan penting dalam meredakan kecemasan. Penelitian menunjukkan bahwa ketika ibu hamil mendapat dukungan fisik melalui sentuhan lembut, tingkat kecemasan dan ketegangan dapat berkurang, yang dapat meningkatkan pengelolaan nyeri (Cohen, 2021). Sentuhan dapat memberikan rasa aman dan kontrol terhadap proses persalinan, sehingga mengurangi rasa takut dan kecemasan.

Dukungan emosional dan fisik dari tenaga kesehatan atau pendamping persalinan melalui sentuhan lembut memberikan perasaan "terhubung" dan dihargai, yang memengaruhi persepsi ibu terhadap rasa sakit. Penelitian oleh Lasky et al. (2017) menunjukkan bahwa ibu yang mendapatkan dukungan emosional dari pasangan atau tenaga medis yang memberikan sentuhan lembut cenderung melaporkan pengalaman persalinan yang lebih positif dan tingkat nyeri yang lebih rendah (Lasky, 2017).

c. Aromaterapi

Aromaterapi, yang menggunakan minyak esensial, adalah salah satu pendekatan alternatif yang semakin populer dalam mendukung kenyamanan emosional dan fisik ibu selama persalinan. Penggunaan aromaterapi bertujuan untuk menciptakan suasana yang menenangkan dengan memanfaatkan aroma yang berpotensi memengaruhi sistem saraf, mengurangi kecemasan, dan meningkatkan kesejahteraan ibu. Aromaterapi bekerja melalui sistem penciuman (olfaktori) yang terhubung langsung ke otak, terutama ke bagian yang mengatur emosi, seperti amigdala dan hipotalamus. Ketika aroma minyak esensial dihirup, sinyal kimia dikirim ke otak yang dapat memicu pelepasan neurotransmitter tertentu, seperti serotonin dan endorfin, yang berperan dalam meredakan kecemasan dan meningkatkan perasaan relaksasi (Tabatabaeichehr & Mortazavi, 2020). Sebagai contoh, minyak esensial lavender dikenal memiliki sifat sedatif, yang dapat menenangkan sistem saraf dan membantu ibu merasa lebih rileks, mengurangi ketegangan, dan meningkatkan kenyamanan emosional selama proses persalinan.

Minyak lavender sering kali digunakan dalam aromaterapi selama persalinan untuk membantu mengurangi kecemasan dan stres yang sering dialami ibu. Minyak esensial lavender memiliki kemampuan untuk menurunkan tingkat kecemasan pada ibu hamil yang mengalami proses persalinan, dengan cara mengaktifkan sistem parasimpatis yang bertanggung jawab untuk mengurangi respons stres tubuh. Dalam sebuah studi, ibu yang terpapar aroma lavender mengalami penurunan yang signifikan dalam tingkat kecemasan dan peningkatan kenyamanan selama fase pertama persalinan. Efek ini sangat penting karena kecemasan yang berlebihan dapat memperburuk persepsi terhadap rasa nyeri, sehingga dengan mengurangi kecemasan, ibu dapat lebih siap dan tenang dalam menghadapi proses kelahiran (Cohen, 2021).

Aromaterapi, terutama dengan menggunakan minyak lavender, juga dapat menciptakan atmosfer yang menenangkan yang mendukung proses persalinan. Dalam lingkungan yang penuh kecemasan atau stres, persepsi terhadap rasa nyeri bisa menjadi lebih intens. Dengan menciptakan suasana

yang lebih tenang dan mendukung, aromaterapi membantu ibu merasa lebih nyaman dan terkendali. Penelitian menunjukkan bahwa ibu yang diberikan aromaterapi lavender melaporkan penurunan rasa nyeri secara subjektif, meskipun efek ini lebih berkaitan dengan kenyamanan emosional yang tercipta dari lingkungan yang menenangkan daripada efek langsung dari minyak tersebut pada nyeri fisik (Field, 2016).

Bidan dapat memanfaatkan aromaterapi sebagai bagian dari pendekatan holistik dalam mengelola nyeri dan kecemasan selama persalinan. Aromaterapi dapat diberikan melalui diffuser, atau dengan menggunakan kapas yang dibubuhi minyak esensial yang ditempatkan di dekat ibu, sehingga ibu dapat menghirup aroma yang menenangkan. Selain minyak lavender, minyak esensial lain yang juga dapat digunakan dalam aromaterapi selama persalinan adalah minyak chamomile dan geranium, yang juga memiliki sifat relaksasi dan menenangkan.

d. Hipnoterapi

Hipnoterapi juga semakin banyak digunakan oleh bidan untuk mendukung persalinan tanpa rasa sakit. Hipnoterapi dapat membantu ibu mengubah persepsi mereka terhadap rasa sakit dengan memanfaatkan sugesti verbal untuk menciptakan keadaan relaksasi mendalam. Penelitian menunjukkan bahwa hipnoterapi dapat mengurangi kebutuhan akan analgesik dan membantu ibu merasa lebih terkendali selama persalinan (Fernández-Gamero et al., 2024; Rofana et al., 2024).

Hipnoterapi memengaruhi mekanisme saraf pusat yang mengontrol persepsi nyeri. Dalam keadaan terhipnosis, tubuh dan pikiran ibu berada dalam kondisi relaksasi yang dalam, yang menurunkan tingkat kecemasan dan stres. Ketegangan otot yang biasanya terjadi karena kecemasan atau ketakutan dapat dikurangi, sehingga mengurangi intensitas rasa sakit yang dirasakan selama kontraksi.

Sugesti verbal yang diberikan selama sesi hipnosis dapat membantu ibu mengubah cara mereka merespons kontraksi dan nyeri persalinan. Penurunan kecemasan berhubungan langsung dengan penurunan persepsi terhadap rasa sakit, karena kecemasan dapat memperburuk persepsi nyeri dengan meningkatkan respons stres tubuh, termasuk peningkatan kadar hormon kortisol dan adrenalin (Anderson, 2020). Oleh karena itu, dengan mengurangi kecemasan melalui hipnoterapi, ibu dapat lebih santai, mengurangi ketegangan otot, dan memperbaiki pengalaman persalinan.

Berbagai penelitian telah menunjukkan bahwa hipnoterapi dapat mengurangi intensitas nyeri dan meningkatkan kenyamanan ibu selama persalinan. Salah

satu penelitian menemukan bahwa ibu yang menerima hipnoterapi mengalami penurunan signifikan dalam tingkat nyeri selama persalinan dan melaporkan pengalaman kelahiran yang lebih positif dibandingkan dengan kelompok kontrol. Penelitian ini juga mencatat bahwa penggunaan hipnoterapi mengurangi kebutuhan ibu akan analgesik, seperti epidural atau obat penghilang rasa sakit lainnya (Madden et al., 2016). Ibu yang menerima hipnoterapi memiliki persepsi nyeri yang lebih rendah, serta tingkat kecemasan yang lebih rendah dibandingkan dengan ibu yang tidak menggunakan teknik tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hipnoterapi tidak hanya mengurangi rasa nyeri, tetapi juga mengoptimalkan kesejahteraan psikologis ibu selama persalinan.

Hipnoterapi dapat membantu ibu mengelola kecemasan yang sering terjadi sebelum dan selama persalinan. Ketika ibu merasa cemas atau takut, tubuh mereka melepaskan hormon stres seperti kortisol dan adrenalin, yang meningkatkan ketegangan otot dan memperburuk persepsi nyeri (Field, 2016; Issac et al., 2023). Dengan mengurangi kecemasan melalui hipnoterapi, ibu dapat mengalami penurunan tingkat stres, yang pada gilirannya mengurangi ketegangan otot dan persepsi terhadap rasa sakit.

Hipnoterapi juga dapat membantu ibu untuk merasa lebih terkendali dalam menghadapi proses persalinan. Dengan meningkatkan rasa kontrol, ibu lebih mungkin untuk merasa lebih siap dan percaya diri dalam menghadapi kontraksi dan fase-fase persalinan lainnya. Penurunan ketidakpastian dan rasa takut yang biasa dialami selama persalinan dapat meningkatkan kualitas pengalaman ibu (Anderson, 2020).

e. Akupresur dan Akupunktur

Akupresur dan akupunktur adalah dua teknik pengobatan tradisional yang berasal dari Tiongkok dan telah digunakan dalam pengelolaan nyeri, termasuk dalam konteks persalinan. Kedua teknik ini melibatkan stimulasi titik-titik tertentu pada tubuh dengan tujuan untuk meredakan nyeri, mengurangi stres, dan meningkatkan kesejahteraan ibu selama proses persalinan.

Akupresur adalah teknik yang melibatkan tekanan pada titik-titik tertentu di tubuh menggunakan jari atau alat tertentu. Teknik ini tidak menggunakan jarum dan lebih fokus pada stimulasi fisik pada titik akupunktur yang dapat memengaruhi aliran energi tubuh (Qi) serta merangsang respons fisik dan neurologis tubuh. Akupresur bertujuan untuk menyeimbangkan aliran energi dalam tubuh dan membantu tubuh merespons dengan cara yang lebih alami terhadap nyeri. Akupunktur, di sisi lain, melibatkan penggunaan jarum yang sangat tipis yang dimasukkan ke dalam titik-titik tertentu pada tubuh untuk

merangsang jalur energi. Proses ini bertujuan untuk memperbaiki ketidakseimbangan energi, meredakan rasa sakit, dan meningkatkan proses penyembuhan tubuh. Akupunktur didasarkan pada prinsip bahwa tubuh memiliki jalur energi (meridian) yang dapat dipengaruhi dengan stimulasi pada titik-titik tertentu untuk memodulasi fungsi tubuh, termasuk meredakan nyeri (Türkmen et al., 2024).

Akupresur digunakan untuk merangsang titik-titik tertentu pada tubuh yang dipercaya dapat mengurangi ketegangan otot dan meningkatkan aliran darah, yang pada gilirannya dapat meredakan rasa nyeri. Titik akupresur yang paling sering digunakan selama persalinan adalah titik LI4 (Hegu), yang terletak di antara ibu jari dan jari telunjuk. Penelitian menunjukkan bahwa stimulasi pada titik ini dapat mengurangi intensitas nyeri, meningkatkan relaksasi, dan mempercepat progresi persalinan (Lee, 2017). Titik lain yang sering digunakan adalah SP6 (Sanyinjiao), yang terletak di bagian dalam kaki, sekitar empat jari di atas pergelangan kaki, dan dapat membantu mengurangi ketegangan pada panggul dan mengatur kontraksi rahim. Penelitian oleh Lee et al. (2017) menunjukkan bahwa akupresur pada titik-titik ini dapat menurunkan intensitas nyeri persalinan dan mengurangi penggunaan analgesik medis. Selain itu, akupresur dapat meningkatkan kualitas tidur ibu sebelum dan selama persalinan, serta mengurangi kecemasan yang sering kali memperburuk persepsi nyeri.

Akupunktur juga telah terbukti efektif dalam mengurangi nyeri selama persalinan. Sebuah meta-analisis oleh Zhang et al. (2021) menyimpulkan bahwa akupunktur dapat mengurangi durasi persalinan, mengurangi rasa sakit yang dirasakan ibu selama fase aktif, dan menurunkan tingkat penggunaan analgesik epidural. Akupunktur bekerja dengan merangsang titik-titik tertentu di tubuh yang mengatur sistem saraf dan mengurangi respons stres, sehingga mengurangi persepsi nyeri. Titik akupunktur yang sering digunakan dalam pengelolaan nyeri persalinan termasuk LI4 (Hegu) dan GB21 (Jianjing), yang bertanggung jawab untuk mengurangi ketegangan pada otot dan meningkatkan aliran darah ke rahim, serta BL32 yang berfokus pada pengelolaan rasa sakit panggul dan punggung bawah (Zhang, 2021).

2. Pendekatan Psikologis melalui edukasi dan dukungan emosional

Peran bidan dalam memberikan edukasi dan dukungan emosional sangat penting dalam mengurangi rasa nyeri persalinan. Banyak ibu yang merasa cemas atau takut terhadap proses persalinan, dan ketakutan ini dapat meningkatkan persepsi terhadap nyeri. Oleh karena itu, bidan berperan penting dalam

memberikan informasi yang benar mengenai proses persalinan dan mengurangi ketidakpastian yang dapat menyebabkan kecemasan.

a. Pendidikan Persalinan

Pendidikan tentang apa yang akan terjadi selama persalinan dapat membantu ibu merasa lebih siap dan mengurangi rasa takut. Dengan memahami tahapan persalinan, ibu akan lebih mampu menerima proses tersebut dan mengelola ekspektasi mereka dengan lebih baik. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa ibu yang menerima pendidikan persalinan lebih cenderung memiliki persepsi nyeri yang lebih rendah karena mereka merasa lebih percaya diri dan siap (Bingham, 2018; Wong, 2019).

b. Dukungan emosional

Bidan juga berperan dalam memberikan dukungan emosional yang sangat dibutuhkan oleh ibu selama proses persalinan. Dukungan emosional dapat mengurangi kecemasan dan memperkuat ketenangan ibu. Sebuah penelitian menunjukkan bahwa ibu yang didampingi oleh seorang bidan yang memberikan dukungan emosional cenderung melaporkan rasa nyeri yang lebih rendah dibandingkan ibu yang merasa tidak mendapat dukungan (Bingham, 2018)

D. Referensi

- Anderson. (2020). Effectiveness of Hypnotherapy in Reducing Labor Pain: A Meta-Analysis. *Journal of Pain and Symptom Management*, 59(5), 1113–1122.
- Aziato, L., Kyei, A. A., & Deku, G. (2017). Experiences of midwives on pharmacological and non-pharmacological labour pain management in Ghana. *Reproductive Health*, 14(1), 1–8. <https://doi.org/10.1186/s12978-017-0398-y>
- Bingham. (2018). The Physiology of Labor Pain: An Overview. *Pain Management Nursing*, 19(6), 624–633.
- Bozkurt. (2020). Effectiveness of Perineal Massage in Reducing Perineal Trauma: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Obstetrics and Gynaecology Research*, 46(9), 1812–1817.
- Choudhary, S., Jelly, P., Mahala, P., & Mery, A. (2021). Effect of back massage on relieving pain during labour: a systemic review. *International Journal of Reproduction, Contraception, Obstetrics and Gynecology*, 10(6), 2466. <https://doi.org/10.18203/2320-1770.ijrcog20212194>
- Cohen. (2021). The Role of Touch and Support During Labor: Effects on Anxiety and Pain Perception. *Journal of Clinical Psychology*, 77(6), 1458–1465.
- Fernández-Gamero, L., Reinoso-Cobo, A., Ruiz-González, M. del C., Cortés-Martín, J., Muñoz Sánchez, I., Mellado-García, E., & Piqueras-Sola, B. (2024). Impact of

- Hypnotherapy on Fear, Pain, and the Birth Experience: A Systematic Review. *Healthcare (Switzerland)*, 12(6), 1–12. <https://doi.org/10.3390/healthcare12060616>
- Field, T. (2016). Massage Therapy Research Review: A Focus on Labor and Delivery. *Pain Management Nursing*, 17(1), 14–24.
- Fitrianingsih, Y., & Prianti, V. A. (2017). Perbedaan Metode Deep Back Massage Dan Metode Endorphin Massage Terhadap Intensitas Nyeri Persalinan Kala I Fase Aktif Di Puskesmas Poned Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2017. *Jurnal Care*, 5(3), 382–392.
- Hockley, J. R. F., González-Cano, R., McMurray, S., Tejada-Giraldez, M. A., McGuire, C., Torres, A., Wilbrey, A. L., Cibert-Goton, V., Nieto, F. R., Pitcher, T., Knowles, C. H., Baeyens, J. M., Wood, J. N., Winchester, W. J., Bulmer, D. C., Cendán, C. M., & McMurray, G. (2017). Visceral and somatic pain modalities reveal NaV1.7-independent visceral nociceptive pathways. *Journal of Physiology*, 595(8), 2661–2679. <https://doi.org/10.1113/JP272837>
- Huang, Y., Zhong, Y., Chen, Q., Zhou, J., Fu, B., Deng, Y., Tu, X., & Wu, Y. (2024). A comparison of childbirth self-efficacy, fear of childbirth, and labor pain intensity between primiparas and multiparas during the latent phase of labor: a cross-sectional study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 24(1), 1–10. <https://doi.org/10.1186/s12884-024-06571-3>
- Hunter, T. A., Sonalkar, S., Schreiber, C. A., Perriera, L. K., Sammel, M. D., & Akers, A. Y. (2020). Anticipated Pain During Intrauterine Device Insertion. *Journal of Pediatric and Adolescent Gynecology*, 33(1), 27–32. <https://doi.org/10.1016/j.jpag.2019.09.007>
- Issac, A., Nayak, S. G., Priyadarshini, T., Balakrishnan, D., Halemani, K., Mishra, P., Indumathi, P., Vijay, V. R., Jacob, J., & Stephen, S. (2023). Effectiveness of breathing exercise on the duration of labour: A systematic review and meta-analysis. *Journal of Global Health*, 13. <https://doi.org/10.7189/jogh.13.04023>
- Karkada, S. R., Noronha, J. A., Bhat, S. K., Bhat, P., & Nayak, B. S. (2022). Effectiveness of antepartum breathing exercises on the outcome of labour: A randomized controlled trial. *F1000Research*, 11, 159. <https://doi.org/10.12688/f1000research.75960.2>
- Kemp. (2020). The Impact of Perineal Massage on Pain and Trauma During Childbirth: A Meta-Analysis. *Journal of Pain & Symptom Management*, 59(6), 1173–1180.
- Lasky. (2017). The Impact of Physical Touch on Labor Pain Perception: A Randomized Controlled Trial. *International Journal of Obstetric Anesthesia*, 29(2), 98–104.
- Lee. (2017). The Effect of Acupressure on Labor Pain and Anxiety: A Randomized Controlled Trial. *Journal of Alternative and Complementary Medicine*, 23(6), 471–478.

- Madden, K., Middleton, P., Cyna, A. M., Matthewson, M., & Jones, L. (2016). [#33159] Cochrane review 2016 Hypnosis for pain management during labour and childbirth. *Cochrane Database of Systematic Reviews*, 2016(5). <https://doi.org/10.1002/14651858.CD009356.pub3>.www.cochranelibrary.com
- Miri, S., Hosseini, S. J., Takasi, P., Mollaei, A., Firooz, M., Falakdami, A., Osuji, J., Ghorbani Vajargah, P., & Karkhah, S. (2023). Effects of breathing exercise techniques on the pain and anxiety of burn patients: A systematic review and meta-analysis. *International Wound Journal*, 20(6), 2360–2375. <https://doi.org/10.1111/iwj.14057>
- Nori, W., Kassim, M. A. K., Helmi, Z. R., Pantazi, A. C., Brezeanu, D., Brezeanu, A. M., Penciu, R. C., & Serbanescu, L. (2023). Non-Pharmacological Pain Management in Labor: A Systematic Review. *Journal of Clinical Medicine*, 12(23). <https://doi.org/10.3390/jcm12237203>
- Rofana, A., Septi, W., & Oktaviani, I. (2024). HYPNOTHERAPY IN OBSTETRIC CARE: SYSTEMATIC REVIEW OF EVIDENCE AND POTENTIAL USE IN CLINICAL PRACTICE. *JOURNAL OF HEALTH MANAGEMENT, ADMINISTRATION AND PUBLIC HEALTH POLICIES*, 2(1).
- Simona, F., Sara, B., Marta, B., Arianna, Z., Marzia, S., Elisabetta, C., & Antonella, N. (2022). Coping strategies for labor pain, related outcomes and influencing factors: A systematic review. *European Journal of Midwifery*, 6(November), 1–13. <https://doi.org/10.18332/ejm/156440>
- Tabatabaeichehr, M., & Mortazavi, H. (2020). The Effectiveness of Aromatherapy in the Management of Labor Pain and Anxiety: A Systematic Review. *Ethiopian Journal of Health Sciences*, 30(3), 449–458. <https://doi.org/10.4314/ejhs.v30i3.16>
- Tanvisut, R., Traisrisilp, K., & Tongsong, T. (2018). Efficacy of aromatherapy for reducing pain during labor: a randomized controlled trial. *Archives of Gynecology and Obstetrics*, 297(5), 1145–1150. <https://doi.org/10.1007/s00404-018-4700-1>
- Türkmen, H., Çetinkaya, S., Kiliç, H., Tuna, S. D., Şırvancı, M., & Mutlu, H. (2024). The Effect of Ice Massage Applied to the SP6 Point on Labor Pain, Labor Comfort, Labor Duration, and Anxiety: A Randomized Clinical Trial. *Journal of Midwifery and Women's Health*, 69(4), 491–498. <https://doi.org/10.1111/jmwh.13600>
- Wong. (2019). The Role of Midwives in Pain Management During Childbirth: A Review of Evidence and Best Practices. *International Journal of Midwifery Research*, 56(2), 210–218.
- Zhang. (2021). Acupuncture for Labor Pain: A Systematic Review and Meta-Analysis. *Journal of Obstetrics and Gynecology Research*, 47(1), 14–22.

Zhu. (2019). Mechanisms of Pain in Labor and Delivery: Insights from Physiology and Neurobiology. *Obstetrical & Gynecological Survey*, 74(2), 71–78.

E. Glosarium

Neurotransmitter: senyawa kimia dalam tubuh yang berfungsi untuk membawa dan mengirimkan pesan antar neuron atau dari neuron ke berbagai jaringan tubuh, seperti otot. Pengiriman pesan ini memungkinkan otak untuk menjalankan fungsinya dengan baik, meningkatkan dan menyeimbangkan sinyal di otak, serta membantu mengelola respons otomatis tubuh.

CHAPTER 3

PENANGANAN DISTOSIA BAHU PADA PERSALINAN NORMAL

Putri Yuniartis, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan

Persalinan normal umumnya berlangsung tanpa komplikasi, tetapi dalam beberapa kasus, dapat terjadi hambatan yang memerlukan intervensi medis segera. Salah satu komplikasi persalinan yang jarang namun berisiko tinggi adalah distosia bahu (The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2017). Konsep distosia bahu telah dikenal dan didokumentasikan selama lebih dari dua abad. Kondisi ini terjadi ketika bahu anterior janin tersangkut di belakang simfisis pubis setelah kepala bayi lahir. Distosia bahu biasanya terjadi ketika diameter biakromial janin (jarak antara kedua bahu) lebih besar daripada diameter panggul ibu, sehingga menghambat proses persalinan (Tsikouras et al., 2024).

Distosia bahu terjadi ketika bahu janin sulit dilahirkan setelah kepala keluar, sehingga membutuhkan intervensi obstetri tambahan. Kondisi ini muncul karena traksi standar pada kepala janin yang biasanya cukup dalam persalinan normal tidak mampu membebaskan bahu anterior, sehingga diperlukan teknik khusus untuk membantu proses persalinan (Gurewitsch Allen, 2024). Apabila tidak ditangani segera, dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas maternal neonatal. Komplikasi yang sering terjadi yaitu cedera pleksus brakialis, fraktur klavikula dan humerus, asfiksia hingga kematian janin. Komplikasi pada ibu termasuk laserasi perineum dan perdarahan postpartum. Risiko trauma ibu dan bayi sangat terkait dengan penatalaksanaan yang dilakukan (Jeppegaard et al., 2024; Michelotti et al., 2018).

Oleh karena itu, tenaga medis yang menangani persalinan, terutama bidan, harus memiliki keterampilan yang baik dalam mengenali, mencegah, dan menangani kondisi ini. Konseling antenatal yang memadai, pemantauan persalinan yang ketat, pelatihan rutin, simulasi, serta pemahaman yang mendalam tentang penanganan distosia bahu sangat penting untuk meningkatkan keberhasilan persalinan dan mengurangi risiko komplikasi bagi ibu dan bayi.

B. Definisi dan Epidemiologi Distosia Bahu

Distosia bahu didefinisikan sebagai suatu penyulit dalam persalinan per vaginam yang terjadi ketika bahu janin tidak lahir segera setelah kepala lahir. Perpanjangan interval waktu antara lahirnya kepala dan lahirnya bahu melebihi 60 detik. Hal ini merupakan kondisi kegawatdaruratan obstetri yang dapat menyebabkan morbiditas dan mortalitas neonatal serta komplikasi maternal dalam beberapa kasus yang berat (Bothou et al., 2021; Heinonen et al., 2024; Tsikouras et al., 2024).

Peningkatan kasus obesitas dan diabetes yang progresif menjadi salah satu faktor risiko utama terjadinya makrosomia janin yang berdampak pada meningkatnya angka kelahiran bayi dengan berat badan besar. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan insidensi distosia bahu dalam persalinan (Alves et al., 2022). Distosia bahu diperkirakan terjadi pada 0,2% hingga 3,0% dari seluruh persalinan, dengan variasi angka kejadian yang dipengaruhi oleh perbedaan dalam subjektivitas diagnosis serta prevalensi makrosomia dan diabetes pada populasi (The American College of Obstetricians and Gynecologists, 2017). Selain itu, diperkirakan bahwa setiap 22.000 persalinan pervaginam pada kehamilan cukup bulan, terdapat satu kasus bayi baru lahir yang mengalami ensefalopati iskemik hipoksia akibat distosia bahu (Alves et al., 2022).

Berdasarkan penyebabnya, distosia bahu dapat dibagi menjadi tiga kategori utama:

1. Distosia akibat kurangnya tenaga untuk melahirkan janin

Terjadi ketika rahim atau plasenta tidak memberikan tenaga yang cukup untuk mendorong janin keluar. Kondisi ini mencakup disfungsi uterus primer atau sekunder selama kala I dan kala II persalinan, serta gagalnya upaya mengejan ibu pada kala II persalinan.

2. Distosia akibat faktor janin

Disebabkan oleh kondisi yang terkait dengan bentuk, presentasi, posisi janin, janin berukuran besar (makrosomia), atau kelainan bawaan. Contohnya adalah presentasi sungsang, posisi janin yang tidak optimal, atau adanya anomali kongenital yang memengaruhi ukuran dan bentuk tubuh janin.

3. Distosia akibat kelainan pada saluran panggul

Disebabkan oleh kelainan bawaan atau kondisi yang mempengaruhi struktur panggul ibu. Kelainan ini bisa berupa ketidakaturan bentuk tulang panggul atau gangguan pada jaringan lunak di sekitar panggul, yang dapat mempersempit jalan lahir dan menghambat proses persalinan.

Perlu diingat bahwa kategori ini tidak bersifat mutlak, karena dalam banyak kasus, beberapa faktor dapat saling berkontribusi terhadap terjadinya distosia bahu. Misalnya, panggul yang sempit dapat menyebabkan posisi janin menjadi tidak normal, sehingga meningkatkan risiko distosia bahu saat persalinan berlangsung. Dalam praktik medis saat ini, Cephalopelvic Disproportion (CPD) atau disproporsi sefalopelvik sering dianggap sebagai salah satu alasan utama untuk melakukan operasi caesar jika persalinan pervaginam tidak memungkinkan. Istilah ini pertama kali digunakan pada abad ke-19 untuk menggambarkan ketidakseimbangan antara ukuran kepala janin dan diameter saluran panggul ibu, yang dapat menghambat proses persalinan. Dahulu, CPD secara akurat menggambarkan kondisi ibu hamil yang menderita rakhitis, yang menyebabkan penyempitan panggul. Pada awal abad ke-20, kondisi ini diperkirakan menjadi penyebab hingga 15% kasus persalinan sulit di beberapa wilayah tertentu. Namun, pada kasus CPD yang parah, di mana persalinan pervaginam benar-benar tidak mungkin dilakukan, kini sangat jarang terjadi. Oleh karena itu, penggunaan istilah ini dalam praktik medis modern sering kali kurang tepat atau berlebihan, terutama jika tidak didukung oleh evaluasi klinis yang akurat. (Tsikouras et al., 2024).

Distosia bahu adalah keadaan darurat yang tidak dapat dicegah dan terjadi secara tidak terduga. Waktu bagi penyedia layanan obstetri untuk menerapkan manajemen yang aman adalah sebelum kondisi kegawatdaruratan ini ditemukan secara klinis. Banyak kasus mungkin tidak terdiagnosis secara dini. Oleh karena itu, setiap tenaga medis yang menangani persalinan harus selalu waspada dan mampu mengenali tanda-tanda awal distosia bahu, sehingga dapat segera melakukan intervensi yang tepat jika bahu janin mengalami hambatan saat lahir (Gurewitsch Allen, 2024).

Distosia bahu berhubungan dengan peningkatan morbiditas dan mortalitas perinatal. Salah satu komplikasi yang sering terjadi adalah cedera pleksus brakialis, yang disebabkan oleh peregangan berlebihan akibat tarikan kepala janin yang terlalu kuat saat upaya melahirkan bahu anterior. Selain itu, fraktur klavikula juga sering ditemukan pada kasus distosia bahu. Jika distosia bahu berlanjut, janin dapat mengalami gawat janin, asfiksia, atau bahkan kematian. Komplikasi maternal akibat distosia bahu meliputi perdarahan postpartum akibat atonia uteri, cedera genital, serta infeksi pascaoperasi pada persalinan sectio caesaria. Infeksi ini dapat terjadi karena kepala janin yang telah terpapar lingkungan vagina dan perineum yang berpotensi septik dimasukkan kembali ke dalam rongga intrauterin selama persalinan transabdominal (Tsikouras et al., 2024).

C. Patofisiologi dan Faktor Predisposisi Distosia Bahu

Distosia bahu merupakan gangguan dalam proses persalinan normal, sehingga sering disebut sebagai "kelahiran patologis". Pada persalinan yang sulit, kemajuan proses persalinan cenderung melambat, yang ditandai dengan terhentinya pembukaan serviks atau turunnya janin ke panggul ibu (Tsikouras et al., 2024).

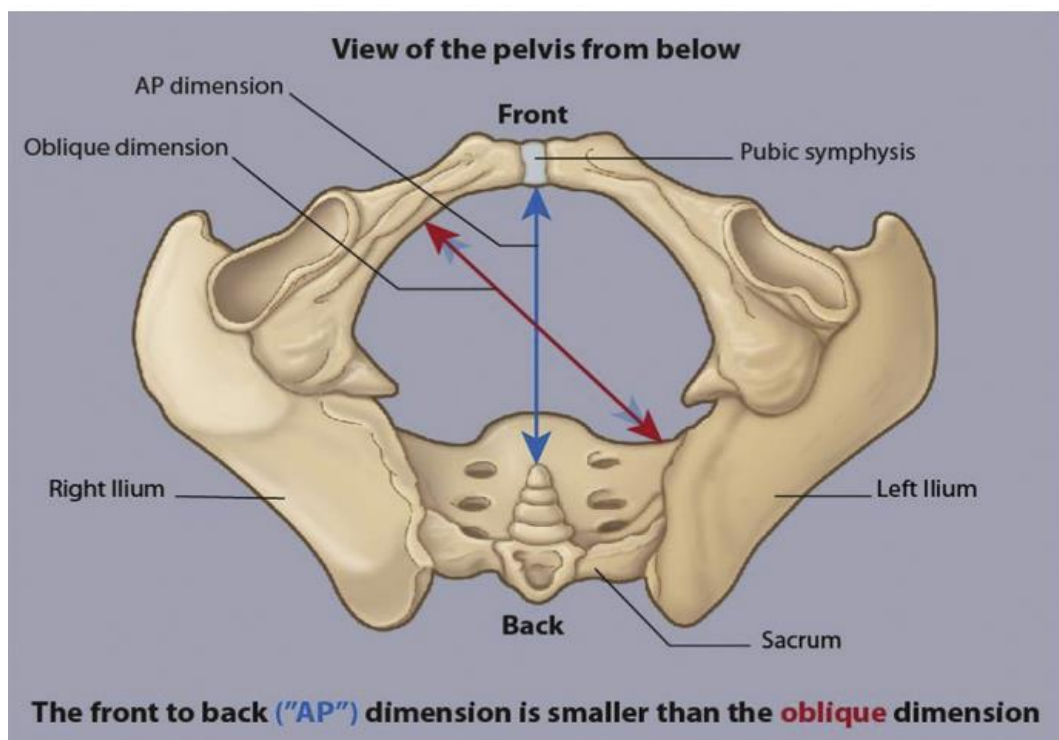
Secara objektif, distosia bahu didefinisikan sebagai keterlambatan lahirnya bahu lebih dari 60 detik setelah lahirnya kepala bayi. Dalam beberapa kasus, kondisi ini ditandai dengan "*turtle sign*"; yaitu kepala bayi yang tampak tertarik kembali ke perineum, menyerupai kura-kura yang masuk ke dalam cangkangnya. Tanda ini biasanya disertai dengan wajah bayi yang memerah dan bengkak, yang terjadi akibat bahu janin terjebak di belakang simfisis pubis ibu. Jika terdapat faktor antenatal dan perinatal yang dapat meningkatkan risiko distosia bahu, tenaga medis yang menangani persalinan harus segera mengenali tanda-tanda awal kondisi ini, seperti bahu janin yang tidak segera turun setelah kepala lahir. (Tsikouras et al., 2024).



Gambar 3.1 Gambar *Turtle Sign*

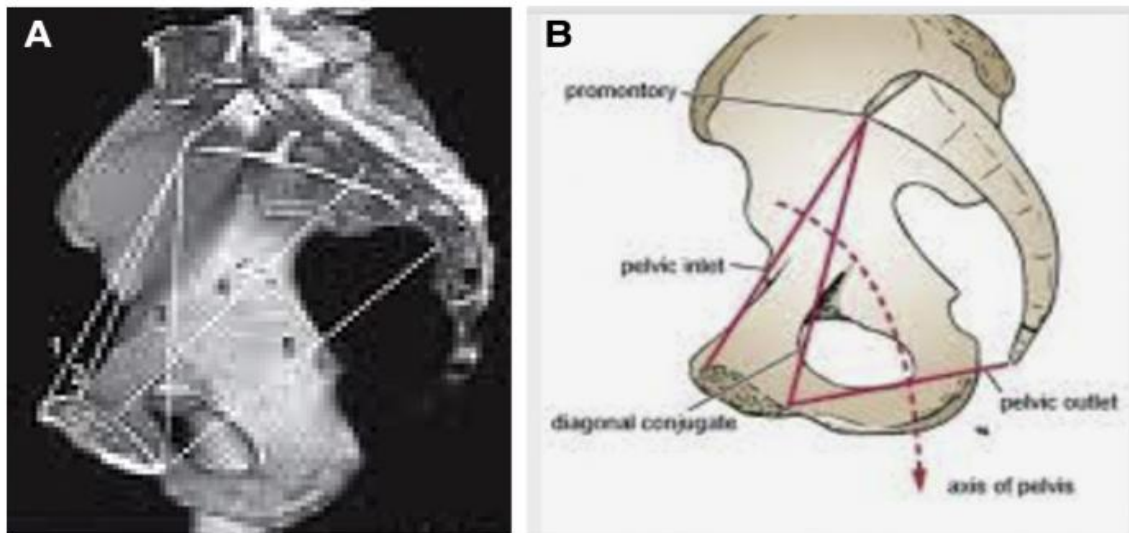
Pada bagian anterior, atau menghadap ke depan, bahu telah terperangkap di bawah tulang kemaluan ibu. Meskipun terjadi distosia, kontraksi uterus yang kuat terus berupaya mendorong bayi melewati jalan lahir. Selama kontraksi, kepala bayi terdorong ke depan dengan peregangan leher sementara bahu dan seluruh tubuh tetap terjebak (Cal Shipley, 2020).

Salah satu yang dapat memengaruhi proses persalinan yaitu 'passage' atau keadaan jalan lahir ibu yang terdiri dari rangka panggul dan jaringan lunak. Distosia bahu pada dasarnya disebabkan oleh impaksi tulang bahu janin terhadap struktur panggul ibu. Kondisi ini terjadi ketika bahu anterior tersangkut di belakang simfisis pubis, bahu posterior menekan promontorium sakrum, atau keduanya, yang menunjukkan adanya disproporsi fetopelvis relatif. Pada pintu bawah panggul ginekoid, jika dilihat pada bidang transversal, dimensi anteroposterior pintu bawah panggul (diukur dari simfisis pubis hingga ujung coccygeus) panjangnya kira-kira 10,5 cm. Dimensi oblique lebih lebar sekitar 2 cm, dan panjang rata-rata 12,5 cm. Dimensi terakhir paling sesuai dengan lebar bahu janin (diameter biacromial) selama persalinan normal melalui vagina.



Gambar 3.2 Pintu bawah panggul ginekoid dilihat dari bidang transversal (Gurewitsch Allen, 2024)

Pada proses turunnya janin saat persalinan, bidang pintu atas panggul dan pintu bawah panggul menjadi miring (membuat jalan lahir berbentuk silinder bengkok, bukan lurus) yang dapat dilihat pada pencitraan gambar di bawah ini:



Gambar 3.3 Pencitraan sagital panggul dan true pelvis/pelvis minor (Gurewitsch Allen, 2024)

Keterangan:

- A. Pencitraan sagital panggul dalam posisi tegak menggambarkan bahwa pintu atas panggul dan pintu bawah panggul tidak terletak pada bidang paralel.
- B. Rongga *true pelvis*/pelvis minor sebanding dengan silinder yang bengkok. Perhatikan kelengkungan sumbu panggul.

Pada mekanisme persalinan normal, terjadi *cardinal movements* atau rangkaian gerakan janin dalam melewati panggul. Kepala janin dan tubuhnya mengikuti gerakan berkelok-kelok, dengan penanda tulang janin (oksiput dan prosesus akromion) bersentuhan dengan penanda tulang panggul (sakrum promontorium, simfisis pubis, dan coccygeus). Awal melewati panggul, kepala janin dalam keadaan fleksi kemudian pada putaran paksi dalam, setiap kontraksi, kepala janin bergerak ke bawah lengkung pubis dan terjadi rotasi kepala saat mencapai otot panggul. Kepala janin akan defleksi ke arah anterior saat mencapai perineum. Mula-mula, oksiput melewati permukaan bawah simfisis pubis, dan setelah ekstensi, kepala keluar mengikuti sumbu jalan lahir. Ketika kepala janin lahir dengan oksiput anterior, terjadi putaran paksi luar disertai rotasi internal bahu bayi di mana bahu janin harus memutar hingga sejajar dengan diameter anteroposterior panggul (Gurewitsch Allen, 2024; Iversen et al., 2021).

Pada kasus di mana tubuh janin lebih besar dibandingkan dengan kepala (makrosomia) atau janin telah turun lebih jauh hingga menyentuh langsung simfisis pubis, seperti pada persalinan operatif atau penurunan janin yang sangat cepat, bahu janin mungkin akan berputar lebih lambat atau memiliki waktu yang lebih sedikit untuk berubah posisi selama fase restitusi kepala. Akibatnya, bahu janin bisa tetap berada dalam orientasi anteroposterior di pintu masuk panggul, bukan dalam

posisi miring yang seharusnya. Hal ini dapat meningkatkan risiko distosia bahu, karena bahu janin tidak dapat melewati jalan lahir dengan lancar setelah kepala lahir (Gurewitsch Allen, 2024).

Terdapat beberapa faktor risiko distosia bahu, baik yang muncul sebelum persalinan (antepartum) maupun saat persalinan berlangsung (intrapartum). Mengenali faktor-faktor ini sangat penting untuk mempertimbangkan kemungkinan operasi caesar elektif atau menentukan pengawasan lebih ketat selama fase persalinan, terutama saat janin memasuki panggul (Alves et al., 2022).

1. Faktor risiko antepartum

Faktor risiko utama sebelum persalinan (antepartum) meliputi:

- a. Makrosomia janin (berat lahir berlebih),
- b. Diabetes melitus,
- c. Riwayat distosia bahu pada persalinan sebelumnya,
- d. Kehamilan lewat waktu,
- e. Jenis kelamin janin laki-laki,
- f. Obesitas ibu atau kenaikan berat badan berlebihan selama kehamilan, serta
- g. Usia ibu yang lebih tua.

2. Faktor risiko intrapartum

Faktor risiko utama distosia bahu saat persalinan berlangsung (intrapartum) adalah gangguan pada tahap persalinan, seperti hambatan pembukaan serviks dan perlambatan turunnya janin ke panggul, serta persalinan pervaginam yang melibatkan alat bantu seperti forsep atau vakum ekstraktor. Gangguan pada fase persalinan di panggul, seperti perlambatan atau berhentinya pembukaan serviks, bukanlah indikator yang akurat untuk memprediksi distosia bahu. Namun, jika kondisi ini terjadi saat berat janin diperkirakan melebihi 4.000 gram dan persalinan pervaginam menggunakan alat bantu, maka risiko terjadinya distosia bahu dapat meningkat secara signifikan. Meskipun persalinan pervaginam dengan alat bantu sering dikaitkan dengan distosia bahu, hingga saat ini belum ada bukti yang menunjukkan bahwa penggunaan forsep atau vakum secara langsung meningkatkan kemungkinan bahu tersangkut. Demikian pula, posisi bahu janin yang kurang optimal sebelumnya tidak selalu menghambat turunnya janin, sehingga memerlukan alat bantu persalinan. Secara umum, risiko distosia bahu pada persalinan dengan forsep dan vakum ekstraktor cenderung sama.

Terdapat berbagai faktor risiko distosia bahu, namun hanya sedikit yang dapat diubah atau dicegah. Selain itu, evaluasi faktor risiko pada riwayat distosia bahu pada persalinan sebelumnya dapat menjadi lebih rumit. Pada kehamilan berikutnya, penting untuk mempertimbangkan faktor risiko ini saat merencanakan tata laksana

dan metode persalinan guna mengurangi kemungkinan terulangnya distosia bahu (Jeppgaard et al., 2024). Beberapa strategi yang dapat dilakukan untuk mengurangi risiko distosia bahu adalah mengontrol berat badan ibu sebelum dan selama kehamilan, serta menjaga kadar gula darah tetap stabil pada ibu hamil dengan diabetes (Alves et al., 2022).

Oleh karena itu, perubahan pola makan dan gaya hidup yang sehat menjadi langkah penting untuk mengurangi kemungkinan janin mengalami makrosomia, yang pada akhirnya dapat menurunkan angka kejadian distosia bahu, terutama pada ibu hamil dengan diabetes. Mengenali faktor-faktor ini sejak dini dapat membantu dokter dan bidan dalam menentukan strategi persalinan yang paling aman bagi ibu dan bayi.

D. Penatalaksanaan Distosia Bahu

Diagnosis dini dan penatalaksanaan segera dapat membuat luaran maternal dan neonatal menjadi lebih baik. Setelah distosia bahu didiagnosis, penting untuk tidak melakukan traksi tambahan apa pun, selain traksi lembut standar yang diperlukan untuk persalinan bahu pada kelahiran normal melalui vagina. Traksi yang berlebihan harus dihindari karena dapat mengakibatkan cedera serius pada ibu dan kerusakan neurologis parah pada bayi baru lahir. Kejadian hipoksia dan kematian janin dapat berkurang jika waktu antara lahirnya kepala dan badan kurang dari 5 menit (Gurewitsch Allen, 2024; Sancetta et al., 2019; Tsikouras et al., 2024).

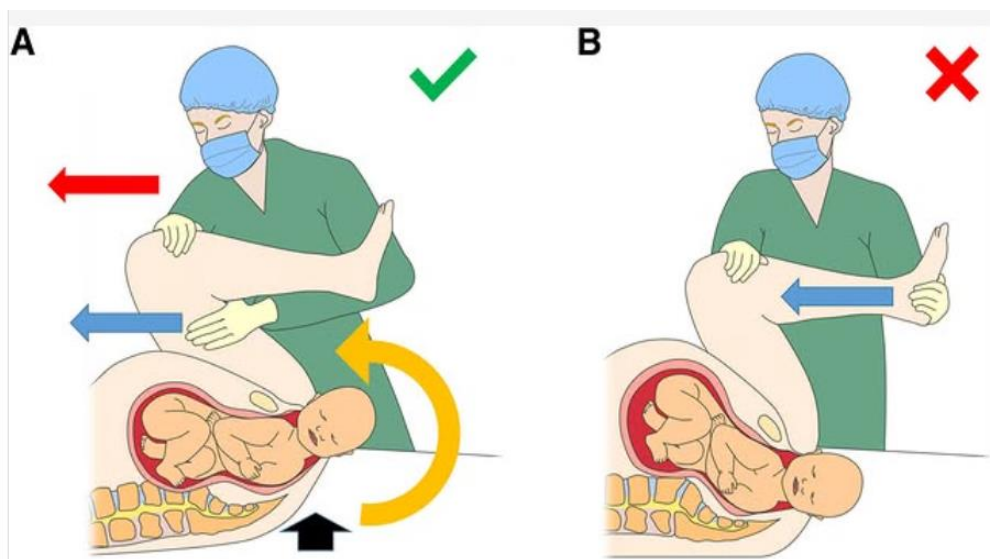
Penatalaksanaan distosia bahu memerlukan keterampilan dan tindakan manuver yang tepat agar tidak terjadi komplikasi yang meluas. Selain itu, tekanan fundus juga perlu dikurangi untuk mencegah dampak negatif lebih lanjut. Tindakan episiotomi perlu dipertimbangkan dan dievaluasi. Episiotomi tidak secara langsung menyelesaikan masalah namun dapat membantu memperluas jalan lahir untuk melakukan manipulasi intravaginal (Bothou et al., 2021; Gurewitsch Allen, 2024; Tsikouras et al., 2024).

Oleh karena itu, manuver obstetri dalam penanganan distosia bahu harus dilakukan oleh tenaga medis yang terlatih dan dengan dukungan tim yang berpengalaman. Menurut American Academy of Family Physicians (AAFP) dan Advanced Life Support in Obstetrics (ALSO) program, algoritma HELPER direkomendasikan sebagai alat klinis yang penting dalam menangani distosia bahu. *Help*, *Evaluate* (episiotomi), *Legs* (manuver Mc Roberts), *Pressure* (Suprapubik), *Enter* (manuver Rubin/Wood), *Remove* (lengan posterior), dan *Roll* (tangan dan lutut). Semua langkah teknis sama pentingnya dan harus dilaksanakan secara adekuat dengan setiap manipulasi dilakukan selama 30 hingga 60 detik (Tsikouras et al., 2024).

Secara historis, berbagai manuver untuk menangani distosia bahu telah diperkenalkan dalam berbagai literatur. Seiring waktu, teknik-teknik ini terus dikembangkan untuk meningkatkan efektivitas penanganan. Tujuan utama dari manuver obstetri ini adalah untuk memperluas ruang panggul ibu, mengurangi diameter biakromial janin, serta mengubah posisi biakromial di dalam panggul, sehingga proses persalinan dapat berlangsung lebih lancar. Penanganan distosia bahu memerlukan keterampilan dalam melakukan manuver yang tepat serta kehati-hatian untuk menghindari kesalahan, guna meminimalkan risiko cedera bagi ibu maupun bayi.

1. McRoberts maneuver

Manuver McRoberts diperkenalkan pada tahun 1983, melibatkan reposisi ibu, dan saat ini menjadi salah satu langkah pertama dan paling sederhana dalam menangani distosia bahu. Manuver ini dilakukan dengan cara paha ibu ditekuk dengan sedikit abduksi sehingga menyentuh perut sehingga terjadi peningkatan diameter anteroposterior panggul. Selama manuver, tempat tidur harus dalam posisi datar, dan semua bantal di bawah ibu harus dilepas. Bantuan dari staf medis di kedua sisi tempat tidur diperlukan untuk menekuk paha ibu dengan benar. Setelah posisi yang tepat tercapai, traksi lembut diterapkan untuk membantu melahirkan bahu anterior janin. 40% kasus distosia bahu berhasil diatasi dengan manuver ini. Jika dalam 30–60 detik persalinan tidak berhasil, maka manuver atau manipulasi lain perlu segera dilakukan untuk membantu proses kelahiran (Sancetta et al., 2019; Tsikouras et al., 2024).



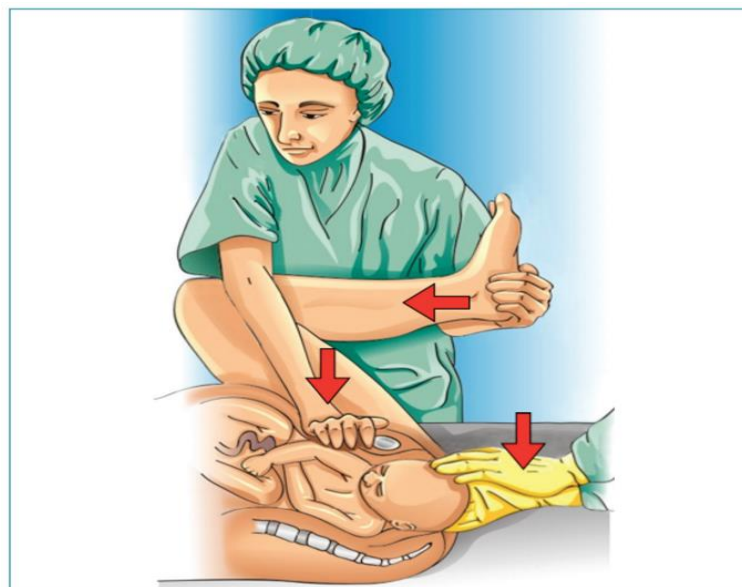
Gambar 3.4 McRobert Maneuver (Lau et al., 2024)

Keterangan:

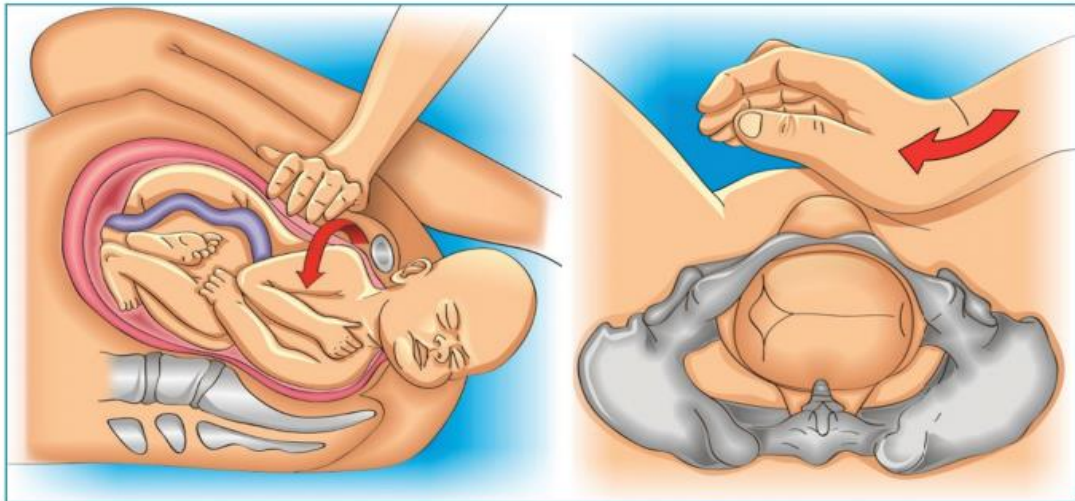
- A. Hiperfleksi panggul lebih efektif dengan menekan bagian belakang paha (panah biru). Penolong juga dapat bersandar ke arah yang sama (panah merah) untuk membantu hiperfleksi. Posisi McRoberts yang berhasil harus mengarah pada rotasi sefaloid panggul (panah melengkung berwarna oranye), yang terlihat dengan terangkatnya bokong ibu (panah hitam).
- B. Metode yang umum digunakan untuk melakukan hiperfleksi panggul, memegang kaki ibu dan melingkari lutut dan mendorong ke arah kepala ibu (panah biru). Kurang efektif dan menimbulkan rasa tidak nyaman pada pergelangan kaki.

2. Suprapubic pressure / Rubin maneuver I

Manuver ini merupakan aspek mendasar dalam penanganan distosia bahu. Dilakukan dengan cara pemberian tekanan suprapubik pada bahu anterior janin dengan tujuan untuk adduksi bahu. Awalnya, tekanan dilakukan terus menerus dan kemudian beralih ke pola ritmis, mirip dengan resusitasi jantung paru (Tsikouras et al., 2024). American College of Obstetricians and Gynecologists merekomendasikan untuk menggunakan manuver McRoberts dan tekanan suprapubik sebagai langkah awal penatalaksanaan distosia bahu. Ketika dikombinasikan dengan manuver McRoberts, tingkat keberhasilannya mencapai 24-62% (Lok et al., 2016; Sancetta et al., 2019).



Gambar 3.5 McRoberts dan Rubin I Maneuvers (Alves et al., 2022)



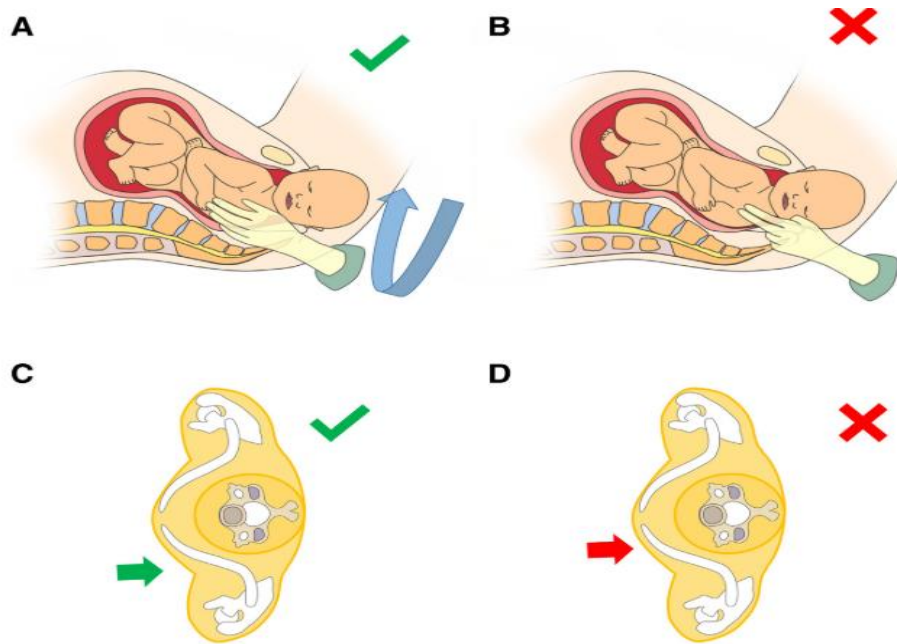
Gambar 3.6 Rubin I Maneuver (Alves et al., 2022)

3. Intravaginal maneuver

Selain manuver utama yang dijelaskan di atas, ada juga intravaginal manuver. Manuver ini dapat dilakukan bersamaan dengan manipulasi Rubin, manuver Woods Screw, manuver Woods Screw terbalik dengan cara tangan penolong dimasukkan ke belakang bahu anterior, memberikan tekanan ke arah dada janin untuk mengurangi diameter bahu.

4. The Woods Screw maneuver

Manuver ini ditemukan pertama kali oleh C.E. Woods pada tahun 1943 yaitu manipulasi intravaginal yang dilakukan bersamaan dengan manuver Rubin. Pada manuver ini, tangan penolong mendekati bahu posterior dari permukaan anterior janin, memperkuat upaya untuk memutar bahu searah dengan manipulasi Rubin. Manuver lainnya adalah dengan meletakkan tangan penolong di belakang bahu posterior dan di depan bahu anterior, kemudian memutar janin ke arah yang berlawanan dengan manipulasi sebelumnya (manuver Woods Screw terbalik). Manuver intravaginal lainnya adalah pergerakan anggota tubuh bagian atas posterior ke dalam saluran genital untuk mengurangi diameter bahu. Untuk melakukan manuver ini, penolong memasukkan tangannya ke dalam vagina untuk mencoba menjangkau ujung posterior atas janin. Setelah lengan bawah tercapai, siku ditekuk sehingga lengan bawah keluar di depan dada janin. Traksi dilakukan secara hati-hati untuk menghindari patahnya ekstremitas atas. Dengan cara ini, ekstremitas atas posterior keluar, dan bahu anterior keluar turun lebih rendah dari simfisis pubis.



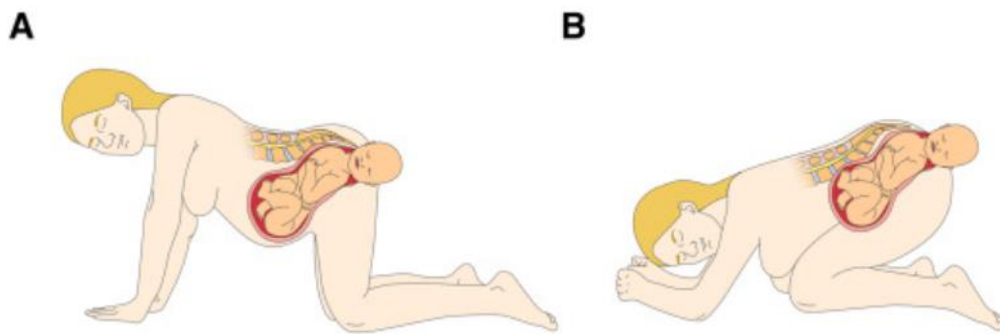
Gambar 3.7 *The Woods Screw maneuver* (Lau et al., 2024)

Keterangan:

- A. Seluruh tangan penolong dimasukkan cukup dalam sehingga telapak tangan dapat mengarahkan gaya rotasi secara merata pada dada anterior janin.
- B. Bila penolong hanya menggunakan 2 jari untuk menekan klavikula posterior janin, maka torsi menjadi kurang efektif dan risiko patah tulang klavikula meningkat. Torsi lebih efektif ketika tangan penolong menekan.
- C. Bagian lateral dinding dada anterior (panah hijau) dibandingkan
- D. Bagian medial dinding dada anterior (panah merah).

5. *All-fours position* dan *knee-chest position*

Jika manuver eksternal dan internal yang umum dilakukan gagal, beberapa guidelines merekomendasikan untuk mengulanginya sebelum melanjutkan ke all four position atau metode yang lebih traumatis, seperti kleidotomi atau simfisiotomi. Jika kegagalan tersebut disebabkan oleh kurangnya pengalaman atau teknik yang tidak tepat, seorang penolong yang berpengalaman dapat mencoba kembali manuver tersebut. Obesitas pada ibu mengurangi kemungkinan keberhasilan manuver eksternal. Kegagalan dalam meninggikan bokong ibu selama manuver McRoberts membuatnya tidak efektif. *All-four position* dan *Knee chest position* atau posisi merangkak, pada dasarnya merupakan kebalikan dari posisi McRobert, dapat menjadi alternatif dalam situasi seperti ini.



Gambar 3.8 *All-fours position* dan *Knee chest position* (Lau et al., 2024)

Keterangan:

- A. *All-fours position* atau posisi merangkak (posisi lutut-tangan). Tubuh ibu ditopang oleh tangan dan lututnya. Panggulnya semifleksi dan tulang belakangnya horizontal.
- B. *Knee chest position* atau posisi lutut-dada. Tubuh ibu ditopang oleh lengan dan lututnya. Oleh karena itu, panggul lebih tertekuk untuk mensimulasikan manuver McRoberts terbalik. Tulang belakang mengarah ke bawah menuju kepala.

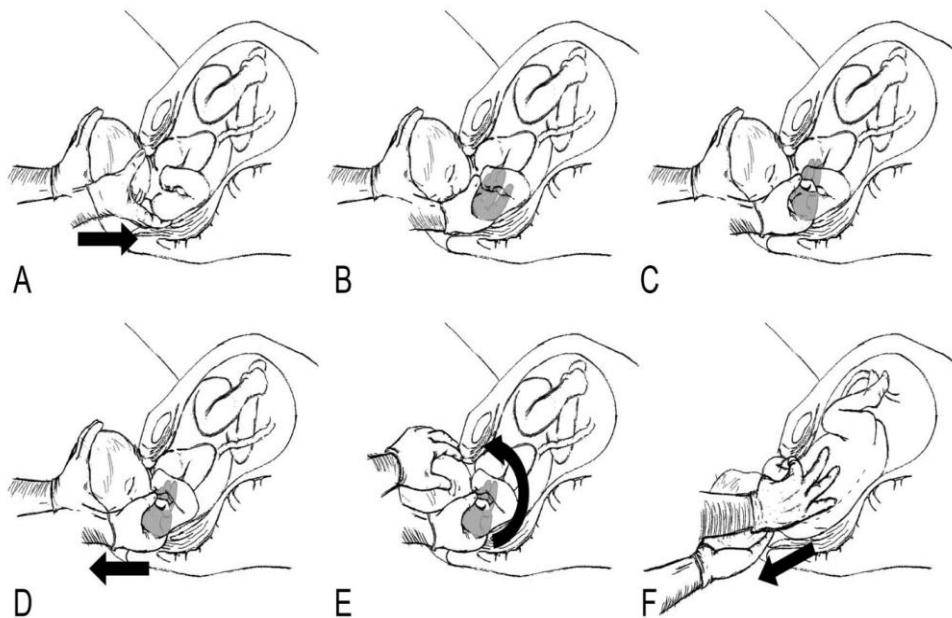
6. *Clavicle fracture*

Cara alternatif untuk mengatasi distosia bahu adalah fraktur klavikula. Selama manipulasi ini, tekanan ke atas diterapkan pada bagian tengah tulang selangka agar mencegah kerusakan pada pembuluh darah subklavia.

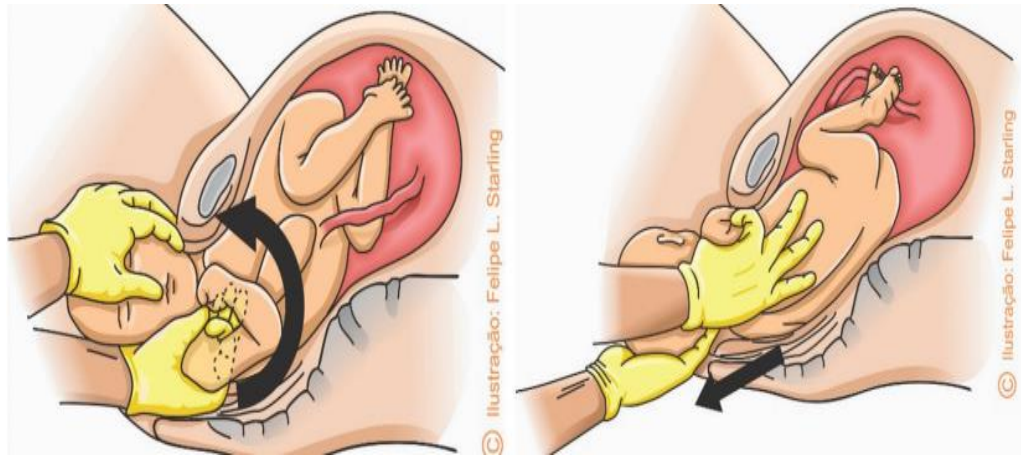
7. *Shoulder shrug maneuver*

Shoulder shrug maneuver atau teknik mengangkat bahu merupakan modifikasi dari manuver yang telah dijelaskan sebelumnya sebagai upaya mengatasi distosia bahu. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

- Pegang bahu posterior pada aksila dengan menggunakan ibu jari dan jari telunjuk penolong dalam genggamannya penjepit sehingga ujung ibu jari dan jari telunjuk menyatu pada fosa aksila.
- Tarik aksila ke arah kepala bayi untuk mengangkat bahu dan menarik kembali bahu ke arah lubang vagina.
- Pertahankan cengkeraman pada bahu yang mengangkat bahu dan gunakan tangan yang berlawanan, pegang kepala dan bahu yang ditarik bersama-sama sebagai satu kesatuan.
- Putar ke arah wajah neonatus 180 derajat (ini akan memungkinkan bahu anterior yang terkena impaksi berguling ke arah dada neonatus saat bergerak menuju posisi posterior). Jika tidak dapat memutar ke arah wajah, dapat dicoba arah sebaliknya.
- Selama bahu yang diangkat tetap inferior terhadap simfisis pubis, maka bahu tersebut dapat dilahirkan ke anterior.
- Kemudian lanjutkan dengan kelahiran sisa bahu di bagian posterior. Saat rotasi, bahu anterior yang terjebak harus dapat dilahirkan di bagian posterior.



Gambar 3.9 Langkah-langkah *Shoulder Shrug Maneuver*
(Sancetta et al., 2019)



Gambar 3.10 langkah E dan F pada *shoulder shrug Maneuver* (Alves et al., 2022)

Manuver ini telah terbukti efektif dalam menangani distosia bahu pada tiga kasus, di mana bahu posterior berhasil diangkat untuk memperlancar persalinan dan juga dapat dilakukan dengan cepat sehingga mengurangi risiko morbiditas pada bayi baru lahir. Oleh karena itu, layak dipertimbangkan sebagai salah satu pilihan dalam penanganan distosia bahu yang sulit diatasi (Sancetta et al., 2019).

E. Simpulan

Distosia bahu merupakan komplikasi persalinan yang dapat terjadi pada persalinan normal ketika bahu janin mengalami kesulitan untuk melewati simfisis pubis ibu setelah kepala lahir. Meskipun insidensinya relatif rendah, kondisi ini dapat menyebabkan komplikasi serius bagi ibu dan bayi, seperti trauma lahir, cedera plexus brakialis, fraktur klavikula, hingga asfiksia neonatal. Pada persalinan normal, distosia bahu sering kali tidak terdeteksi sebelumnya, sehingga penanganan yang cepat dan tepat sangat penting. Identifikasi faktor risiko, seperti makrosomia janin, diabetes gestasional, dan riwayat distosia bahu sebelumnya, dapat membantu tenaga medis dalam mengantisipasi kejadian ini. Teknik manuver obstetri, seperti McRoberts, tekanan suprapubik, Rubin, dan Woods, terbukti efektif dalam mengatasi distosia bahu dan meminimalkan risiko komplikasi. Oleh karena itu, dalam praktik persalinan normal, tenaga kesehatan khususnya bidan harus memiliki keterampilan dalam mengenali dan menangani distosia bahu secara efektif. Pelatihan rutin serta penerapan prosedur klinis berbasis bukti sangat penting untuk keamanan ibu dan bayi selama proses persalinan.

F. Referensi

Alves, Á. L. L., Nozaki, A. M., Polido, C. B. A., & Knobel, R. (2022). Management of Shoulder Dystocia. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, 44(7). <https://doi.org/10.1055/s-0042-1755446>

- Bothou, A., Apostolidi, D. M., Tsikouras, P., Iatrakis, G., Sarel-la, A., Iatrakis, D., Peitsidis, P., Gerente, A., Anthoulaki, X., Nikolettos, N., & Zervoudis, S. (2021). Overview of techniques to manage shoulder dystocia during vaginal birth. *European Journal of Midwifery*, 5(October), 1–6. <https://doi.org/10.18332/ejm/142097>
- Cal Shipley, M. . (2020). *Turtle Sign in Shoulder Dystocia*. <https://trialimage.com/home-page/stock-medical-animation/obstetrical-animation-library/turtle-sign-in-shoulder-dystocia-video/>
- Gurewitsch Allen, E. (2024). Prescriptive and proscriptive lessons for managing shoulder dystocia: a technical and videographical tutorial. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 230(3), S1014–S1026. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2022.03.016>
- Heinonen, K., Saisto, T., Gissler, M., & Sarvilinna, N. (2024). Maternal and neonatal complications of shoulder dystocia with a focus on obstetric maneuvers: A case–control study of 1103 deliveries. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, January, 1965–1974. <https://doi.org/10.1111/aogs.14780>
- Iversen, J. K., Kahrs, B. H., & Eggebø, T. M. (2021). There are 4, not 7, cardinal movements in labor. *American Journal of Obstetrics and Gynecology MFM*, 3(6), 100436. <https://doi.org/10.1016/j.ajogmf.2021.100436>
- Jeppegaard, M., Larsen, M. H., Thams, A. B., Schmidt, A. B., Rasmussen, S. C., & Krebs, L. (2024). Incidence of shoulder dystocia and risk factors for recurrence in the subsequent pregnancy—A historical register-based cohort study. *Acta Obstetrica et Gynecologica Scandinavica*, December 2023, 1975–1984. <https://doi.org/10.1111/aogs.14784>
- Lau, S. L., Sin, W. T. A., Wong, L., Lee, N. M. W., Hui, S. Y. A., & Leung, T. Y. (2024). A critical evaluation of the external and internal maneuvers for resolution of shoulder dystocia. *American Journal of Obstetrics and Gynecology*, 230(3), S1027–S1043. <https://doi.org/10.1016/j.ajog.2023.01.016>
- Lok, Z. L. Z., Cheng, Y. K. Y., & Leung, T. Y. (2016). Predictive factors for the success of McRoberts' manoeuvre and suprapubic pressure in relieving shoulder dystocia: A cross-sectional study. *BMC Pregnancy and Childbirth*, 16(1), 1–7. <https://doi.org/10.1186/s12884-016-1125-3>
- Michelotti, F., Flatley, C., & Kumar, S. (2018). Impact of shoulder dystocia, stratified by type of manoeuvre, on severe neonatal outcome and maternal morbidity. *Australian and New Zealand Journal of Obstetrics and Gynaecology*, 58(3), 298–305. <https://doi.org/10.1111/ajo.12718>
- Sancetta, R., Khanzada, H., & Leante, R. (2019). Shoulder Shrug Maneuver to Facilitate Delivery During Shoulder Dystocia. *Obstetrics and Gynecology*, 133(6), 1178–1181. <https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000003278>
- The American College of Obstetricians and Gynecologists. (2017). Shoulder Dystocia.

Obstetrics & Gynecology, 129(5), 123–133.
<https://doi.org/10.1097/AOG.0000000000002043>

Tsikouras, P., Kotanidou, S., Nikolettos, K., Kritsotaki, N., Bothou, A., Andreou, S., Nalmpanti, T., Chalkia, K., Spanakis, V., Peitsidis, P., Iatrakis, G., & Nikolettos, N. (2024). Shoulder Dystocia: A Comprehensive Literature Review on Diagnosis, Prevention, Complications, Prognosis, and Management. *Journal of Personalized Medicine*, 14(6), 1–19.
<https://doi.org/10.3390/jpm14060586>

G. Glosarium

AAFP = American Academy of Family Physicians

ALSO = Advanced Life Support in Obstetrics

CPD = *Chepalopelvic Disproportion*

HELPERR = *Help, Evaluate, Legs, Pressure, Enter, Remove, Roll*

CHAPTER 4

OPTIMALISASI IMD (INISIASI MENYUSUI DINI)

Umu Qonitun, S.ST., M.Keb., M.M.

A. Pendahuluan

Sebagian besar dari masalah bayi baru lahir adalah spesifik timbul pada periode perinatal. Masalah-masalah ini bukan hanya bisa menyebabkan kematian, tetapi juga besarnya angka kecacatan dan angka penyakit. Masalah ini salah satunya disebabkan oleh kebersihan yang tidak terjaga selama proses kelahiran, kurangnya asuhan BBL serta asuhan yang pilih kasih. Kematian dikalangan bayi baru lahir sudah demikian seringnya hingga hal tersebut diterima sebagai suatu hal yang rutin oleh masyarakat.

Negara berkembang masih dihadapkan dengan permasalahan Angka Kematian Bayi, Pada tahun 2015 AKABA sebesar 26,29 per 1000 kelahiran hidup. Namun target SDG's pada tahun 2030 menurunkan AKN menjadi < 12 per 1000 kelahiran hidup, AKABA menjadi <25 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini tentu masih menjadi tantangan Indonesia untuk mencapai target SGD's. Pencapaian target akan terwujud apabila faktor kematian yang berperan penting terkendali. (Kementerian Kesehatan RI, 2012).

Salah satu faktor yang berperan penting dalam permasalahan ini adalah kecukupan gizi selain peran penting dari pola asuh, budaya dan lingkungan. Sumber kecukupan gizi saat anak baru lahir adalah berasal dari Air Susu Ibu (ASI). Manfaat pemberian ASI banyak memberikan asupan gizi dan sebagai perlindungan bagi bayi baru lahir untuk melawan penyakit infeksi, kekebalan tubuh bayi, kecerdasan, perkembangan sel-sel, jaringan dan organ-organ bayi terutama perkembangan otak bayi. Pemberian ASI dimulai dari adanya Inisiasi Menyusui Dini yaitu segera setelah bayi dilahirkan hingga ASI Eksklusif yaitu pemberian ASI hingga usia 6 bulan (Lionita, W.,dkk., 2016; Santi, M.Y., 2017).

IMD yaitu bayi mulai menyusu sendiri segera setelah lahir. Dengan meletakkan bayi baru lahir tengkurap di dada ibu dalam waktu minimal 1 jam hingga menimbulkan kontak kulit ibu dan kulit bayi sampai dapat menyusu sendiri, hentakan kepala bayi ke dada ibu, sentuhan tangan bayi di putting susu dan sekitarnya, emutan dan jilatan bayi pada putting ibu merangsang pengeluaran hormon oksitosin, dimana hormon oksitosin membantu uterus berkontraksi sehingga membantu mempercepat pelepasan dan pengeluaran ari-ari (placenta)

dan menurunkan resiko pendarahan pasca persalinan serta mempercepat kembalinya uterus ke bentuk semula hormon oksitosin juga merangsang produksi hormon lain yang membuat ibu menjadi lebih rileks, lebih mencintai bayinya, meningkatkan ambang nyeri, dan perasaan sangat bahagia. (Sondakh, 2013).

Srigati (2016) menuliskan bahwa tercapainya pemberian ASI eksklusif diperlukan pengetahuan dan motivasi dari seorang ibu. Ibu yang memiliki pengetahuan dan motivasi kuat, maka ibu tersebut akan berusaha memberikan ASI saja selama 6 bulan kepada bayinya. Ibu tersebut tahu dan paham bahwa manfaat yang akan diterima bayinya jika bayi diberikan ASI eksklusif, sehingga pemahaman pengetahuan mendorong timbulnya motivasi. Dengan kata lain ibu yang tidak memberikan ASI eksklusif boleh jadi ibu memiliki pengetahuan yang kurang tentang pentingnya pemberian ASI eksklusif sehingga motivasi ibu memberikan ASI eksklusif juga rendah.

Proverawati dan Rahmawati (2012) menuliskan motivasi juga bisa muncul dari dukungan suami, orang tua, ibu mertua, dan keluarga lainnya sangat diperlukan agar upaya pemberian ASI eksklusif selama enam bulan bisa berhasil. Ibu bekerja tetap bisa memberikan ASI sebelum berangkat kerja. Selain keluarga, bidan juga mempunyai peranan yang sangat penting dalam menunjang pemberian ASI dan keberhasilan menyusui (Martalia, 2012).

B. Inisiasi Menyusu Dini

1. Definisi Inisiasi Menyusu Dini

Inisiasi Menyusu Dini atau disingkat sebagai IMD merupakan program yang sedang gencar dianjurkan pemerintah. Menyusu dan bukan menyusui merupakan gambaran bahwa IMD bukan program ibu menyusui bayi tetapi bayi yang harus aktif menemukan sendiri puting susu ibu. Program ini dilakukan dengan cara langsung meletakkan bayi yang baru lahir di dada ibunya dan membiarkan bayi ini merayap untuk menemukan puting susu ibu untuk menyusui. IMD harus dilakukan langsung saat lahir, tanpa boleh ditunda dengan kegiatan menimbang atau mengukur bayi. Bayi juga tidak boleh dibersihkan, hanya dikeringkan kecuali tangannya. Proses ini harus berlangsung skin to skin antara bayi dan ibu.

Dalam mendukung program Pemerintah Indonesia sesuai dengan kebijakan WHO dan UNICEF yang merekomendasikan inisiasi menyusui dini sebagai tindakan “penyelamatan kehidupan”, dengan inisiasi menyusui dini ini, dapat menyelamatkan 22% dari bayi yang meninggal sebelum usia satu bulan. Menyusui satu jam pertama kehidupan yang diawali dengan kontak kulit antara ibu dan bayi sangat penting bagi kelangsungan hidup si bayi selanjutnya.

IMD mulai diperkenalkan kepada masyarakat pada akhir tahun 2007, karena IMD diharapkan mampu mengurangi jumlah bayi yang tidak mendapat kolostrum pada satu jam pertama. Data hasil Survei Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI) 1997 menyebutkan bahwa hanya 8,3% bayi yang disusui dalam satu jam pertama setelah lahir dari 52,7% bayi yang disusui dalam 24 jam pertama. Sedangkan pada SDKI 2002-2003 hanya 38,7 % balita mendapat ASI pertama satu jam setelah lahir dari 95,9% balita sudah mendapat ASI.

Inisiasi Menyusu Dini (IMD) adalah dengan meletakkan bayi baru lahir di atas perut ibu atau dada ibu, dalam waktu hampir satu jam bayi akan merangkak mencari puting susu ibunya dan mulai menyusui sendiri. Cara bayi melakukan inisiasi menyusui dini dinamakan the breast crawl atau merangkak mencari payudara.¹ Inisiasi menyusui dini dengan memberikan ASI segera setelah bayi dilahirkan, biasanya dalam waktu 30 menit-1 jam

pasca bayi dilahirkan. Tujuan IMD adalah kontak kulit dengan kulit membuat ibu dan bayi lebih tenang, saat IMD bayi menelan bakteri baik dari kulit ibu yang akan membentuk koloni di kulit dan usus bayi sebagai perlindungan diri, kontak kulit dengan kulit ibu dan bayi akan meningkatkan ikatan kasih sayang ibu dan bayi, mengurangi perdarahan setelah melahirkan serta mengurangi terjadinya anemia.

2. Cara Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

IMD merupakan langkah yang sangat baik untuk memudahkan bayi dan ibu dalam memulai proses menyusui. Berbagai macam keuntungan didapatkan dari proses baik untuk ibu maupun bayi :

- a. Segera setelah bayi lahir dan diputuskan tidak memerlukan resusitasi, letakkan bayi di atas perut ibunya (bila sectio, bayi diletakkan di atas dada) dan keringkan bayi mulai dari muka, kepala, dan bagian tubuh lainnya kecuali kedua tangannya. Bau cairan amnion pada tangan bayi akan membantunya mencari puting ibu yang mempunyai bau yang sama. Maka agar baunya tetap ada, dada ibu juga tidak boleh dibersihkan. Mengeringkan tubuh bayi tidak perlu sampai menghilangkan verniks karena verniks dapat berfungsi sebagai penahan panas pada bayi.
- b. Setelah tali pusat dipotong dan diikat, tengkurapkan bayi di atas perut ibu dengan kepala bayi menghadap ke arah kepala ibunya.
- c. Kalau ruang bersalin dingin, berikan selimut yang akan menyelimuti ibu dan bayinya, dan kenakan topi pada kepala bayi.
- d. Pengamatan oleh Windstrom, Righard dan Alade memperlihatkan bahwa bayi-bayi yang tidak mengalami sedasi mengikuti suatu pola perilaku prefeeding yang dapat diprediksi. Apabila bayi dibiarkan tengkurap di perut ibu, selama

beberapa waktu bayi akan diam saja tetapi tetap waspada melihat sekelilingnya.

- e. Setelah 12-44 menit bayi akan mulai bergerak dengan menendang, menggerakkan kaki, bahu dan lengannya. Stimulasi ini akan membantu uterus untuk berkontraksi. Meskipun kemampuan melihatnya terbatas, bayi dapat melihat areola mammae yang berwarna lebih gelap dan bergerak menuju ke sana. Bayi akan membentur-benturkan kepalanya ke dada ibu. Ini merupakan stimulasi yang menyerupai pijatan pada payudara ibu.
- f. Bayi kemudian mencapai puting dengan mengandalkan indera penciuman dan dipandu oleh bau pada kedua tangannya. Bayi akan mengangkat kepala, mulai mengulum puting, dan mulai menyusui. Hal tersebut dapat tercapai antara 27 - 71 menit.
- g. Pada saat bayi siap untuk menyusui, menyusui pertama berlangsung sebentar, sekitar 15 menit, dan setelah selesai, selama 2-2,5 jam berikutnya tidak ada keinginan bayi untuk menyusui. Selama menyusui bayi akan mengkoordinasi gerakan menghisap, menelan, dan bernapas.
- h. Setelah usai tindakan inisiasi menyusui dini ini, baru tindakan asuhan keperawatan seperti menimbang, pemeriksaan antropometri lainnya, penyuntikkan vitamin K1, dan pengoleskan salep pada mata bayi dapat dilakukan.
- i. Tunda memandikan bayi paling kurang 6 jam setelah lahir atau pada hari berikut.
- j. Bayi tetap berada dalam jangkauan ibunya agar dapat disusukan sesuai keinginan bayi (rooming in / rawat gabung).

3. Tujuan Inisiasi Menyusui Dini (IMD)

Dalam publikasi oleh breastcrawl.org yang berjudul Breast Crawl: A Scientific Overview dalam buku Yesie Aprilia (2010) ada beberapa hal yang menyebabkan bayi mampu menemukan sendiri puting ibunya dan mulai menyusui, yaitu:

- a. Sensory inputs yaitu terdiri dari indra penciuman (bayi sensitif terhadap bau khas ibunya setelah melahirkan), indra penglihatan (karena bayi baru dapat mengenal pola hitam dan putih, bayi akan mengenali puting dan wilayah areola payudara ibunya karena warna gelapnya), indra pengecap (bayi mampu merasakan cairan amniotik yang melekat pada jari-jari tangannya sehingga ia suka menjilati jarinya sendiri saat baru lahir), indra pendengaran (sejak dari dalam kandungan ia paling mengenal suara ibunya), dan indra perasa (dilakukan melalui sentuhan kulit ke kulit. Ini adalah sensasi pertama antara ibu dan bayi yang memberi kehangatan dan rangsangan lainnya).

- b. Central component yaitu otak bayi yang baru lahir sudah siap untuk segera mengeksplorasi lingkungannya, dan lingkungan yang paling dikenalnya adalah tubuh ibunya.
- c. Motor outputs yaitu gerak bayi yang merangkak di atas tubuh ibunya adalah gerak yang paling alamiah yang dapat dilakukan bayi setelah lahir. Gerakan ini juga memberi manfaat pada ibu, misalnya mendorong pelepasan plasenta dan mengurangi perdarahan pada rahim.

4. Manfaat Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

a. Pemberian Nutrisi yang Optimal

Inisiasi Menyusui Dini memungkinkan bayi untuk segera mendapatkan Air Susu Ibu (ASI) yang kaya akan nutrisi penting dan melindungi bayi dari infeksi. ASI mengandung zat-zat penting yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan bayi

b. Membangun Ikatan Emosional

Kontak kulit-kulit dan proses ini membantu membangun ikatan emosional antara ibu dan bayi. Sentuhan dan kontak langsung ini penting untuk memperkuat hubungan emosional yang saling mendukung.

c. Stimulasi Untuk Memulai Menyusui

Inisiasi Menyusui Dini merangsang bayi untuk mulai menyusui, membantu mempercepat respons bayi dalam mencari puting dan mengisap ASI, yang pada gilirannya dapat mendukung produksi ASI yang cukup dan lancar.

d. Perlindungan Kesehatan

ASI yang diberikan sejak dini dapat memberikan perlindungan kekebalan pada bayi melalui antibodi dan zat-zat penting lainnya yang membantu melawan infeksi dan penyakit.

e. Mendukung Kesehatan Ibu

Menyusui juga memiliki manfaat bagi kesehatan ibu, seperti membantu uterus kembali ke ukuran semula lebih cepat dan mengurangi risiko pendarahan pasca persalinan. Selain itu, menyusui juga dapat membantu ibu dalam mengurangi risiko kanker payudara dan ovarium

5. Apa yang terjadi pada Bayi selama proses IMD

Saat menjalani Inisiasi Menyusui Dini (IMD), bayi mengalami serangkaian tindakan dan reaksi yang merupakan bagian dari proses interaksi awal antara ibu dan bayi:

- a. Tangisan Awal: Awalnya, bayi mungkin akan menangis sesaat setelah lahir. Namun, tangisan ini biasanya berlangsung sebentar.

- b. Relaksasi dan Respons Terhadap Suara: Kemudian, bayi memasuki tahap relaksasi, di mana ia akan berhenti menangis dan mulai merespons suara ibunya. Bayi juga bisa mulai bangun dan membuka mata.
- c. Pergerakan Tubuh: Bayi mulai bergerak secara perlahan, dengan gerakan awal di lengan, wajah, dan kepala. Seiring waktu, gerakan ini semakin meningkat, dan bayi bisa bergerak ke arah payudara ibu.
- d. Pendekatan ke Payudara: Begitu sampai di area payudara, bayi mungkin akan berhenti sejenak untuk beristirahat, bukan karena tidak lapar, tetapi sebagai bagian dari proses penyesuaian.
- e. Mengeksplorasi Payudara: Setelah istirahat, bayi akan mulai mengamati dan mengeksplorasi payudara ibu, mencium, menjilat, dan mengamati area tersebut sebagai langkah mempersiapkan diri untuk menyusui.
- f. Menemukan Puting Payudara: Proses ini memerlukan waktu di mana bayi secara bertahap akan mencari puting payudara ibu untuk mulai menyusui.

6. Hambatan dalam pelaksanaan Inisiasi Menyusu Dini (IMD)

Berikut ini beberapa pendapat yang dapat menghambat terjadinya kontak dini kulit ibu dengan kulit bayi :

- a. Bayi kedinginan – tidak benar
Bayi berada dalam suhu yang aman jika melakukan kontak kulit dengan sang ibu. Menakjubkan! Suhu payudara ibu meningkat $0,5^{\circ}$ dalam 2 menit jika bayi diletakkan didada ibu. Menurut penelitian Niels Bergman dari Afrika Selatan, kulit dada ibu yang melahirkan 1° lebih panas dari ibu yang tidak melahirkan. Jika bayinya kedinginan, suhu kulit ibu otomatis naik 2° untuk menghangatkan bayi. Jika bayi kepanasan, maka suhu kulit ibu otomatis turun 1° untuk mendinginkan bayinya. Kulit ibu bersifat termoregulator atau thermal synchrony bagi suhu bayi.
- b. Setelah melahirkan, ibu terlalu lelah untuk segera menyusui bayinya – tidak benar
Seorang ibu jarang terlalu lelah untuk memeluk bayinya segera setelah lahir. Keluarnya oksitosin saat kontak kulit ke kulit serta saat bayi menyusui dini membantu menenangkan ibu
- c. Tenaga kesehatan kurang tersedia – tidak benar
Saat bayi didada ibu, penolong persalinan dapat melanjutkan tugasnya. Bayi dapat menemukan sendiri payudara ibu. Libatkan suami atau keluarga terdekat untuk menjaga bayi sambil memberi dukungan pada ibu

- d. Kamar bersalin atau kamar operasi sibuk – tidak benar
Dengan bayi didada ibu, ibu dapat dipindahkan ke ruang pulih atau kamar perawatan. Beri kesempatan pada bayi untuk meneruskan usahanya mencapai payudara dan menyusui dini
- e. Ibu harus dijahit – tidak masalah
Kegiatan merangkak mencari payudara terjadi diareal payudara, yang dijahit adalah bagian bawah tubuh ibu
- f. Bayi harus segera dibersihkan, dimandikan, ditimbang dan diukur – tidak benar
Menunda memandikan bayi berarti menghindarkan hilangnya panas badan bayi. Selain itu, vernix meresap, melunakkan dan melindungi kulit bayi lebih besar, Bayi dapat dikeringkan segera setelah lahir, penimbangan dan pengukuran dapat ditunda sampai menyusui awal selesai
- g. Bayi kurang siaga – tidak benar
Justru pada 1-2 jam pertama kelahirannya, bayi sangat siaga (alert). Setelah itu, bayi tidur dalam jangka waktu yang lama. Jika bayi mengantuk akibat obat yang diasup ibu, kontak kulit akan lebih penting karena bayi memerlukan bantuan lebih untuk bonding
- h. Kolostrum tidak keluar atau jumlah kolostrum tidak memadai sehingga diperlukan cairan lain (cairan pre-laktal) – tidak benar
Kolostrum cukup dijadikan makanan pertama bayi baru lahir. Bayi dilahirkan dengan membawa bekal air gula yang dapat dipakai pada saat itu. Kolostrum sangat diperlukan untuk tumbuh kembang bayi, selain itu juga sebagai imunisasi pertama dan mengurangi kuning pada bayi baru lahir, melindungi dan mematangkan dinding usus yang masih muda.

C. Kesimpulan

Melakukan IMD membutuhkan kesabaran, dukungan, dan kesempatan bagi ibu dan bayi untuk menjalin hubungan yang baik serta memulai proses menyusui dengan lancar. Dalam hal ini, bantuan dari petugas kesehatan atau konselor laktasi sangatlah penting untuk membantu ibu dan bayi memulai perjalanan menyusui dengan sukses.

D. Referensi

- Buku panduan Peserta, pelatihan asuhan persalinan Normal Bahan tambahan Inisiasi menyusui Dini, JNPK-KR/POGI dan IDAI dengan dukungan dari USAID. 2018
- IDAI. Inisiasi Menyusui Dini. (2013). [Idai.or.id](https://www.idai.or.id).
<https://www.idai.or.id/artikel/klinik/asi/inisiasi-menyusui-dini>. (Diakses pada 21 Desember 2023).

- Proverawati, A & Rahmawati, E. 2012. Kapita Selekta ASI & Menyusui. Yogyakarta: Nuha Medika.
- Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) (2018). Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementerian RI tahun 2018. http://www.depkes.go.id/resources/download/infoterkini/materi_rakorpop_2018/Hasil%20Riskesdas%202018.pdf – Diakses Oktober 2020
- Skin-to-skin contact - Baby Friendly Initiative. Baby Friendly Initiative. <https://www.unicef.org.uk/babyfriendly/baby-friendly-resources/implementing-standards-resources/skin-to-skin-contact/>. Diakses pada 21 Desember 2023).
- Srigati, dkk. 2016. Hubungan Pengetahuan dan Motivasi Ibu terhadap Pemberian ASI Eksklusif di Desa Jono'Oge. Jurnal Kesehatan Tadulako Vol. 2 No.1, Januari 2016: 1-75.

E. Glosarium

- ASI Eksklusif : pemberian hanya ASI saja kepada bayi tanpa penambahan makanan dan minuman lain, kecuali obat dan vitamin dalam bentuk sirup jika dibutuhkan
- Kolostrum : cairan susu yang keluar pertama kali dari payudara ibu pada beberapa hari pertama setelah melahirkan

CHAPTER 5

STRATEGI PENCEGAHAN LASERASI PERINEUM (PRAKTIK DAN TANTANGAN)

Bdn. Lilis Suryani, SST., M.Keb.

A. Pendahuluan

Laserasi perineum merupakan salah satu komplikasi yang paling sering terjadi selama proses persalinan pervaginam. Cedera ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan fisik ibu pascapersalinan, tetapi juga dapat menimbulkan konsekuensi jangka panjang seperti nyeri kronis, disfungsi seksual, hingga gangguan kontinensia. Oleh karena itu, upaya pencegahan laserasi perineum menjadi fokus penting dalam praktik kebidanan dan keperawatan maternitas.

Strategi pencegahan laserasi telah mengalami banyak perkembangan, baik dari segi pendekatan non-invasif, teknik penanganan saat persalinan, hingga kebijakan klinis yang mendukung perawatan berpusat pada ibu. Praktik-praktik seperti massage perineum antenatal, teknik "hands on" atau "hands off" saat persalinan, kompres hangat, serta pendekatan komunikatif yang empatik terhadap ibu, telah banyak diteliti dan diterapkan dengan hasil yang bervariasi.

Meski demikian, pelaksanaan strategi-strategi tersebut tidak lepas dari tantangan. Faktor-faktor seperti kurangnya pelatihan tenaga kesehatan, resistensi terhadap perubahan praktik tradisional, keterbatasan sumber daya, serta kondisi klinis yang tidak selalu ideal, menjadi kendala tersendiri dalam menerapkan upaya pencegahan secara efektif dan konsisten.

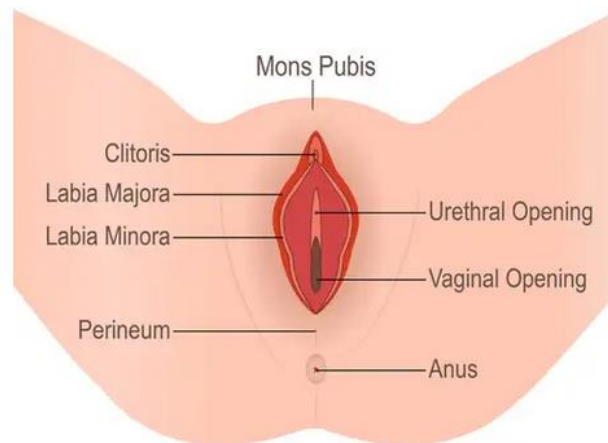
Dalam pembahasan ini, akan diuraikan berbagai strategi yang telah terbukti efektif dalam mencegah laserasi perineum, sekaligus mengkaji tantangan-tantangan yang dihadapi dalam implementasinya di berbagai setting pelayanan kesehatan. Dengan pemahaman yang komprehensif, diharapkan tenaga kesehatan dapat lebih siap dalam mengintegrasikan strategi-strategi tersebut ke dalam praktik klinis, guna mendukung keselamatan dan kesejahteraan ibu selama proses persalinan.

B. Anatomi Perineum

Perineum adalah otot, kulit, dan jaringan yang ada diantara kelamin dan anus. Jaringan utama yang menopang perineum adalah diafragma pelvis dan urogenitale. Diafragma pelvis terdiri dari muskulus levator ani dan muskulus koksigeus di bagian posterior serta selubung fasia dari otot – otot ini. Muskulus levator ani membentuk

sabuk otot lebar yang berorigo dari permukaan posterior ramus pubis superior, dari permukaan dalam spina iskiadika, dan dari fasia obturatoria yang terletak diantara keduanya.

Perineum terdiri atas diagram urogenital dan bagian bawah dari genetalia eskterna. Regio urogenital berhubungan dengan pembukaan dari sistem urinaria dan system reproduksi. Secara fisiologis, saat kepala janin menyembul di vagina perineum akan secara otomatis menegang dan menipis untuk dapat di lewati bayi dengan aman.



Gambar 5.1 Anatomi Perineum Wanita

Batas batas perineum antara lain:

1. Superior: Dasar panggul terdiri dari M. Levator dan M. Coccygeus
2. Lateral: Tulang dan ligament yang membantuk pintu bawah panggul (exitus pelvis) yakni dari depan ke belakang angulus subpubicus, ramus ishiopubicus, tuber ischiadicum, ligament sacroberosum, os. Coccygis.
3. Inferior: Kulit dan fascia

C. Ruptur Perineum

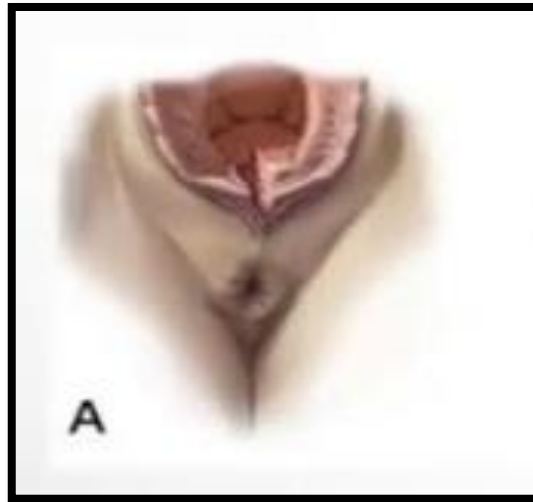
Ruptur perineum dengan tingkat derajadnya masing masing merupakan komplikasi pada proses persalinan. Pada tingkat derajad tiga dan empat disebut dengan cedera sfingter ani atau dalam bahasa Inggris disebut *Obstetri Anal Sphincter Injuries* (OASIS). Cedera sfingter ani hingga anus sfingter dan mukosa anus merupakan trauma perineum parah. Cedera sfingter merupakan penyebab umum inkontinensia anal pada wanita usa reproduksi.

Menurut World Health Organization (WHO) terdapat 2,7 juta kasus ruptur perineum dalam masyarakat, 50% dari kejadian ruptur perineum di dunia (3). Dari data kementrian Kesehatan menyatakan kejadian ruptur perineum di Indonesia dialami oleh 5% ibu melahirkan pervaginam. Ruptur perineum terjadi karena beberapa faktor, salah satunya faktor janin penyebabnya adalah berat badan bayi

lahir, posisi kepala abnormal, ekstraksi forcep yang sukar, distosia bahu, dan anomaly congenital seperti hydrocephalus (4).

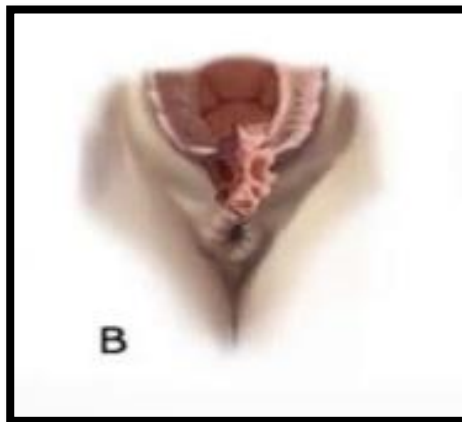
Tingkatan Derajat Ruptur Perineum antara lain sebagai berikut :

1. Derajat I dengan batasan mukosa vagina, fourcette posterior, sampai kulit perineum



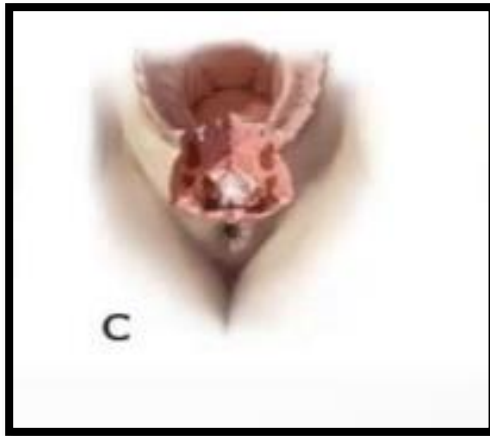
Gambar 5.2 Derajat I Rupture Perineum

2. Derajat II dengan batasan mukosa vagina, fourcette posterior, kulit perineum sampai otot perineum



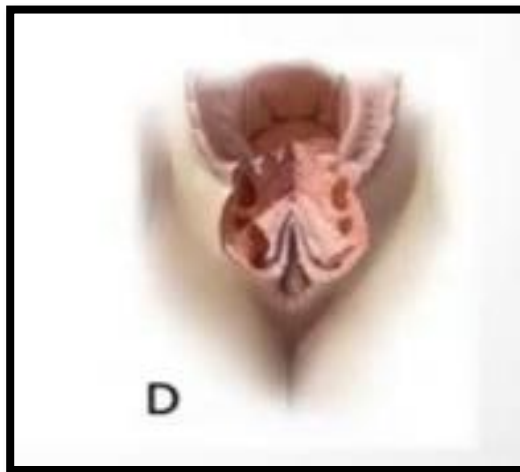
Gambar 5.3 Derajat II Rupture Perineum

3. Derajat III dengan batasan mukosa vagina, fourcette posterior, kulit perineum, otot perineum, sampai otot sfingter ani eskternal (C)



Gambar 5.4 Derajat III Rupture Perineum

4. Derajat IV dengan batasan mukosa vagina, fourchette posterior, kulit perineum, otot perineum, otot sfingter ani eskternal, sampai dinding rectum anterior (D)



Gambar 5.5 Derajat IV Rupture Perineum

D. Strategi Pencegahan Laserasi Perineum

Ruptur perineum terjadi karena banyak faktor baik maternal maupun neonatal, antara lainnya yaitu paritas, berat badan bayi, pimpinan persalinan tidak sebagaimana mestinya, perineum yang kaku, esktraksi cunam, ekstraksi vakum, trauma alat dan episiotomy, ruptur perineum terjadi hamper pada semua persalinan pertama dan tidak jarang juga pada persalina selanjutnya. Robekan jalan lahir selalu memberikan perdarahan dalam jumlah yang bervariasi banyaknya. Perdarahan yang berasal dari jalan lahir selalu di evaluasi yaitu sumber dan perdarahan sehingga dapat diatasi.

Dampak yang dapat akibat robekan jalan lahir antara lain perdarahan dan infeksi serta gangguan ketidaknyamanan. Perdarahan hebat dapat terjadi pada ruptur perineum jika tidak ditangani dengan baik, khususnya pada derajat III dan IV. Sedangkan Infeksi dapat dengan mudah terjadi karena lokali dari perineum yang

sering terkontaminasi dengan feses, juga dapat menimbulkan jaringan parut yang menyebabkan ketidaknyamanan.

Untuk itu diperlukan pencegahan untuk dapat menurunkan angka kejadian ruptur perineum. Hasil penelitian diperoleh 51,6% ibu bersalin tidak mengalami ruptur karena rutin senam hamil dengan hasil analisis p value 0,011 dimana terdapat hubungan senam hamil dengan kejadian rupture perineum. (6). Dari hasil analisis literature dari sepuluh jurnal diperoleh secara keseluruhan menyatakan bahwa pijat perineum efektif dalam mencegah robekan perineum dengan durasi pijat 10 menit dilakukan 1 kali sehari secara rutin sejak usia kehamilan 36 minggu hingga inpartu kala I (7).

Menurut penelitian Clasarari dan Dahliana (8) terdapat pengaruh kegel exercise dan tehnik birthing ball terhadap robekan jalan lahir pada ibu bersalin. Terdapat 80% ibu yang melakukan latihan birthingball dan kegel exercise tidak terdapat robekan perineum saat proses persalinan berlangsung. Dari beberapa hasil penelitian diatas dapat ditarik kesimpulan, pencegahan dalam kejadian robekan perineum ini sangat diperlukan, guna menurunkan angka rupture perineum. Beberapa tehnik yang akan dibahas antara lain : Pijat Perineum, Senam Hamil (Kegel Exercise), dan Latihan Birth Ball.

1. Pijat Perineum

a. Pengertian

Pijat perineum adalah tehnik pemijatan yang dilakukan pada perineum dimulai pada usia kehamilan 3 minggu guna melembutkan jaringan ikat, melancarkan peredaran darah, dan meningkatkan elastisitas perineum. Waktu yang diperlukan untuk pemijatan bisa 5 sampai 10 menit setiap kali pemijatan.

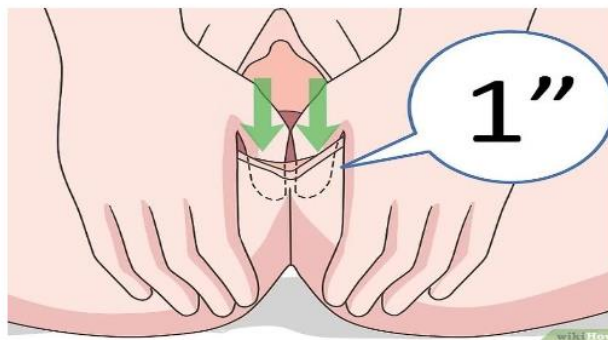
b. Tujuan Pijat Perineum

- 1) Mempersiapkan jaringan perineum dengan baik untuk proses peregangan selama proses persalinan serta akan mengurangi robekan perineum
- 2) Melancarkan aliran darah di daerah perineum dan vagina, serta aliran hormone yang membantu melemaskan otot – otot dasar panggul sehingga proses persalinan jadi lebih mudah
- 3) Menstimulasi aliran darah ke perineum yang akan membantu mempercepat proses penyembuhan setelah melahirkan
- 4) Membantu otot – otot perineum dan vagina elastic sehingga memperkecil risiko perobekan dan episiotomy
- 5) Membantu menyiapkan mental ibu terhadap tekanan dan regangan perineum dikala kepala bayi akan keluar

c. Cara Melakukan Pijat Perineum

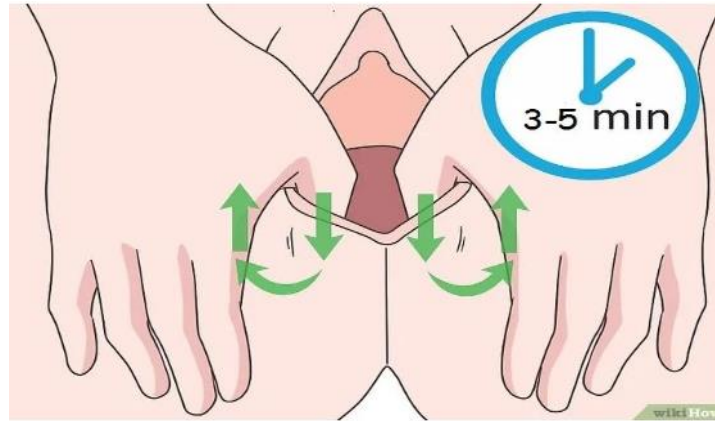
- 1) Cuci tangan terlebih dahulu, pastikan kuku jari pendek

- 2) Posisikan klien yang paling nyaman, bisa duduk, berbaring atau berdiri dengan satu kursi diatas kursi.
- 3) Sebelum pijat bisa menambah kompres air hangat untuk membantu relaksasi otot perineum
- 4) Oleskan minyak vitamin E, baby oil, atau minyak zaitun untuk membantu melicinkan tangan dan mengurangi nyeri saat pemijatan.
- 5) Letakkan satu atau dua jari ibu jari (atau jari lainnya bila ibu tidak sampai) sekitar 2-3 cm didalam vagina dengan posisi ditekuk, sementara jari lainnya berada diluar perineum. Tekan ke bawah dan kemudian menyamping pada saat bersamaan. Perlahan –lahan regangkan daerah yang ditekan sampai ibu merasakan sensasi seperti terbakar, perik atau tersengat



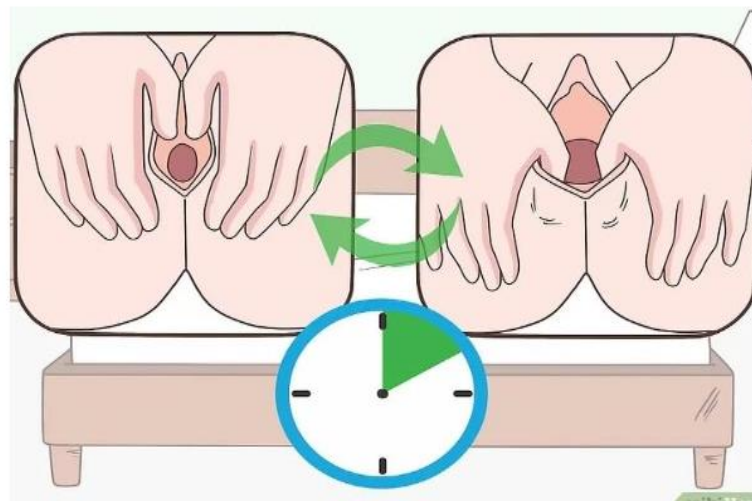
Gambar 5.6 Langkah I Pijat Perineum

- 6) Tahan ibu jari dalam posisi seperti di atas, selama 2 menit sampai daerah tersebut menjadi tidak terlalu beres dan ibu tidak terlalu merasakan perih lagi. Pijatan tidak boleh terlalu keras karena dapat mengakibatkan pengembangan pada jaringan perineum.
- 7) Tetap tekan daerah tersebut dengan ibu jari. Perlahan – lahan pijat ke depan dan ke belakang melewati sepuh terbawah vagina. Lakukan ini selama 3 - 5 menit. Hindari pembukaan saluran kemih karena dapat mengakibatkan iritasi, kemudian ibu dapat mulai melakukan pijatan ringan dan semakin ditingkatkan tekanannya seiring dengan sensitivitas yang berkurang.



Gambar 5.7 Langkah II Pijat Perineum

- 8) Lakukan pemijatan ke arah luar perineum dengan gerakan seperti proses kepala bayi pada say akan lahir.



Gambar 5.8 Langkah III Pijat Perineum

- 9) Tarik perlahan bagian terbawah dari vagina dengan ibu jari tetap berada didalam. Hal ini akan membantu meregangkan kulit pada saat kepala bayi lahir dan akan meregangkan aadalah perineum itu sendiri.
- 10) Setelah ibu selesai melakukan pemijatan, kompres hangat jaringan perineum selama 10 menit. Lakukan secara perlahan dan hati hati. Kompres hangat ini akan sangat meningkatkan sirkulasi darah, sehingga otot di daerah perineum kendur (tidak berkontraksi atau tegang) (Lestari, 2019).

2. Senam Hamil (Kegel Exercise)

a. Pengertian

Otot – otot dasar panggul adalah kelompok penting dari otot jauh didalam panggul. Mereka mendukung organ panggul dan membantu organ panggul dan membantu anda mengontrol kandung kemih dan usus. Latihan kegel penting untuk ibu hamil dan pemulihan setelah kelahiran bayi (King et al, 2019).

Senam kegel adalah latihan dasar panggul yang dilakukan dengan tujuan untuk memperkuat otot-otot penopang rahim, kandung kemih, dan usus. Selain itu senam kegel juga bisa bermanfaat membantu memperkuat otot – otot vagina (Asiyah dkk, 2023).

b. Tujuan

- 1) Membantu memperlancar proses persalinan
- 2) Mengontrol otot – otot dasar panggul selama persalinan
- 3) Mencegah terjadinya dasar panggul selama persalinan
- 4) Mempercepat penyembuhan luka perineum
- 5) Meredakan gangguan kesehatan pada ibu hamil
- 6) Mengoptimalkan proses pemulihan vagina pascapersalinan

c. Cara melakukan Kegel Exercise ada beberapa gerakan :

1) *Slow Hold*

- a) Duduk atau berbaring dengan nyaman dengan kedua kaki terbuka lebar. Pejamkan mata dan bayangkan bunda menahan diri untuk tidak buang air kecil
- b) Kencangkan otot di sekitar saluran depan (vagina) dan bagian belakang (anus) dengan kuat mungkin dan pegang erat – erat selama tiga detik. Dengan melakukan ini, bunda harus merasakan otot dasar panggul terangkat kedalam. Santai setidaknya selama lima detik.
- c) Ulangi gerakan 10 kali, tahan selama tiga hingga lima detik atau selama 10 sampai 15 detik jika bunda mampu, kemudian lepas.
- d) Istirahatlah selama satu menit sebelum melanjutkan latihan berikutnya.

2) *Quick Squeeze*

- a) Kencangkan dan angkat otot dasar panggul sekuat dan secepat mungkin
- b) Secara bertahap tingkatkan kecepatan setiap kontraksi, biarkan istirahat tiga detik diantara setiap latihan.
- c) Ulangi 10 kali, lakukan ini beberapa kali sehari.

3) *Squeeze And Hold*

- a) Kencangkan otot – otot dasar panggul dan tahan selama lima hitungan lambat untuk memulai, bekerja sesuai keinginan hingga 10 kali.
- b) Santai dan istirahat selama 10 detik
- c) Ulangi lima sampai 10 kali, lakukan ini beberapa kali sehari

4) *Elevator Exercise*

- a) Visualisasikan bagian tengah tubuh sebagai menara apartemen. Dengan menggunakan otot dasar panggul, gambarkan keatas lantai pertama dan tahan selama lima detik.
- b) Sambil terus menahan, tarik keatas lantai dua dan tahan selama lima detik

- c) Lepaskan dan ulangi beberapa kali per hari. Duduk diatas bantal, bola akan membantu meningkatkan kemampuan bunda untuk berkontraksi.
- 5) *Belly Botton Breathing*
 - a) Dengan menggunakan diafragma, tarik napas melalui hidung.
 - b) Buang napas melalui mulut sambil mengucapkan HA HA HA
 - c) Lakukan satu hingga tiga set dengan 10 repetisi
- 6) *Baby Hugs*
 - a) Duduk dengan punggung ditopang, gunakan perut melintang untuk bungkus bayi atau bantal ibu dan peluk dia
 - b) Beri bayi atau bantal pelukan yang lebih erat, lalu peluk yang lebih erat
 - c) Lakukan satu hingga tiga set dengan 10 repetisi
- 7) *Squat Combo*
 - a) Ibu memegang benda tetap, seperti tiang atau kursi yang kokoh
 - b) Kemudian berdiri dengan kaki lebih jauh dari lebar kursi
 - c) Turunkan tubuh bunda ke posisi yang dalam, pertahankan berat badan diatas tumit bunda, jika tumit tidak menyentuh lantai, letakkan handuk dibawahnya.
 - d) Lakukan kegel lalu tarik perut bunda saat mengeluarkan napas
 - e) Ulangi kombo ini sebanyak lima kali.

3. Latihan *Birth Ball*

Menurut Suryani dan Hardika (9) penggunaan birthing ball terbukti efektif efektifitas untuk memperpedek durasi kala persalinan, dimana intensitas nyeri saat durasi persalinan yang pendek.

a. Pengertian

Bola Swiss, yang dikenal sebagai birth ball di bangsal persalinan normal, pertama kali diperkenalkan pada tahun 1963 untuk tujuan perawatan perkembangan saraf. Birth ball atau disebut juga bola bersalin merupakan bola yang digunakan untuk melakukan gerakan gerakan yang bermanfaat dalam persiapan proses persalinan. Latihan birthing ball ini diterapkan pada ibu mulai kehamilan 30 minggu dengan memenuhi syarat syarat yang ditentukan oleh provider. Gerakan pada latihan birthing ball ini menggabungkan goyang dan gerakan olah raga dengan berbagai macam gerakan (9). Birth ball meski sederhana akan tetapi berguna dalam praktik bersalin salah satunya untuk menurunkan nyeri dan mencegah robekan perineum.

b. Tujuan

Tujuan berlatih birthing ball menurut Kustari dalam Raidati adalah sebagai berikut:

- 1) Membuat rileks otot dan ligamentum dengan memperkuat otot perut dan punggung bagian bawah
 - 2) Mempercepat proses penurunan kepala janin ke dasar panggul dan menjadikan otot dasar panggul menjadi elastis dan lentur
 - 3) Membuat dasar panggul bermanuver dan membuat luas sisi kanan kirinya ada yang meluaskan sisi depan dan belakang dan bisa mengurangi tekanan ditulang ekor
 - 4) Memposisikan janin ke posisi sempurna menghadapi persalinan
 - 5) Membuat ibu merasakan kenyamanan serta membantu kemajuan proses persalinan dan menurunkan intensitas nyeri pada ibu bersalin
 - 6) Mempersingkat kala I persalinan dengan menurunkan efek negative pada ibu dan janin
 - 7) Menyembuhkan masalah pada tulang dan syaraf
 - 8) Menurunkan angka kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin
 - 9) Membantu mengurangi tekanan kandung kemih dan pembuluh darah.
- c. Peralatan yang perlu dipersiapkan
- 1) Pakaian olah raga yang nyaman
 - 2) Minum air putih
 - 3) Matras olah raga (yoga hamil) jika diperlukan
 - 4) Handuk kecil
 - 5) Kursi/Meja
 - 6) Birth Ball dengan ukuran sesuai tinggi badan ibu
 - (a) Diameter 65 cm untuk tinggi < 155 cm
 - (b) Diameter 75 cm untuk tinggi badan > 155 cm
- d. Gerakan Gerakan dalam latih Birthing ball antara lain:
- 1) Bouncing
Duduk diatas birth ball sambil gerakan mantul mantulkan badan. Pastikan posisi tubuh aman, bisa dengan berpegangan pada benda disekitar yang kuat. Manfaat gerakan ini untuk meluaskan bagian sacrum atau tulang ekor, dengan minimal 20 kali.
 - 2) Pervic Circle/ocking
Duduk diatas birth ball dengan memutar bagian panggul minimal 20 kali dari sisi kanan dan sebaliknya, dengan manfaat melatih otot panggul serta membuat ruang untuk janin, serta mempercepat penurunan kepala.
 - 3) Angka 8
Duduk diatas birth ball dengan menggerakkan panggul dengan posisi membentuk angka 8, dengan manfaat mengurangi nyeri panggul, pinggang,

dan punggung. Gerakan ini juga bermanfaat untuk mengoptimalkan posisi janin.

4) Pelvic Tilt

Duduk diatas birth ball sambil melakukan gerakan kedepan dan kebelakang minimal 20 kali.

5) Side to Side

Duduk diatas birth ball sambil melakukan gerakan pinggul kesamping kiri dan kanan dengan tangan diangkat diatas dengan 20 kali gerakan.

6) Infinity

Gerakan seperti Angka 8 dengan gerakan terbaik minimal 20 kali gerakan.

7) Hip Circle

Peluk birth ball, buka kaki dan lutut sejajar pinggul dan buat gerakan memutar dipinggul membuat nyaman didaerah pinggul bisa dilakukan sampai menjelang proses persalinan.

8) Cat n Cow

Peluk birth ball, buka kaki dan lutu sejajar pinggul dan buat gerakan naik turun panggul minimal 20 kali

e. Metode latihan atau gerakan yang lain dengan menggunakan birthing ball antara lain:

1) Ibu Hamil duduk diatas bola

Posisi duduk diatas bola mempermudah ibu hamil untuk melakukan gerakan rotasi diatas bola. Gerakan ini bermanfaat menjaga agar otot di sekitar panggul terbuka dan perineum lentur sehingga mempermudah proses persalinan. Pada saat persalinan kala I, posisi ini mempermudah pendamping persalinan memberikan sentuhan pada daerah tulang panggul ibu bersalin. Gerakan dapat dilakukan dengan cara melakukan gerakan rotasi, ke kanan, dan kiri, serta maju mundur dalam waktu 10 menit

2) Berdiri bersandar pada bola

Posisi bersandar diatas bola yang diletakkan diatas kursi atau meja yang memberikan kenyamanan pada ibu bersalin dalam melakukan gerakan, mengayun dengan lembut, dan memberikan perasaan rileks. Gerakan dapat dilakukan dengan cara melakukan gerakan rotasi, ke kiri dan ke kanan serta maju mundur dalam waktu 10 menit.

3) Berlutut dan bersandar diatas bola

Posisi berlutut dan bersandar diatas bola memberikan kenyamanan pada ibu pada daerah punggung dan sekitar panggul. Gerakan dapat dilakukan dengan cara melakukan gerakan rotasi, ke kanan dan kiri, serta maju mundur dalam waktu 10 menit

4) Jongkok bersandar pada bola

Bola diletakkan menempel pada tembok atau papan sandaran, sedangkan Ibu duduk dilantai dengan posisi jongkok dan membelakangi sambil nyandar pada bola, sambil melakukan tarikan nafas selama 5-10 menit

E. Simpulan

Persalinan merupakan proses yang natural, akan tetapi proses ini dapat dianggap titik balik wanita. Dimana proses persalinan akan menjadikan sebuah peristiwa penting bagi wanita karena dapat menghadirkan buah hati di dunia ini, yaitu mahluk kecil dengan nyawa dari Tuhan yang mempunyai arti luar biasa dalam hidup seorang wanita. Proses persalinan ini akan membawa kenangan bagi ibu selama masa hidupnya. Proses ini biasanya terbagi dalam dua lini, yaitu kebahagiaan dan trauma. Proses kehamilan selama Sembilan bulan lebih, dengan banyak ketidaknyamanan dan proses persalinan yang lekat dengan image mengerikan akan membawa ceritanya masing masing ibu. Sebagai seorang provider kita sebagai sahabat ibu tentunya ingin memberikan asuhan sayang ibu sebaik mungkin dalam pelayanan. Salah satu ketakutan ibu bersalin adalah adanya perlukaan perineum. Tidak dapat dihindari, perlukaan perineum akan terjadi baik secara alami maupun buatan. Seiring perkembangan teknologi dan penelitian tentunya berkembang pula tehnik asuhan dalam pelayanan yang harus kita berikan. Salah satu yang dapat kita lakukan adalah memberikan asuhan sesuai dengan evidence base kebidanan. Sudah banyak penelitian yang menyebutkan beberapa strategi dalam mengurangi bahkan mencegah terjadinya rupture perineum ini. Dalam pembahasan ini kami menjabarkan beberapa strategi menurunkan kejadian rupture perineum yaitu dengan: senam hamil (kegel exercise), pijat perineum, dan latihan birth ball. Besar harapan penulis dapat dikembangkan dengan tehnik lain.

F. Referensi

- (Indriyani et al, 2024). Hubungan senam hamil, berat badan baru lahir dan lama persalinan terhadap kejadian ruptur perineum pada ibu bersalin di Puskesmas Cibiuk Kabupaten Garut Tahun 2023. *Sentri : Jurnal Riset Ilmu* Vol. 3, No. 5 Mei 2024. <https://ejournal.nusantaraglobal.ac.id/index.php/sentri/article/view/2728> DOI <https://doi.org/10.55681/sentri.v3i5.2728>
- Amdadi, 2022. Pengaruh Senam Hamil dengan Kejadian Rupture Perineum di Puskesmas Minasaupa Makasar. Vol. 2 No. 11 <https://ejournal.stpmataram.ac.id/JIP/article/view/1421> DOI DOI: <https://doi.org/10.47492/jip.v2i11.1421>

- Begley et al, 2019. Active versus expectant management for women in the third stage of labour. <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30754073/>. doi: 10.1002/14651858.CD007412.pub5.
- Clasarari dan Dahliana (2022). PENGARUH KEGEL EXERCISE DAN TEKNIK BIRTH BALL TERHADAP ROBEKAN JALAN LAHIR PADA IBU BERSALIN. Vol. 13 No. 1 2022 <https://ejr.umku.ac.id/index.php/jikk/article/view/1282> DOI: <https://doi.org/10.26751/jikk.v13i1.1282>
- Gustini, et al. 2024. Buku Saku Pijat Perineum. Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia. Tasikmalaya. 2024. ISBN. 978-623-8750-20-7
- Hau, W. L. et al (2012) "The Use of Birth Ball as a Method of Pain Management in Labour, Hkjgom, 12 (1), pp 1-6
- Lumy, et al (2022). Pijat Perineum Efektif Mencegah Robekan Perineum pada Ibu Hamil Trimester III sampai Inpartu Kala I : Literatur Review. GHIDZA : Jurnal Gizi dan kesehatan. Vo. 6 Issue 2. DOI : <https://doi.org/10.22487/ghidza.v6i2.585>
- Mutoharoh, S., Indrayani, E. and Kusumastuti, K. (2020) 'Pengaruh Latihan Birthball terhadap Proses Persalinan', Jurnal Ilmiah Kesehatan, 13(1). Doi : 10.48144/jiks.v13i1.220
- Raidanti, D dan Mujiyanti, C. (2021). Birthing Ball (Alternatif dalam mengurangi nyeri persalinan). AHLIMEDIA PRESS. 2021. ISBN: 978-623-6351-47-5
- Saifuddin A, 2013. Panduan Praktis Pelayanan Kesehatan Maternal dan Neonatal. EGC. 2013
- Suryani dan Hardika, 2020. The Effectiveness Of Birthing Ball Therapy On The Duration Of The First Stage Of Labor And The Intensity Of Labor Pain In Primigravid Mothers Giving Births. SJK Strada Vo. 9 No. 2 2020. <https://www.sjk.org/index.php/sjk/article/view/404>. DOI : 10.30994/sjk.v9i2.404
- World Health Organization (WHO, 2020). Maternal Mortality. Diakses 25 Januari 2025. <http://www.who.int/healthinfo/statistic/indmaternalmortality/en/>.

CHAPTER 6

DOKUMENTASI DAN EVALUASI ASUHAN PERSALINAN

Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb.

A. Pendahuluan/Prolog

Persalinan yaitu proses pengeluaran hasil konsepsi yang sudah cukup bulan atau dapat hidup di luar kandungan dengan lahir spontan maupun dengan bantuan dokter atau tanpa bantuan. Persalinan suatu proses fisiologis yang dialami wanita pada akhir kehamilannya, proses ini dimulai dari adanya kontraksi persalinan yang ditandai dari perubahan serviks dan diakhiri dengan pengeluaran plasenta (Yulizawati, Insani, Sinta, & Andriani, 2019).

Persalinan adalah proses keluarnya janin yang sudah cukup bulan, plasenta, dan selaput ketuban dari rahim ibu melalui jalan lahir atau operasi caesar. Proses persalinan merupakan tahap akhir dari kehamilan yang melibatkan kontraksi rahim untuk mendorong bayi keluar ke dunia. Persalinan yang normal berlangsung dengan prosedur yang relatif alami, tetapi ada kalanya membutuhkan intervensi medis untuk mengatasi komplikasi yang mungkin terjadi (Zikriyana & Zahara, 2022).

Dalam pengertian sehari-hari persalinan sering diartikan serangkaian kejadian pengeluaran bayi yang sudah cukup bulan, disusul dengan pengeluaran plasenta dan selaput janin dari tubuh ibu melalui jalan lahir atau melalui jalan lain, berlangsung dengan bantuan atau tanpa bantuan (kekuatan ibu sendiri). Tindakan mengeluarkan hasil konsepsi yang layak-janin dan uri-melalui jalan lahir atau bukaan lain ke dunia luar dikenal sebagai persalinan. Persalinan normal dan persalinan sesar merupakan dua bentuk persalinan (Indah, Firdayanti, & Nadyah, 2019). Menurut (Iswanti et al., 2024) Persalinan adalah saat di mana bayi, plasenta, dan selaput ketuban keluar dari rahim ibu. Persalinan dianggap normal jika terjadi pada masa kehamilan yang sudah mencukupi, yaitu antara 37 hingga 42 minggu, tanpa adanya komplikasi.

Ada indikator persalinan bagi seseorang yang akan memasuki masapersalinan. Tiga indikator persalinan yang tercantum dalam Kurniawan A.(2016): adanya lendir berdarah, kontraksi rahim, dan penipisan dan pembukaan leher rahim. Tahapan I, II, III, dan IV merupakan empat fase yang dialami seorang wanita saat melahirkan (Yuliani, 2020).

Seorang bidan harus mempunyai kompetensi dalam memberikan pelayanan selama persalinan. Guna mempertahankan tingkat keselamatan dan mutu pelayanan

yang ideal, tujuan asuhan kebidanan pada masa nifas adalah memaksimalkan kelangsungan hidup dan mencapai derajat kesehatan yang tinggi baik bagi ibu maupun anak melalui berbagai upaya yang terpadu, komprehensif dan intervensi yang minimal (Suparti & Nur Fauziah, 2021).

Kebidanan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan bidan dalam memberikan pelayanan kebidanan kepada perempuan selama masa sebelum hamil, masa kehamilan, persalinan, pascapersalinan, masa nifas, bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah, termasuk kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana sesuai dengan tugas dan wewenangnya (Iswanti et al., 2024).

B. Dokumentasi Asuhan Persalinan

1. Definisi

Dokumentasi Asuhan persalinan merupakan bentuk catatan dari asuhan kebidanan yang dilaksanakan pada ibu dalam masa intranatal, yakni pada kala I sampai dengan kala IV. Pendokumentasian meliputi pengkajian, pembuatan diagnosis kebidanan, pengidentifikasian masalah terhadap tindakan segera dan melakukan kolaborasi dengan dokter atau tenaga kesehatan lain serta menyusun asuhan kebidanan dengan tepat dan rasional berdasarkan keputusan yang dibuat pada langkah sebelumnya (Indah et al., 2019).

Pendokumentasian adalah bagian penting dari proses membuat keputusan klinik karena memungkinkan penolong persalinan untuk terus menerus memperhatikan asuhan yang diberikan selama proses persalinan dan kelahiran bayi (Warina & Hamang, 2023). Partograf adalah bagian terpenting dari proses pendokumentasian selama persalinan. Pendokumentasian dilakukan karena:

- a. Sebagai alat bantu untuk membuat keputusan klinik dan mengevaluasi kesesuaian dan keefektifan asuhan atau perawatan, mengidentifikasi kesenjangan pada asuhan yang diberikan dan untuk membuat perubahan dan peningkatan pada rencana asuhan atau perawatan
- b. Sebagai tolak ukur keberhasilan dalam proses membuat keputusan klinik
- c. Sebagai catatan permanen tentang asuhan, perawatan dan obat yang diberikan
- d. Dapat dibagikan di antara para penolong persalinan sehingga lebih dari satu penolong persalinan akan memberikan perhatian dan asuhan pada ibu atau bayi baru lahir
- e. Dapat mempermudah kelangsungan asuhan dari satu kunjungan ke kunjungan berikutnya, dari satu penolong persalinan ke penolong persalinan lainnya, atau dari seorang penolong persalinan ke fasilitas kesehatan lainnya.
- f. Dapat digunakan untuk penelitian atau studi kasus

- g. Diperlukan untuk memberi masukan data statistik nasional dan daerah, termasuk catatan kematian dan kesakitan ibu atau bayi baru lahir

Aspek-aspek penting dalam pendokumentasian antara lain :

- a. Tanggal dan waktu asuhan diberikan
- b. Identifikasi penolong persalinan
- c. Paraf atau tanda tangan (dari penolong persalinan) pada semua catatan
- d. Mencakup informasi yang berkaitan secara tepat, dicatat dengan jelas dan dapat dibaca
- e. Suatu sistem untuk memelihara catatan pasien sehingga selalu siap tersedia
- f. Kerahasiaan dokumen-dokumen medis

2. Tujuan dan Fungsi Dokumentasi

Adapun tujuan dokumentasi kebidanan menurut (Surtinah, Sulikah, & Nuryani, 2019) adalah sebagai sarana komunikasi. Komunikasi terjadi dalam tiga arah sebagai berikut.

- a. Ke bawah untuk melakukan instruksi.
- b. Ke atas untuk member laporan.
- c. Ke samping (lateral) untuk member saran.

Dokumentasi yang dikomunikasikan secara akurat dan lengkap dapat berguna untuk beberapa hal berikut ini:

- a. Membantu koordinasi asuhan kebidanan yang diberikan oleh tim kesehatan.
 - 1) Mencegah informasi yang berulang terhadap pasien atau anggota tim kesehatan atau mencegah tumpang tindih, atau tindakan yang mungkin tidak dilakukan untuk mengurangi kesalahan dan meningkatkan ketelitian dalam memberikan asuhan kebidanan pada pasien.
 - 2) Membantu tim bidan dalam menggunakan waktu sebaik-baiknya karena dengan pendokumentasian, bidan tidak banyak menghabiskan waktu untuk berkomunikasi secara oral. Contoh: Seorang bidan melakukan pencatatan asuhan kebidanan yang telah dilaksanakannya sehingga bidan lain dapat mengetahui asuhan kebidanan tersebut dari catatan.
- b. Sebagai tanggung jawab dan tanggung gugat.

Bidan diharuskan mencatat segala tindakan yang dilakukan terhadap pasien sebagai upaya untuk melindungi pasien terhadap kualitas pelayanan kebidanan yang diterima dan perlindungan terhadap keamanan bidan dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini penting berkaitan dengan langkah antisipasi terhadap ketidakpuasan pasien terhadap pelayanan yang diberikan dan kaitannya dengan aspek hukum yang dapat dijadikan settle concern, artinya dokumentasi dapat digunakan untuk menjawab ketidakpuasan terhadap pelayanan yang diterima secara hukum.

c. Sebagai informasi statistik.

Data statistik dari dokumentasi kebidanan dapat membantu merencanakan kebutuhan di masa mendatang, baik SDM, sarana, prasarana, dan teknis. Penting kiranya untuk terus menerus memberi informasi kepada orang tentang apa yang telah, sedang, dan akan dilakukan, serta segala perubahan dalam pekerjaan yang telah ditetapkan.

d. Sebagai sarana pendidikan.

Dokumentasi asuhan kebidanan yang dilaksanakan secara baik dan benar akan membantu para siswa kebidanan maupun siswa kesehatan lainnya dalam proses belajar mengajar untuk mendapatkan pengetahuan dan membandingkannya, baik teori maupun praktik lapangan

e. Sebagai sumber data penelitian.

Informasi yang ditulis dalam dokumentasi dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Hal ini erat kaitannya dengan yang dilakukan terhadap asuhan kebidanan yang diberikan, sehingga melalui penelitian dapat diciptakan satu bentuk pelayanan keperawatan dan kebidanan yang aman, efektif, dan etis.

f. Sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan.

Melalui dokumentasi yang dilakukan dengan baik dan benar, diharapkan asuhan kebidanan yang berkualitas dapat dicapai, karena jaminan kualitas merupakan bagian dari program pengembangan pelayanan kesehatan. Suatu perbaikan tidak dapat diwujudkan tanpa dokumentasi yang kontinu, akurat, dan rutin baik yang dilakukan oleh bidan maupun tenaga kesehatan lainnya. Audit jaminan kualitas membantu untuk menetapkan suatu akreditasi pelayanan kebidanan dalam mencapai standar yang telah ditetapkan.

g. Sebagai sumber data asuhan kebidanan berkelanjutan.

Dengan dokumentasi akan didapatkan data yang aktual dan konsisten mencakup seluruh asuhan kebidanan yang dilakukan.

h. Untuk menetapkan prosedur dan standar.

Prosedur menentukan rangkaian kegiatan yang akan dilaksanakan, sedangkan standar menentukan aturan yang akan dianut dalam menjalankan prosedur tersebut.

i. Untuk mencatat.

Dokumentasi akan diperlukan untuk memonitor kinerja peralatan, sistem, dan sumber daya manusia. Dari dokumentasi ini, manajemen dapat memutuskan atau menilai apakah departemen tersebut memenuhi atau mencapai tujuannya dalam skala waktu dan batasan sumber dayanya. Selain itu manajemen dapat mengukur kualitas pekerjaan, yaitu apakah outputnya sesuai dengan spesifikasi dan standar yang telah ditetapkan.

- j. Untuk memberi instruksi.

Dokumentasi yang baik akan membantu dalam pelatihan untuk tujuan penanganan instalasi baru atau untuk tujuan promosi (Surtinah et al., 2019).

3. Prinsip-prinsip Teknik Pendokumentasian

Beberapa prinsip teknik pendokumentasian yaitu:

- a. Mencantumkan nama jelas pasien pada setiap lembar observasi atau pemeriksaan.
- b. Menulis dengan tinta hitam (tidak boleh pakai pensil), supaya tidak terhapus dan bila perlu foto copy akan lebih jelas.
- c. Menuliskan tanggal, jam, pemeriksaan, tindakan atau observasi yang dilakukan sesuai dengan temuan yang obyektif (kenyataan) dan bukan interpretasi (hindari kata penilaian seperti tampaknya, rupanya).
- d. Tuliskan nama jelas pada setiap pesanan, hasil observasi dan pemeriksaan oleh orang yang melakukan.
- e. Hasil temuan digambarkan secara jelas termasuk posisi, kondisi, tanda, gejala, warna, jumlah dan besar dengan ukuran yang lazim dipakai. Memakai singkatan atau simbol yang sudah di sepakati, misalnya KU, Ket +, KPD, Let kep, Let Su, S/N, T dan lain-lain
- f. Interpretasi data objektif harus di dukung oleh observasi.
- g. Kolom tidak dibiarkan kosong tetapi dibuat tanda penutup. Misalnya dengan garis atau tanda silang.
- h. Bila ada kesalahan menulis, tidak diperkenankan menghapus, (ditutup, atau ditipex), tetapi dicoret dengan garis dan membubuhkan paraf disampingnya (Handayani & Mulyati, 2017).

Teknik penulisan dalam dokumentasi asuhan kebidanan pada ibu bersalin dengan Tujuh langkah varney antara lain sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan data

Data yang dikumpulkan pada ibu bersalin adalah sebagai berikut: biodata, data demografi, riwayat kesehatan termasuk faktor herediter, riwayat menstruasi, riwayat obstetri dan ginekologi, termasuk nifas dan laktasi, riwayat biopsikososiospiritual, pengetahuan, data pemeriksaan fisik, pemeriksaan khusus dan penunjang seperti laboratorium, radiologi dan USG.

- b. Melakukan interpretasi data dasar

Tahap ini dilakukan dengan melakukan interpretasi data dasar terhadap kemungkinan diagnosis yang akan ditegakkan dalam batas diagnosis kebidanan intranatal

Contoh:

Diagnosis : G2P1A0 hamil 39 minggu inpartu kala I fase aktif

Masalah: Wanita dengan kehamilan tidak diinginkan (KTD) atau takut menghadapi persalinan

- c. Melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial dan mengantisipasi penanganannya.

Langkah ini dilakukan dengan mengidentifikasi masalah kemudian merumuskan diagnosis potensial berdasarkan diagnosis masalah yang sudah teridentifikasi pada masa intranatal.

Contoh: Ibu A di ruang bersalin dengan pembesaran uterus yang berlebihan, Bidan harus mempertimbangkan kemungkinan penyebab pembesaran uterus Yang berlebihan seperti adanya hidramnion, makrosomi, kehamilan ganda, ibu diabetes, atau lainnya, sehingga beberapa diagnosis dan masalah potensial dapat

teridentifikasi sekaligus mempersiapkan penanganannya.

- d. Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera atau masalah potensial

Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi dan melakukan konsultasi secara kolaborasi dengan tim kesehatan lain berdasarkan kondisi pasien. Sebagai contoh: ditemukan adanya perdarahan antepartum, adanya distosia bahu atau bayi dengan APGAR Score rendah. Maka tindakan segera yang dilakukan adalah tindakan sesuai dengan standar profesi bidan dan apabila perlu tindakan kolaboratif seperti preeklampsia berat maka harus segera dikolaborasi ke dokter spesialis obgyn.

- e. Menyusun rencana asuhan secara menyeluruh

Rencana asuhan yang dilakukan secara menyeluruh adalah berdasarkan hasil identifikasi masalah dan diagnosis serta dari kebutuhan pasien.

1) Kala I yaitu dimulai dari his persalinan yang pertama sampai pembukaan serviks menjadi lengkap:

a) Bantulah ibu dalam masa persalinan jika ia tampak gelisah, ketakutan dan kesakitan. Dengan cara:

- Memberikan dukungan dan motivasi
- Memberikan informasi mengenai proses dan kemajuan persalinan
- Mendengarkan keluhan-keluhannya dan mencoba lebih sensitif terhadap perasaannya

b) Jika ibu tampak merasa kesakitan, dukungan atau asuhan yang dapat diberikan antara lain:

- Melakukan perubahan posisi, yaitu posisi sesuai dengan keinginan ibu. Namun jika ibu ingin beristirahat di tempat tidur, anjurkan agar posisi tidur miring ke kiri.

- Sarankan suami atau keluarganya untuk memijat dan menggosok punggungnya diantara dua kontraksi
 - Ajarkan kepada ibu teknik bernafas dengan cara meminta ibu menarik nafas panjang, menahan nafasnya sebentar lalu kemudian dilepaskan dengan cara meniup udara keluar sewaktu terasa kontraksi
- c) Penolong tetap menjaga privasi ibu dalam persalinan dengan menggunakan penutup atau tirai dan tidak menghadirkan orang lain tanpa pengetahuan dan seizin ibu.
 - d) Menjelaskan kemajuan persalinan dan perubahan yang terjadi secara prosedural yang akan dilaksanakan dan hasil pemeriksaan.
 - e) Memperbolehkan ibu untuk mandi dan membasuh sekitar kemaluannya setelah buang air besar atau buang air kecil.
 - f) Ibu bersalin biasanya merasa panas dan banyak mengeluarkan keringat, maka gunakan kipas angin atau AC dalam kamar atau menggunakan kipas biasa dan menganjurkan ibu untuk mandi sebelumnya.
 - g) Untuk memenuhi kebutuhan cairan tubuh dan mencegah dehidrasi, berikan ibu cukup minum.
 - h) Lakukan pemantauan tekanan darah, suhu, denyut jantung janin, kointraksi dan pembukaan serviks. Sedangkan pemeriksaan dalam sebaiknya dilakukan selama empat jam selama kala I persalinan atau jika ada indikasi lain. Kemudian dokumentasikan hasil temuan dengan partograf (Handayani & Mulyati, 2017).
- 2) Kala II yaitu dimulai dari pembukaan lengkap sampai lahirnya bayi.
- a) Memberikan dukungan terus menerus kepada ibu dengan mendampingi ibu agar merasa nyaman dengan menawarkan minum atau memijat ibu
 - b) Menjaga kebersihan ibu agar terhindar dari infeksi. Bila terdapat darah lendir atau air ketuban segera dibersihkan
 - c) Memberikan dukungan mental untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan ibu dengan cara menjaga privasi ibu, menjelaskan proses dan kemajuan persalinan, menjelaskan tentang prosedur yang akan dilakukan dan keterlibatan ibu.
 - d) Mengatur posisi ibu dan membimbing ibu untuk meneran dengan posisi yang nyaman seperti jongkok, setengah duduk, tidur miring atau menungging.
 - e) Mengatur posisi agar nyeri berkurang, mudah meneran, menjaga kandung kemih tetap kosong, menganjurkan berkemih sesering mungkin, memberikan cukup minum untuk memberi tenaga dan mencegah dehidrasi (Handayani & Mulyati, 2017).

- 3) Kala III yaitu dimulai dari lahirnya bayi sampai lahirnya plasenta
 - a) Melaksanakan Manajemen Aktif Kala III meliputi pemberian oksitosin dengan segera, pengendalian tarikan pada tali pusat dan pemijatan uterus segera setelah plasenta lahir
 - b) Jika menggunakan Manajemen Aktif Kala III dan plasenta belum lahir dalam waktu 15 menit, berikan oksitosin 10 unit (intramuskular)
 - c) Jika menggunakan manajemen aktif kala III dan plasenta belum lahir juga dalam waktu 30 menit, periksa kandung kemih dan lakukan kateterisasi, periksa adanya pelepasan plasenta, berikan oksitosin 10 unit (intramuskular) dosis ketiga, dan periksa ibu dengan seksama dan jahit semua robekan pada servik dan vagina kemudian perbaiki episiotomi (Handayani & Mulyati, 2017).
- 4) Kala IV yaitu dimulai dari plasenta lahir sampai 2 jam postpartum.
 - a) Periksa fundus uteri setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 20-30 menit pada jam kedua. Jika kontraksi tidak kuat lakukan masase uterus sampai uterus berkontraksi
 - b) Periksa tekanan darah, nadi, kandung kemih, perdarahan, setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua.
 - c) Anjurkan ibu untuk minum agar mencegah dehidrasi. Tawarkan ibu makanan dan minuman yang disukainya.
 - d) Bersihkan perineum ibu dan kenakan pakaian yang bersih dan kering
 - e) Biarkan bayi berada pada ibu untuk meningkatkan hubungan ibu dan bayi, sebagai permulaan dengan menyusui bayi karena menyusui dapat membantu uterus berkontraksi.
 - f) Melaksanakan perencanaan
Tahap ini dilakukan dengan melaksanakan rencana asuhan kebidanan menyeluruh yang dibatasi oleh standar asuhan kebidanan pada masa intranatal.
 - g) Evaluasi
Evaluasi pada masa intranatal dapat dilakukan setelah melakukan perencanaan dan pelaksanaan (Handayani & Mulyati, 2017).

4. Dokumentasi Asuhan Persalinan:

- a. Identitas Pasien
 - Nama, umur, alamat, dan nomor rekam medis.
 - Riwayat kesehatan dan obstetri.
- b. Data Anamnesis
 - Riwayat kehamilan, termasuk komplikasi yang terjadi.

- Keluhan saat ini dan tanda-tanda persalinan.
- c. Pemeriksaan Fisik
 - Tanda-tanda vital (nadi, tekanan darah, suhu).
 - Pemeriksaan abdomen dan posisi janin.
- d. Proses Persalinan
 - Waktu dan cara persalinan (normal atau caesar).
 - Tahapan persalinan (dilatasi, ekspulsi, dan plasenta).
- e. Intervensi yang Dilakukan
 - Penggunaan obat-obatan, epidural, atau intervensi lainnya.
 - Penanganan komplikasi jika ada.
- f. Kondisi Ibu dan Bayi
 - Penilaian Apgar bayi setelah lahir.
 - Kondisi ibu setelah persalinan (perdarahan, pemulihan).
- g. Pendidikan dan Konseling
 - Informasi yang diberikan kepada ibu tentang perawatan diri dan bayi.

C. Tujuan dan Fungsi Dokumentasi

Setiap catatan harus memberikan informasi penting yang berpotensi memandu profesional kesehatan lain dalam mentransfer asuhan, seperti yang mungkin terjadi dalam rujukan yang berorientasi masalah, rujukan keperawatan dokter untuk kondisi beresiko tinggi, atau lintas pengurusan cakupan yang sederhana antar bidan (Aning, 2017).

Dokumentasi adalah kunci memvalidasi asuhan yang berkualitas, keterampilan dokumentasi menjadi sangat penting dalam praktik kebidanan. Pendokumentasian merupakan suatu bukti pelayanan kesehatan yang berisi kegiatan pencatatan, pelaporan yang otentik dan penyimpanan semua kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan klien yang dapat dipergunakan untuk mengungkapkan suatu fakta aktual dan dapat dipertanggungjawabkan (Handayani & Mulyati, 2017).

Pencacatan klinis menjadi dokumen yang sangat berguna bagi bidan maupun pasien yang menerima pelayanan. Pendokumentasian dapat membantu bidan menjaga informasi dasar secara tertulis yang diperlukan dalam lingkungan praktek, namun pendokumentasian yang akurat dalam lingkungan pelayanan kesehatan harus terkait dengan konsep praktik yang berbasis bukti, objektif, dan tidak memihak (Aning, 2017).

Semua bidan harus meningkatkan kewaspadaan diri yang terkait dengan pendokumentasian asuhan yang mereka berikan kepada para pasien mereka, terlepas seberapa banyak pasien mereka. Dokumentasi asuhan kebidanan tersebut harus mencerminkan esensi dari kebidanan: asuhan yang berorientasi pada

perempuan yang difokuskan pada keunggulan dalam proses memberikan asuhan dengan perhatian terhadap hasil (Surtinah et al., 2019).

Salah satu format catatan yang dapat menjadi dokumentasi kebidanan adalah format catatan S-O-A-P yang tertuang dalam KepMenKes 938 tentang standar asuhan kebidanan, yakni pada standar VI. Catatan S-O-A-P adalah metode dokumentasi paling umum yang digunakan oleh penyedia kesehatan, termasuk bidan, untuk memasukkan catatan ke rekam medis pasien. Catatan ini memungkinkan penyedia kesehatan untuk merekam dan berbagi informasi dalam format universal, sistematis, dan mudah dibaca (Aning, 2017). Penggunaan catatan S-O-A-P memberikan banyak manfaat dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah dapat membantu bidan untuk mengatur proses berpikir yang terlibat dalam asuhan pasien. Dengan berpikir secara terorganisasi, bidan dapat secara lebih baik membuat keputusan tentang asuhan pasien (Zikriyana & Zahara, 2022).

Menurut hukum jika sesuatu tidak didokumentasikan berarti pihak yang bertanggung jawab tidak melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Jika bidan tidak melaksanakan atau menyelesaikan suatu aktivitas atau mendokumentasikan secara tidak benar, dia bisa dituntut melakukan malpraktik. Dokumentasi kebidanan harus dapat dipercaya secara legal (Handayani & Mulyati, 2017).

Metode pendokumentasian yang dilakukan dalam asuhan kebidanan adalah SOAP, yang merupakan salah satu pendokumentasian yang ada. SOAP adalah catatan yang bersifat sederhana, jelas, logis dan tertulis. SOAP sebagai suatu metode pendokumentasian asuhan kebidanan, metode ini disarikan dari proses pemikiran penatalaksanaan kebidanan. Dipakai untuk mendokumentasikan hasil asuhan klien dalam rekam medis klien sebagai catatan perkembangan/kemajuan (progress note) yaitu:

1. Subyektif (S)

Subyektif yaitu menggambarkan pendokumentasian hasil pengumpulan data klien melalui anamnesa sebagai langkah 1 Varney. Data subyektif yang dikumpulkan adalah sebagai berikut:

- a. Biodata (Kalau tidak ANC)
- b. Keluhan utama

2. Obyektif (O)

Obyektif yaitu menggambarkan pendokumentasian hasil pemeriksaan fisik klien, laboratorium dan tes diagnosis lain yang dirumuskan dalam data fokus yang mendukung asuhan, sebagai langkah 1 Varney.

3. Assessment (A)

Assesment yaitu menggambarkan pendokumentasian hasil analisa dan interpetasi data subjektif dan objektif dalam suatu identifikasi atau masalah potensial, sebagai langkah 2, 3 dan 4 Varney.

4. Planing (P)

Merupakan rencana dari tindakan yang akan diberikan termasuk asuhan mandiri, kolaborasi tes diagnosis atau laboratorium, serta konseling untuk tindak lanjut. sebagai langkah 5, 6, dan 7 Varney (Handayani & Mulyati, 2017).

Tabel 6.1 Langkah proses manajemen dan pendokumentasian kebidanan:

NO	7 Langkah Varney	SOAP
1	Mengumpulkan data	Subjektif objektif
2	Melakukan Interpetasi data dasar	Assessment
3	Melakukan identifikasi diagnosis atau masalah potensial	
4	Menetapkan kebutuhan terhadap tindakan segera atau masalah potensial	
5	Menyusun rencana asuhan secara menyeluruh	Planning
6	Melaksanakan perencanaan	
7	Evaluasi	

Contoh kasus dengan pendokumentasian SOAP pada asuhan persalinan:

Kasus:

Ny. A datang ke BPS pukul 10.00 WIB dengan keluhan mulas sejak pukul 02.00 WIB, keluar lendir darah satu jam yang lalu. ibu mengaku ini kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran. Riwayat haid terakhir tanggal 15 september 2014. Tanda-tanda vital dalam batas normal

ASUHAN KEBIDANAN PADA IBU BERSALIN KALA I

Tanggal : 22-06-2015
Pukul : 10.00 WIB

S :

- Ny. A mengatakan mulas sejak pukul 02.00 WIB dan keluar lendir darah pukul 10.00 WIB
- Ibu mengatakan ini kehamilan kedua dan tidak pernah keguguran
- HPHT= 15-09-2014, TP= 22-06-2015

O : Ku= baik

Kes = compos mentis

TTV.

TD= 110/80 MmHg

RR= 20x/menit

N = 80x/menit

S = 360C

TFU= 32 cm

DJJ = puki, 140x/menit

His = 3x 10'40"

Pemeriksaan dalam.

Dinding vagina= tidak ada kelainan

Pembukaan = 5 cm

Portio = tipis lunak

ketuban = positif

presentasi = kepala

penurunan = Hodge II

posisi = belum teraba.

Pemeriksaan ekstremitas didapatkan hasil oedema (-), varises (-).

A :

G2P1A0 hamil 40 minggu inpartu kala I fase aktif Janin tunggal hidup intrauterine presentasi kepala

P :

- Menginformasikan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan pada ibu dan janin dan anjurkan ibu dan keluarga mengisi informed consent
- Memantau keadaan ibu dan mengobservasi keadaan umum, tanda-tanda vital. Keadaan janin dengan mengobservasi denyut jantung janin, observasi his, dengan menggunakan partograf.
- Mengajarkan ibu mengurangi rasa sakit yang timbul saat his dan cara mengedan yang baik
- Menganjurkan ibu untuk makan dan minum

- Menyiapkan ruangan, alat dan obat-obatan.
- Mendokumentasikan seluruh hasil pemeriksaan

H. Evaluasi Asuhan Persalinan

Evaluasi Asuhan Persalinan adalah proses penilaian terhadap tindakan atau layanan yang diberikan kepada ibu hamil dan bayi selama proses persalinan. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua langkah yang diambil selama persalinan sesuai dengan standar medis yang berlaku dan memberikan hasil yang terbaik untuk ibu dan bayi (Annisa, 2022).

Evaluasi Asuhan Persalinan meliputi beberapa aspek, seperti:

1. Proses Persalinan: Menilai apakah persalinan berjalan dengan lancar atau ada komplikasi yang memerlukan intervensi medis.
2. Tindakan Medis: Memastikan bahwa tindakan medis, seperti penggunaan obat-obatan, pembedahan (seperti caesar), atau prosedur lainnya dilakukan dengan tepat.
3. Pemantauan Kondisi Ibu dan Bayi: Memastikan ibu dan bayi dalam kondisi baik, seperti memantau tanda vital ibu (tekanan darah, detak jantung, suhu tubuh) dan kesehatan bayi (misalnya, skor APGAR).
4. Keterampilan Tenaga Kesehatan: Mengevaluasi keterampilan dan kompetensi tenaga medis yang terlibat dalam asuhan persalinan, seperti bidan, dokter, atau perawat.
5. Pencegahan Komplikasi: Memastikan bahwa langkah-langkah untuk mencegah komplikasi seperti perdarahan, infeksi, atau gangguan lainnya dilakukan dengan benar (Indah et al., 2019).

Tujuan dari evaluasi adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan, mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan, dan memastikan keselamatan ibu dan bayi selama persalinan. Evaluasi pada Asuhan Persalinan mencakup beberapa aspek penting untuk memastikan kualitas pelayanan yang diberikan kepada ibu dan bayi selama proses persalinan.

I. Simpulan

Persalinan adalah proses keluarnya janin yang sudah cukup bulan, plasenta, dan selaput ketuban dari rahim ibu melalui jalan lahir atau operasi caesar. Proses persalinan merupakan tahap akhir dari kehamilan yang melibatkan kontraksi rahim untuk mendorong bayi keluar ke dunia. Asuhan persalinan adalah serangkaian tindakan atau perawatan yang diberikan kepada ibu hamil menjelang, selama, dan

setelah proses persalinan, dengan tujuan untuk memastikan keselamatan ibu dan bayi serta memperhatikan kenyamanan ibu. Asuhan persalinan melibatkan pengelolaan fisik, psikologis, dan sosial selama proses kelahiran, serta pemantauan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi potensi komplikasi dan memberikan penanganan yang tepat. Dokumentasi kebidanan sangat penting bagi bidan dalam memberikan asuhan kebidanan. Hal ini karena asuhan kebidanan yang diberikan kepada klien membutuhkan pencatatan dan pelaporan yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menuntut tanggung jawab dan tanggung gugat dari berbagai permasalahan yang mungkin dialami oleh klien berkaitan dengan pelayanan yang diberikan. Bidan wajib mendokumentasikan seluruh temuan dan keputusan klinik yang diberikan sebagai bentuk pertanggung jawaban dan tanggung gugat bidan atas asuhan kebidanan yang dilakukan.

J. Contol Soal Dan Pembahasan:

1. Apa yang dimaksud Dokumentasi Asuhan Kebidanan?
 - a. Persalinan normal yang didokumentasikan pada kala 2
 - b. Dokumentasi asuhan persalinan normal merupakan bentuk catatan dari asuhan kebidanan yang dilakukan pada ibu dalam masa intranatal
 - c. Merupakan dokumentasi kehamilan
 - d. Merupakan tindakan bidan terhadap pasien

Jawaban: b. Dokumentasi asuhan persalinan normal merupakan bentuk catatan dari asuhan kebidanan yang dilakukan pada ibu dalam masa intranata

Pembahasan: Dokumentasi Asuhan persalinan merupakan bentuk catatan dari asuhan kebidanan yang dilaksanakan pada ibu dalam masa intranatal, yakni pada kala I sampai dengan kala IV. Pendokumentasian meliputi pengkajian, pembuatan diagnosis kebidanan

2. Apa yang harus dicatat dalam pendokumentasian hasil asuhan pada kala I persalinan?
 - a. Memberikan dukungan mental untuk mengurangi kecemasan dan ketakutan ibu dengan cara menjaga privasi ibu.
 - b. Menginformasikan hasil pemeriksaan yang dilakukan pada ibu dan janin.
 - c. Mengatur posisi Ibu yang nyaman
 - d. Dalam pendokumentasian hasil asuhan kala I, harus dicatat data subyektif seperti keluhan ibu, serta data obyektif seperti keadaan umum, tanda vital, pemeriksaan kebidanan, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Selain itu, harus ada analisis (Assessment) dan rencana tindakan (Planning) yang jelas.

Jawaban: d. Dalam pendokumentasian hasil asuhan kala I, harus dicatat data subyektif seperti keluhan ibu, serta data obyektif seperti keadaan umum,

tanda vital, pemeriksaan kebidanan, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Selain itu, harus ada analisis (Assessment) dan rencana tindakan (Planning) yang jelas.

Pembahasan:

Dalam pendokumentasian hasil asuhan kala I, harus dicatat data subyektif seperti keluhan ibu, serta data obyektif seperti keadaan umum, tanda vital, pemeriksaan kebidanan, dan hasil pemeriksaan laboratorium. Selain itu, harus ada analisis (Assessment) dan rencana tindakan (Planning) yang jelas.

3. Apa saja aspek-aspek penting yang harus diperhatikan dalam pendokumentasian asuhan kebidanan?
 - a. Melaksanakan Manajemen Aktif Kala III meliputi pemberian oksitosin dengan segera, pengendalian tarikan pada tali pusat dan masase uterus segera setelah plasenta lahir.
 - b. Memantau keadaan ibu dan mengobservasi keadaan umum, tanda-tanda vital. Keadaan janin dengan mengobservasi denyut jantung janin, observasi his, dengan menggunakan partograf.
 - c. Melakukan observasi Kala IV setiap 15 menit pada jam pertama dan setiap 30 menit pada jam kedua. Jika kontraksi tidak kuat lakukan masase uterus sampai uterus berkontraksi
 - d. Aspek penting dalam pendokumentasian meliputi tanggal dan waktu asuhan, identifikasi penolong persalinan, paraf atau tanda tangan, informasi yang jelas dan dapat dibaca, sistem pemeliharaan catatan, dan kerahasiaan dokumen medis.

Jawaban: d. Aspek penting dalam pendokumentasian meliputi tanggal dan waktu asuhan, identifikasi penolong persalinan, paraf atau tanda tangan, informasi yang jelas dan dapat dibaca, sistem pemeliharaan catatan, dan kerahasiaan dokumen medis.

Pembahasan

Pendokumentasian adalah bagian penting dari proses membuat keputusan klinik karena memungkinkan penolong persalinan untuk terus menerus memperhatikan asuhan yang diberikan selama proses persalinan dan kelahiran bayi.

4. Pernyataan mana yang benar mengenai dokumentasi asuhan persalinan setelah proses persalinan selesai?
 - a. Hanya perlu mencatat komplikasi yang terjadi selama persalinan
 - b. Dokumentasi hanya perlu dilakukan jika ada masalah serius
 - c. Dokumentasi harus mencatat semua detail penting dari proses persalinan
 - d. Dokumentasi tidak penting jika kondisi pasien stabil

Jawaban: c. Dokumentasi harus mencatat semua detail penting dari proses persalinan

Pembahasan: Dokumentasi harus mencatat semua detail penting, termasuk prosedur, pengobatan, intervensi yang dilakukan, kondisi pasien, dan respons terhadap perawatan. Hal ini penting untuk referensi di masa mendatang dan untuk kualitas pelayanan kesehatan.

5. Apa tujuan utama dari dokumentasi asuhan persalinan?

- a. Memastikan bahwa pasien mendapatkan pelayanan sesuai dengan standar
- b. Mencatat semua tindakan medis yang dilakukan selama proses persalinan
- c. Memberikan informasi yang berguna bagi tim medis untuk perawatan selanjutnya
- d. Semua jawaban benar

Jawaban: d. Semua jawaban benar

Pembahasan: Dokumentasi asuhan persalinan bertujuan untuk memastikan pelayanan diberikan sesuai standar, mencatat tindakan medis, dan menyediakan informasi yang diperlukan untuk evaluasi serta perawatan lebih lanjut bagi ibu dan bayi.

K. Referensi

- Aning, S. (2017). Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan. In *Buku Ajar Dafis Kebidanan*. Jakarta: Fakultas Kedokteran dan Kesehatan Universitas Muhammadiyah Jakarta.
- Annisa, N. H. (2022). *Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan* (1st ed.). Purbalingga: CV EUREKA MEDIA AKSARA.
- Handayani, S. R., & Mulyati, T. S. (2017). *Dokumentasi Kebidanan* (Tahun 2017). Jakarta: Kementerian Kesehatan RI.
- Indah, I., Firdayanti, F., & Nadyah, N. (2019). Manajemen Asuhan Kebidanan Intranatal Pada Ny "N" dengan Usia Kehamilan Preterm di RSUD Syekh Yusuf Gowa Tanggal 01 Juli 2018. *Jurnal Midwifery*, 1(1), 1–14.
- Iswanti, T., Anggraeni, I. E., Yulianti, N. T., Afriyani, L., Margiyanti, N. J., Sayuti, ... Untari, S. (2024). Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir. In *Nuansa Fajar Cemerlang* (1st ed.). Jakarta: Nuansa Fajar Cemerlang.
- Suparti, S., & Nur Fauziah, A. (2021). Determinan Kepatuhan Bidan Dalam Melaksanakan Standar Asuhan Persalinan Normal. *Jurnal Kebidanan Indonesia*, 12(2), 99–110.
- Surtinah, N., Sulikah, & Nuryani. (2019). *Buku Ajar Dokumentasi Kebidanan* (T. Herlina, ed.). Surabaya: Prodi Kebidanan Magetan Poltekkes Kemenkes Surabaya.
- Warina, F. B., & Hamang, S. H. (2023). Asuhan Kebidanan Persalinan Normal pada Ny.

- F. *Window of Midwifery Journal*, 04(02), 119–128.
- Yuliani, I. (2020). Documentation of Childbirth Care as Legal Protection for Midwives' Independent Practices. *Jurnal Hukum Kesehatan*, 4(2), 319–336.
- Yulizawati, Insani, A. A., Sinta, L. El, & Andriani, F. (2019). Buku Ajar Asuhan Kebidanan Pada Persalinan. In *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. Sidoarjo: Indomedia Pustaka.
- Zikriyana, I., & Zahara, E. (2022). Studi Kasus: Asuhan Kebidanan Persalinan Grande Multipara. *Jurnal Medika : Karya Ilmiah Kesehatan*, 7(2), 29.

PROFIL PENULIS



Rolita Efriani, S.ST., M.Keb., Lahir di Kelutum, Bengkulu Selatan, Agustus tahun 1993. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII pada Program Studi Kebidanan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2014, DIV pada Program Studi Kebidanan, Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan di Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta dan lulus tahun 2019. Riwayat pekerjaan sebagai Dosen Kebidanan Poltekkes Kemenkes Bengkulu sekaligus sebagai PJ SPMI Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2020. Saat ini penulis bekerja di Poltekkes Kemenkes Bengkulu dan mengampu mata kuliah Asuhan Kebidanan Kehamilan, Asuhan Kebidanan Persalinan dan Bayi Baru Lahir, Asuhan Kebidanan Pasca Persalinan dan Menyusui, Pengantar Praktik Kebidanan, Evidence Based dalam Praktik Kebidanan, Ilmu Kesehatan Keluarga, Komunikasi Efektif dalam Praktik Kebidanan, Kesehatan Perempuan dan Perencanaan Keluarga, Promosi Kesehatan dan Pendidikan Budaya Anti Korupsi. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi. Penulis juga aktif sebagai penulis buku serta jurnal ilmiah. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: efrianirolita@gmail.com dan efrianirolita@poltekkesbengkulu.ac.id

Motto: "Tanamkan dalam diri untuk terus belajar karena ilmu adalah harta yang tidak akan pernah habis dan investasi berharga untuk masa depan".



Bdn. Melly Damayanti, SST., M.Keb., Lahir di Bukittinggi, 15 Agustus 1985. Penulis merupakan Dosen Poltekkes Kemenkes Tanjungpinang dan telah mengabdikan sejak tahun 2009. Penulis menyelesaikan Program Diploma III Kebidanan di Poltekkes Kemenkes Padang pada tahun 2006. Gelar Sarjana Sains Terapan dan Magister Kebidanan telah didapatkan penulis di Universitas Padjadjaran, Bandung pada tahun 2008 dan 2017. Penulis juga menyelesaikan Pendidikan Profesi Bidan di Poltekkes Kemenkes Jambi pada tahun 2023. Penulis aktif melaksanakan kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi untuk meningkatkan kualitas sebagai seorang dosen. Beberapa penelitian dan kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan didanai oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan telah menghasilkan beberapa produk dan inovasi yang telah mendapatkan sertifikat HAKI. Penulis juga berkontribusi dalam penyusunan beberapa buku ajar, buku referensi, buku monograf dan lainnya. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: apriyandimelly@gmail.com

PROFIL PENULIS



Putri Yuniartis, S.Tr.Keb., M.Keb., Lahir di Jakarta, 10 Juni 1989. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang DIII Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta III tahun 2008, DIV Bidan Pendidik Universitas Nasional tahun 2016. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2023. Saat ini penulis aktif bekerja di Prodi DIII Kebidanan Poltekkes Kemenkes Jakarta I, juga sebagai praktisi kebidanan dan konselor laktasi. Dengan pengalaman lebih dari 16 tahun di bidang kebidanan, penulis terus berupaya memberikan kontribusi nyata dalam peningkatan derajat kesehatan ibu dan anak melalui pendidikan, praktik kebidanan, serta penelitian. Melalui karya ilmiah dan berbagai publikasi, penulis berharap dapat berbagi ilmu dan pengalaman kepada para tenaga kesehatan, mahasiswa, serta masyarakat luas. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: p.yuniartis@gmail.com.



Umu Qonitun, SST., M.Keb., MM., Penulis lahir di Lamongan pada tanggal 25 Agustus. Merupakan staf dosen tetap Kebidanan di Institut Ilmu Kesehatan Nahdlatul Ulama Tuban sejak tahun 2008, aktif dalam melaksanakan tri darma perguruan tinggi baik sebagai pengajar, menulis buku, melakukan penelitian dan pengabdian. Riwayat pendidikan lulus pendidikan S2 Manajemen di STIE Mahardika Surabaya pada Tahun 2012, Pendidikan S2 Kebidanan di Universitas Brawijaya pada tahun 2016. pendidikan program D-III Kebidanan di Akbid NU Tuban pada tahun 2006 dan Program D-IV bidan pendidik pada tahun 2008 di Poltekkes Kemenkes Yogyakarta. Selain aktif sebagai pengajar, saat ini juga aktif sebagai Ketua Program Studi yang sebelumnya aktif sebagai ketua LPPM dan koordinator kurikulum di prodi D-III kebidanan, pengelola jurnal IJMR (International Journal Of Midwifery Research), sebagai editor dan reviewer pada beberapa jurnal nasional, tim LEPK IIK NU Tuban. Pemenang hibah penelitian nasional dari kemristek dikti pada tahun 2019, Beberapa buku yang sudah diterbitkan antara lain Asuhan Kebidanan kegawatdaruratan maternal dan neonatal terbit pada tahun 2017, Buku ajar pelayanan kontrasepsi terbit pada tahun 2018, pelayanan keluarga berencana terbit pada tahun 2022. Email : hafizh.hak@gmail.com

PROFIL PENULIS



Bdn. Lilis Suryani, SST., M.Keb., Lahir di Madiun, 09 September 1987. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang S1 pada Program Studi Terapan Kebidanan, STIKes Karya Husada Kediri Lulus tahun 2009. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 pada Universitas AISYIYAH Yogyakarta dan lulus tahun pada tahun 2016. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2009 di Pelayanan sampai Tahun 2010. Kemudian masuk dunia pendidikan di Akademi Kebidanan Muhammadiyah Madiun tahun 2010 sampai 2020. Saat ini penulis bekerja di STIKes Husada Jombang mengampu mata kuliah Obstetri, Kegawatdaruratan Maternal Neonatal, Kebidanan Komplementer. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku, publikasi, pembicara seminar, dan memiliki outlet enterpreuner Kebidanan yaitu Griya Sehat Bunda Madiun dengan pelayanan holistic care. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: Lsuryani784@gmail.com



Anisah Tifani Maulidyanti, S.Tr.Keb., M.Keb., Lahir di Bengkulu, 19 Agustus 1994. Pendidikan tinggi yang telah ditempuh oleh penulis yaitu jenjang D4 pada Program Studi Kebidanan Program Sarjana Terapan, Poltekkes Kemenkes Bengkulu tahun 2018. Kemudian melanjutkan pendidikan S2 Kebidanan pada Universitas Padjadjaran dan lulus pada tahun 2022. Riwayat pekerjaan diawali pada tahun 2019-2022 sebagai Teknis Akademik dan Evaluasi D4 Kebidanan Alih Jenjang di Poltekkes Kemenkes Bengkulu. Saat ini penulis bekerja sebagai Dosen di STIKes

Tri Mandiri Sakti Bengkulu mengampu mata kuliah Etika dan Hukum Kesehatan, Midwifery Disaster, Ilmu Kesehatan Masyarakat, dan Asuhan Kebidanan Pada Persalinan dan BBL. Penulis aktif dalam berbagai kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu sebagai penulis buku dan penelitian. Penulis mendapat hibah penelitian Kemenristekdikti tahun 2024 skema PDP Afirmasi. Penulis dapat dihubungi melalui e-mail: anisahbidan23@gmail.com.

Motto: "Don't Be A Follower, Be A Story Maker"

Buku *Bunga Rampai: Persalinan Normal – Praktik dan Tantangan* merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang menggambarkan kompleksitas dan dinamika dalam proses persalinan normal. Disusun oleh para akademisi dan praktisi kebidanan, buku ini hadir sebagai panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan persalinan yang aman, holistik, dan berbasis bukti.

Isi buku mencakup enam topik utama yang relevan dengan kebutuhan praktik di lapangan. Dimulai dengan pembahasan aspek psikologis dalam persalinan normal, buku ini menyoroti pentingnya kesiapan mental ibu dalam menghadapi proses melahirkan. Selanjutnya, dibahas peran bidan dalam mendukung persalinan tanpa rasa sakit, yang menjadi pilar penting dalam meningkatkan kenyamanan dan pengalaman positif ibu selama proses persalinan.

Topik penanganan distosia bahu, sebagai salah satu komplikasi yang menantang dalam persalinan normal, dijabarkan secara praktis untuk memperkuat kapasitas respons tenaga kesehatan. Tak kalah penting, optimalisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dikupas sebagai upaya membangun ikatan awal ibu dan bayi serta mendukung keberhasilan menyusui.

Dalam bab strategi pencegahan laserasi perineum, buku ini menyajikan pendekatan preventif dan teknik yang dapat diterapkan di berbagai kondisi praktik kebidanan. Terakhir, dibahas pula pentingnya dokumentasi dan evaluasi asuhan persalinan sebagai bagian dari standar pelayanan profesional dan alat refleksi mutu asuhan.

Dengan pendekatan teoritis yang berpadu dengan pengalaman praktik, buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di Indonesia. Cocok digunakan sebagai referensi akademik maupun panduan lapangan, buku ini merupakan kontribusi nyata dalam mendukung persalinan yang lebih humanis, aman, dan bermartabat

Buku Bunga Rampai: Persalinan Normal – Praktik dan Tantangan merupakan kumpulan tulisan ilmiah yang menggambarkan kompleksitas dan dinamika dalam proses persalinan normal. Disusun oleh para akademisi dan praktisi kebidanan, buku ini hadir sebagai panduan komprehensif bagi tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan persalinan yang aman, holistik, dan berbasis bukti.

Isi buku mencakup enam topik utama yang relevan dengan kebutuhan praktik di lapangan. Dimulai dengan pembahasan aspek psikologis dalam persalinan normal, buku ini menyoroti pentingnya kesiapan mental ibu dalam menghadapi proses melahirkan. Selanjutnya, dibahas peran bidan dalam mendukung persalinan tanpa rasa sakit, yang menjadi pilar penting dalam meningkatkan kenyamanan dan pengalaman positif ibu selama proses persalinan.

Topik penanganan distosia bahu, sebagai salah satu komplikasi yang menantang dalam persalinan normal, dijabarkan secara praktis untuk memperkuat kapasitas respons tenaga kesehatan. Tak kalah penting, optimalisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) dikupas sebagai upaya membangun ikatan awal ibu dan bayi serta mendukung keberhasilan menyusui.

Dalam bab strategi pencegahan laserasi perineum, buku ini menyajikan pendekatan preventif dan teknik yang dapat diterapkan di berbagai kondisi praktik kebidanan. Terakhir, dibahas pula pentingnya dokumentasi dan evaluasi asuhan persalinan sebagai bagian dari standar pelayanan profesional dan alat refleksi mutu asuhan.

Dengan pendekatan teoritis yang berpadu dengan pengalaman praktik, buku ini diharapkan dapat memperkaya wawasan dan meningkatkan kualitas pelayanan kebidanan di Indonesia. Cocok digunakan sebagai referensi akademik maupun panduan lapangan, buku ini merupakan kontribusi nyata dalam mendukung persalinan yang lebih humanis, aman, dan bermartabat

Penerbit:

PT Nuansa Fajar Cemerlang

Grand Slipi Tower Lt. 5 Unit F

Jalan S. Parman Kav. 22-24

Kel. Palmerah, Kec. Palmerah

Jakarta Barat, DKI Jakarta, Indonesia, 11480

Telp: (021) 29866919



ISBN 978-634-7219-05-3

